Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich	F15.2
Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom	F12.2
	F12.3
Psychische und Verhaltensstörungen durch andere Stimulanzien, einschließlich	F15.3
	F33.1
	F43.1
	F60.31

Sehr geehrte Frau Kollegin,
wir berichten über unsere Patientin Frau T., Jenny, geb. am 29.08.1998, Dorfstr. 25 a, 15738 Zeuthen, die sich vom 01.07.2025 bis zum 16.07.2025 in unserer stationären Behandlung befand.
Diagnosen:
Koffein: Abhängigkeitssyndrom
Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom
Koffein: Entzugssyndrom
Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode
Posttraumatische Belastungsstörung
Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ
Aktuelle Anamnese:
Die stationäre Aufnahme der im Haus bekannten Patientin erfolgte auf der Station 2.2 bei Amphetamin-und Cannabisabhängigkeit.
Die Patientin war zuletzt vom 04.06.2025 bis 24.06.2025 in unserer stationären Behandlung.
Nach der Entlassung sei sie einen Woche abstinent gewesen, aber dann am 29.06.2025 sei sie mit 1 g
Cannabis und 1 g Amphetamin rückfällig geworden.
Der letzte Konsum mit Cannabis und Amphetaminen sei gestern abends gewesen.
Die Entzugserscheinungen kenne sie in Form von starkem Schwitzen, Herzrasen, Unruhe, Ameisenlaufen im Gesicht, Taubheitsgefühlen im rechten Arm und linken Bein sowie Gedächtnisproblemen

(hauptsächlich anterograd).

Als Auslöser für den Konsum nannte sie die Einsamkeit und Verzweiflung.
Psychischer Zustand bei Aufnahme: Bei der Aufnahme sahen wir eine orientierte, traurig wirkende und schläfrige Patientin.
Sie distanziert sich aktuell glaubhaft von Suizidalität, offenbart jedoch, dass sie in der Vergangenheit mehrere suizidale Episoden versucht hatte.
Sie bleibt freiwillig in der Behandlung.
Aktuelle soziale Belastungsfaktoren:
Einsamkeit und Verzweiflung
Aktuelle somatische Beschwerden / Symptomatik:
Intermitterende Taubheitsgefühl im rechten rechten Arm und im linken Bein.
Intermitterende krampfartige und ziehende Unterbauch Schmerzen
Psychiatrische Anamnese:
Posttraumatische Belastungsstörung als Kind.
Borderline (mit 8-9 JA diagnostiziert).
Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode
Eigenanamnese / Somatische Anamnese:
angeborene Herzklappenfehler
2 Sectio caesarea OP's (2016 und 2020).
Soziale Anamnese:
Ledig. Wohne mit ihren Kinder (3) in einer Mietwohnung.
Aktuell beziehe sie Bürgergeld und Pflegegeld. Früher habe sie als Verkäuferin, Reinigungskraft und Küchenhelferin gearbeitet.
Suchtanamnese:
Langjährige Cannabisabhängigkeit.
Amphetaminkonsum: wieder Rückfall vor einer Woche.
Medikation bei Aufnahme:

Medikament	Weg	Dosierung	Erste - letzte Verabreichungen
Carbamazepin Carbamazepin 200mg RET Oral		1 - 0 - 1 Stk	ab 01.07.2025
Chlorprothixen Chlorprothixen HCl 15mg Oral FTA		2 - 2 - 2 Stk	ab 01.07.2025

Chlorprothixen

Chlorprothixen HCl 50mg Oral FTA		0 - 0 - 1 Stk	ab 01.07.2025

Doxazosin			
Doxazosin 1mg TBL	Oral	0 - 0 - 0 - 2 Stk	ab 01.07.2025
Folsäure Folsäure 5mg TBL	Oral	1 - 0 - 0 Stk	ab 02.07.2025

Untersuchungsbefunde:
Allgemeinmedizinisch - Internistischer Befund vom 01.07.2025:
Patientin in reduziertem AZ und EZ, Haut und sichtbare Schleimhäute gut durchblutet, keine kardiopulmonalen
Dekompensationszeichen.
Kopf/Hals:
Rachenring
reizlos, keine
Lymphknotenschwellung, keine Struma. Thorax: Cor: Herztöne rein und rhythmisch.
Pulmo:
Vesikuläratmen, keine RG. Abdomen: Bauchdecken weich und indolent, Leber ist nicht vergrößert, Milz nicht palpierbar. Extremitäten: Frei beweglich, Fußpulse regelrecht.
Neurologischer Befund vom 01.07.2025:
Kein Meningismus. Visus intakt. Pupillen isokor und rund. Prompte, seitengleiche direkte und konsensuelle
Augenbewegungen
Doppelbildwahrnehmungen. Kein Spontan-, kein Blickrichtungsnystagmus. Keine Sensibilitätsstörungen im Gesicht, keine mimischen Paresen. Armhalteversuch und Beinhalteversuch unauffällig, keine Paresen.
Die Kraftentfaltung ist altersentsprechend und seitengleich Tonus und Trophik regelrecht. Keine Pyramidenbahnzeichen. Finger-Nase-Versuch sicher. Romberg sicher. Sensibilität allseits zu allen Qualitäten intakt. Keine vegetativen Störungen. Keine aphasischen oder apraktischen Störungen.
Psychischer / Psychopathologischer Befund vom 01.07.2025:
Im Kontaktverhalten freundlich und unsicher. Wach und bewusstseinsklar. Zu allen Qualitäten vollständig orientiert. Keine inhaltlichen Denkstörungen. Keine Ich-Störungen. Zukunftsängste. Immer wiederkehrende Sorge bez. alltäglicher Situationen und den Verlust von zwei ihr nahestehenden Personen. Keine Zwänge. Stimmung subjektiv gedrückt. Leicht reduzierte affektive
Schwingungsfähigkeit. Antrieb und Interesse jeweils mittelschwer reduziert. Psychomotorisch unauffällig. Keine Suizidgedanken und - intentionen.
Diagnostik:
Endbefund Labor 28 vom 03.07.2025
Auftrag vom 01.07.2025 19:49
Auftragsannahme 01.07.2025 19:49
Status
Urin
Anforderung: Pathogene Keime
Leukozyten im Urin 19
- Keimzahl: < 10.000 KBE/ml über 3 verschiedene Keime, V. a. Kontamination
Ruhe EKG vom 01.07.2025:

Indifferenztyp, Sinusrhythmus, Hinweise auf eine Vorhofbelastung, keine Erregungsrückbildungsstörungen, HF 84 BPM, Qtc-Zeit 400 ms.

ASKLEPIOS
FACHKLINIKUM TEUPITZ

Laborwerte: Bezeichnung	Ref.-Bereich	Einheit	1.7.25 1.7.25 12.7.25 13:05 19:49 07:00
Tramadol			negativ negativ
Status			Endbefun
			d
Drogenscreening-Hinweis			folgt
Kreatinin i. H.	29 - 226	mg/di	75
Cannabinole i. H.		ng/	* positivit
CANNAP		ug/1	>100.0
Amphetamine i. H.		нg/1	* positivtt
AMPHP		нg/1	>5000.0
Status			Endbefun Endbefun
			d d
Leukozyten	3.6 - 11.8	Gpt/l	7.8
Erythrozyten	3.8 - 5.2	Tpt/1	4.05
	7.3 - 9.8	mmoll	7.10
Hk	0.35 - 0.4	1/1	0.35
MCV	84 - 100	fl	85
MCH	1.75 - 2.1	fmol	1.75
MCHC	20 - 22	mmoll	20.5
Thrombozyten	150-370	Gpt/1	340
Lymphozyten	20 - 51	%	20.2
Monozyten	<14	%	8.2
Neutrophile	42 - 75	%	61.2
Eosinophile		%	9.2

Basophile		%	1.2
Lymphozyten absolut 1,0-2,9		Gpt/l	1.6
Neutrophile absolut	1,6-7,1	Gpt/1	4.8
Monozyten absolut	0,2-0,6	Gpt/l	0.6
Eosinphile absolut	0,06-0,46	Gpt/l	0.72
Basophile absolut	<0,08	Gpt/1	0.09
Bilirubin/U			negativ
Urobilinogen/U			normal
Ketonkörper/U			negativ
Glucose/U			normal
Protein/U			negativ
Erythrozyten/U			negativ
	5- 7		7.0
pH-Wert/U Nitrit/U	negativ		negativ

ASKLEPIOS
FACHKLINIKUM TEUPITZ

Bezeichnung
Ref.-Bereich
Einheit
Leukozyten/U spezif. Gewicht/U Calcium
Kalium
Natrium
Creatinin
Glomer.
Filtrationsrate(ber.)
Protein
Bilirubin
ASAT
ALAT
AP
GGT
Glucose im Serum

Lipase
negativ
1.015-1.02
2.10-2.55
3.5-5.1
135-145
50-98
80-140
mmol/l mmol/1
mmol/1
umol/l ml/min
66-83
<21
<0.58
umol/l umol/sl
<0.60
0,80-1,60
umol/sl umol/sl
<0.66
umol/sl
4.1-6.1
mmol/l
<1.32
umol/sl
<2.84
Mmol/sl
CRP
<10
mg/l
TSH
0.27- 4.20
mIU/l
Benzodiazepine
Cocain
Cannabinoide
Methadon
Methamphetamin
Morphin/Opiate
Tricyclische
Anitidepressiva
Amphetamine
Ecstasy
Laborwerte übernommen am: 15.07.2025 09:18
1.7.25 13:05
* +++
1.010
2.26 4.06
141
70

* 93
1.7.25 19:49
12.7.25 07:00
63.44
<15
0.37
0.48
3.36个
4.731
6.531
0.20
1.33
<5
1.76
negativ negativ
* POSITIV
negativ negativ negativ negativ
* POSITIV
negativ
negativ negativ negativ negativ negativ negativ negativ
negativ negativ
Therapie und Verlauf:
Die stationäre Aufnahme der im Haus bekannten Patientin erfolgte auf der Station 2.2 bei Amphetamin-und Cannabisabhängigkeit. Die Patientin erhielt die Möglichkeit, an den angebotenen Therapien (Ergotherapie, Musiktherapie, Aromatherapie, Akupunktur, themenzentrierte Einzel- und Gruppentherapie, Psychoedukation) teilzunehmen sowie die sozialarbeiterische Beratung zu nutzen. Die Behandlung erfolgte freiwillig.
Klinisch entwickelte die Patientin in den Stunden nach Aufnahme ein vegetatives Entzugssyndrom mit Tremor, Hyperhidrosis, Tachykardien und innerer Unruhe, welches wir medikamentös mit Chlorprothixen 30-30-30-80 mg pro Tag behandelten. Darunter waren die Entzugssymptome rückläufig.
Im weiteren Verlauf remittierte die Entzugssymptomatik vollständig. Die Patientin konnte sich schnell in das Stationsleben integrieren und von dem angebotenen Programm profitieren. Sie wurde über die

Möglichkeiten der Nachsorge und Rückfallprävention informiert.
Der Verlauf der Behandlung gestaltete sich komplikationslos. Die Vitalparameter waren im Rahmen regelmäßiger Kontrollen nach Abklingen der Entzugssymptomatik im normalen Bereich. Laborchemisch zeigten sich leicht erniedrigte Proteinwerte sowie erhöhte Werte für alkalische Phosphatase (AP) und Gamma-Glutamyltransferase (GGT). Zudem wurde eine Hyperglykämie festgestellt, sonst

keine relevanten Auffälligkeiten. Der EKG-Befund bei Aufnahme zeigte einen normofrequenten Sinusrhythmus mit Hinweisen auf eine Vorhofbelastung. Erregungsrückbildungsstörungen waren nicht nachweisbar.
Nach erfolgter qualifizierter Entzugsbehandlung entlassen wir Frau T. am 16.07.2025 in die Häuslichkeit und Ihre geschätzte ambulante Weiterbehandlung. Wir klärten die Pat. über die weiteren therapeutischen Möglichkeiten wie Suchtberatungsstellen, ambulante Selbsthilfegruppe, stationäre Krisen- und Entwöhnungstherapien auf. Bei Entlassung bestand weder Suizidalität, noch Eigen- oder Fremdgefährdung. Die Möglichkeit zur Wiederaufnahme zur Krisenintervention bei drohendem Rückfall wurde besprochen.
Im Falle einer Wiederaufnahme bei Zustandsverschlechterung können Sie sich an die Zentrale Aufnahme für Psychiatrie (033766/66-000) wenden.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Entlassmedikation:

Medikament	Weg	Dosierung Erste - letzte Verabreichungen
Carbamazepin		
Carbamazepin 200mg RET Oral Chlorprothixen Chlorprothixen HCl 15mg Oral FTA		1 - 0 - 1 Stk 2 - 2-2 Stk
Chlorprothixen Chlorprothixen HCl 50mg Oral FTA		0 - 0 - 1 Stk
Doxazosin Doxazosin 1mg TBL	Oral	0 - 0 - 0 - 2 Stk
Doxepin Doxepin 25mg FTA	Oral	Bedarfsmedikation : Bei Unruhe und Schlafstörungen 1 Stk je Einnahme Maximum je 24 h: 4 Stk
Folsäure Folsäure 5mg TBL	Oral	1 - 0 - 0 Stk

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Versicherungsnummer
Eingangsstempel der Antrag aufnehmenden Stelle
Deutsche
Rentenversicherung
Eingangsstempel des Rentenversicherungsträgers

Antrag auf Leistungen zur Teilhabe für Versicherte
- Rehabilitationsantrag
G0100
Hinweis: Um sachgerecht über Ihren Antrag entscheiden zu können, benötigen wir aufgrund des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und Neunten Buches Sozialgesetzbuch von Ihnen einige wichtige Informationen und Unterlagen.
Wir möchten Sie deshalb bitten, die gestellten Fragen vollständig zu beantworten und uns die erbetenen Unterlagen möglichst umgehend zu überlassen. Ihre Mithilfe, die in den §§ 60-65 Erstes Buch Sozialgesetzbuch - SGB I ausdrücklich vorgesehen ist, erleichtert uns eine rasche Erledigung Ihrer Angelegenheiten. Bitte bedenken Sie, dass wir Ihnen, wenn Sie uns nicht unterstützen, die Leistung ganz oder teilweise versagen oder entziehen dürfen
(§ 66 SGB I).
Sie können diesen Antrag auch elektronisch auf www.deutsche-rentenversicherung.de/eantrag-g0100 stellen.
Handschriftliche Ergänzungen bitte in Druckschrift in schwarz oder blau
Hat die gesetzliche Krankenkasse, die Agentur für Arbeit oder das Jobcenter schriflich aufgefordert, diesen Antrag zu stellen?
nein
ja, die Krankenkasse
Aufforderungsschreiben bitte in Kopie beifügen!
ja, die Agentur für Arbeit
ja, das Jobcenter
1
Beantragte Leistung

Bitte den Befundbericht (Formular S0051) und die Honorarabrechnung (Formular S0050) beifügen. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation stationär ganztägig ambulant	Bitte Formular G0110 beifügen!
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation bei Abhängigkeitserkrankungen stationär ganztägig ambulant ambulant Kombinationsbehandlungen	Bitte Formular G0110 beifügen!
Leistungen zur onkologischen Rehabilitation stationär ganztägig ambulant	Bitte Formular G0110 (sofern Sie keine Altersrente beziehen) und das Formular S0052 beifügen!
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (Berufliche Rehabilitation)	Bitte Formular G0130 beifügen!
Kraftfahrzeughilfe	Bitte die Formulare G0140 und G0142 beifügen!

Hilfsmittel und technische Arbeitshilfen, die behinderungsbedingt zur Berufsausübung erforderlich sind	Bitte die Formulare G0133 und gegebenenfalls G0134 beifügen!

ehörigen
Asklepios Fachklinikum Teupitz
Sozialdienst/ Station 2.2/ Frau A.Rösner
Buchholzer Str. 21
15755 Teupitz
Tel.: 0337 66 66-565, Fax:- 507
Sozialbericht
- Psychosoziale Grunddaten -
erstellt am
15.07.2024
Versicherungsnummer der Rentenversicherung
Versicherten - Nummer der Krankenkasse
1204925918
Name der Krankenkasse
BARMER Berlin/Brandenburg
Alkohol
2
Medikamente
3
illegale Drogen
2
3
- Sonstiges:
1. Angaben zur Person
Name
T.
Geburtsname
Vorname
Jenny
Familienstand ledig
Geburtsdatum
Geburtsort
Staatsangehörigkeit
29.08.1998
Berlin
Straße, Hausnummer
Dorfstr. 25 a
Postleitzahl
Wohnort
15738

Zeuthen
derzeitiger Aufenthaltsort
AFK Teupitz/ Station 2.2
(erlernter) Beruf
• Niederlassungserlaubnis oder Aufenthaltserlaubnis liegt vor.
Eine Kopie ist beigefügt.
Telefon (mit Vorwahl)
zuletzt ausgeübte Tätigkeit
Angestellte bei der Essensausgabe für Schul 01.01.2024
arbeitslos seit nicht erwerbstätig
seit
Erläuterungen
Erziehungsberechtige / Erziehungsberechtiger, Betreuerin / Betreuer
Name
Anschrift
Erziehungsberechtigte / Erziehungsberechtigter
Betreuerin /Betreuer
Telefon (mit Vorwahl)
Art des Betreuungsverhältnisses
Aktenzeichen
Betreuung eingeleitet am
durch
Behandelnde Ärzte (Name, Fachrichtung, Anschrift, Telefon (mit Vorwahl))
Dr. med. Anne Horlbeck
Frankfurter Allee 70 10247 Berlin
030 2914803
2. Kinder
Anzahl
Alter
Davon im Haushalt lebend
3
8, 7,4
3

3. Wohnsituation und finanzielle Verhältnisse
Ausfüllhinweis: Die Daten sind nur zu erheben, soweit sie für die Rehabilitation erforderlich sind)
- Mietwohnung
- Schulden, an Schuldnerberatung angebunden
- Bürgergeld und Pflegegeld
- Rechtl. Betreuung ist benatragt, noch nicht amtl. bestellt
- Jugendamt ist involviert

4. Vorbehandlung der Abhängigkeitserkrankung

4.1 Entzugsbehandlungen
Gesamtzahl
letzte in (Einrichtung)
4
hiesiges Krankenhaus
4.2 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
Gesamtzahl
von
09.07.2024
bis
0
davon in den letzen 4 Jahren
reguläre
Entlassung
in ambulanter Rehabilitationseinrichtung (Name)
von
bis
ja
n
in stationärer Rehabilitationseinrichtung (Name)
von
bis
ja
Bemerkungen (z.B. zu einer durchgeführten Adaption)
Sonstiges
Suchtberatungsstelle Wildau 2-malig aufgesucht
5. Anamnese der Abhängigkeitserkrankung
5.1 Suchtmittelanamnese
Suchtmittel
Cannabis
Beginn /Dauer seit dem 11 Lbsj.
Dosis, Verlauf und Gewohnheiten
- Konsum schwankend, je nach dem wie das Geld vorhanden war oder wie sehr die Impulskontrollstörung sie bestimmt
- aktuell 4 Gramm, bzw. 14 Joints /täglich Suchtmittel
Crystal Meth
Beginn /Dauer
mit 12 Jahren Beginn vor 8-9 Jahren aufgehört
Dosis, Verlauf und Gewohnheiten
- aus finanziellen Gründen aufgehört
- sie habe sich 3 Jahre lang prostituiert, um sich den "nächsten Schuß leisten zu können".
- im Zuge dessen habe sie auch ein Kind verloren
- Verwandte und Bekannte haben sie von dem weiteren Konsum abgehalten
Suchtmittel
Beginn /Dauer
-Ibuprofen, Ibuflam, Blutverdünner
vor 2 Jahren Beginn bis zum 06.07.2024
Dosis, Verlauf und Gewohnheiten

- 40-50 Tabletten/ tägl. Ibuprofen oder Ibuflam
- Blutverdünner: je nach dem, wie sehr sie sich belastet gefühlt habe; 2-3 Tabletten bis zu 50 Stück

5.2 Körperliche und psychische Auffälligkeiten in der Vorgeschichte (Krampfanfälle, Delir, Psychose, Suizidversuche u.a.)

- Posttraumatische Belastungsstörung als Kind.
- Borderline (mit 8-9 JA diagnostiziert).
- Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode
- Taubheitsgefühlt in vereinzelten Gliedmaßen
- Unterleib-/ Bauchschmerzen
- hört regelmäßig die negativen Stimmen ihres "Erzeugers" (Bez. der Pat:)

5.3 Von der Antragsstellerin beschriebene Verhaltens- und / oder Wesensänderungen im Verlauf der Abhängigkeitserkrankung

- neative Gedankengänge
- aggressive und impulsartige Verhaltenswiesen

Sei, 0ỗ
stinenzpha
Schwangersch aktuell abstinent
nein
ggf. seit wann und mit welchem M
Sozialanar
.1 Elternha

Nicht

5.5
⊠a
stinenzphasen (Dauer, Bedingungen, Lebenssituation) er Schwangerschaft ihrer Kinder kein Konsum, außer 3-4 mal Nikotin aktuell abstinent abstinent seit
• nein
ggf. seit wann und mit welchem Mittel substituiert

6. Sozialanamnese

6.1 Elternhaus und persönliche Entwicklung

- ihre Mutter habe immer gearbeitet; Pat. habe mittlerweile ein neutrales Verhältnis zu ihr
- Erzeuger war sehr gewalttätig den Kindern und der Kindsmutter gegenüber
- 5 Geschwister: Pat. ist die Jüngste
- der mittlerweile verstorbene Bruder war die wichtigste Person der Pat.
- zwischen 10 und 13 Jahre in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Herzberge gewesen (mehr inhaltlich wird an dieser Stelle erwähnt, da es die Patienten zu sehr emotional belastet.

6.2 Soziales Umfeld und wichtige Bezugspersonen

- ihre Schwester
- der Kindsvater ihres jüngsten Kindes

- Bruder (01.04.2017 verstorben)

6.3 Schulischer Werdegang, Arbeits- und Berufsanamnese (beruflicher Werdegang)

6.3.1 Schulbildung

letzter Schulabschluss (Art der Schule), Jahr

ohne Schulabschluss abgegangen im Jahr

6. Klasse, beendet

6.3.2 Berufsausbildung (auch wenn kein Abschluss erworben wurde)

von

bis

Beruf

Abschluss

X Berufsausbildung nie angestrebt

6.3.3 Zeiten der Berufstätigkeit und Arbeitslosigkeit

von

bis

beschäftigt als

2017

2023

Verkäuferin

• Fachschulabschluss

• Hochschulabschluss

bei Arbeitgeber, Ort

arbeitslos

Tankstellen, Rewe,

Lotto und Service

6.4 Mögliche Hinderungsgründe für Antritt und Durchführung einer Leistung zur medizinischen Rehabilitation (z.B. Angaben über laufende Strafverfahren, Angaben zum voraussichtlichen Zeitpunkt für eine Zurückstellung, Angaben über Aussetzung oder Unterbrechung der Strafvollstreckung)

7. Verlauf der bisherigen Vorbetreuung / Beratung

7.1 Beginn der Vorbetreuung / Beratung im Vorfeld der beantragten Leistung zur medizinischen Rehabilitation

Beratungsstelle / Einrichtung

15.07.2024

Asklepios Fachklinikum Teupitz

7.2 Art und Umfang (Anzahl) der Einzelkontakte

1 Einzeltermin beim Sozialdienst, ansonsten Gespräche im Rahemn des Stationssprechstunde

- 7.3 Art und Umfang (Anzahl) der Gruppenkontakte üblcihe Gruppensettings des qualifizierten Entzugs
- 7.4 Einbindung der Familie und / oder sonstiger wichtiger Bezugspersonen (in welcher Form?)

keine Einbindung

7.5 Anschluss an eine Selbsthilfegruppe und Häufigkeit der Teilnahme

keine Anschlußvermittlung

8

Behandlungsbereitschaft und individuelle Rehabilitationsziele

8.1 Ist Behandlungsbereitschaft erkennbar und wodurch wird sie bestimmt (Eigen- und / oder Fremdmotivation)?
SB1

Seite
Versich
Sozialbericht T., Jenny; geb.: 29.08.1998
Eigenmotiviert und Motivation durch den Kindsvater des ältesten Kindes
8.2 Welche persönliche Rehabilitationziele benennt die Antragstellerin ?
- mehr Lebensfreude
- ernen mit den Erkrankungen (Bauch- und Unterleibschmerzen, psychischen Erkrankungen) umzugehen
- Tablettenabstinenz
- Cannabisreduktion

8.3 Bei erneuter Entwöhnungsbehandlung:
Hat sich zwischenzeitlich die Einstellung zum Suchtmittel geändert? Wenn ja, in welcher Weise?
9. Hinweise zur Leistungsform und zur Rehabilitationseinrichtung
9.1 Schwerpunktsetzung für die medizinische Rehabilitation aus Sicht der Beraterin / des Beraters (z.B notwendige Behandlungsangebote, spezifische Einrichtungsmerkmale, Leistungsform)
- reguläre Entwöhnung, unter Beachtung von Komorbidität (Sucht und Trauma)

9.2 Angaben zu weiteren voraussichtlich erforderlichen Maßnahmen (z.B. andere Leistungen der medizinischen Rehabilitation, Adaption, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Betreutes Wohnen, ambulante
Psychotherapie)
- evtl. Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
- evtl. ambulante Psychotherapie
- evtl. psychosomatische Rehabilitation

9.3 Ggf. Wünsche der Antragstellerin zur Leistungsform und / oder zur Art der Rehabilitationseinrichtung und Begründung der Wünsche
-Fontane Klinik, Motzen: die Nähe zu ihrem Wohnort ist der Patient wichtig, damit die Kinder sie regelmäßig besuchen
können.
9.4 Sind bei der Einrichtung persönliche, religiöse oder geschlechtsspezifische Besonderheiten zu beachten?
nein
10. Zusammenfassende Stellungnahme im Hinblick auf die beantragte Maßnahme
Ich befürworte eine stationäre Suchtrehabilitationsmaßnahme für die Patientin. Dies sei ihr erster Antrag. Sie habe bereits einmal den Antrag bei mir stellen wollen, wozu es jedoch nicht gekommen ist, da sie sich damals noch nicht dazu in der Lage gesehen habe. Sie habe mittlerweile eine andere. Ansicht in die Notwendigkeit einer Suchtreha erlangt. Die Pat. beschreibt ein starkes Resignationsgefühl; sie sieht sich nicht mehr in der Lage ihr Leben, wie bisher, fortzuführen. Sie wünscht sich professionelle Unterstützung ihre Traumatas zu bearbeiten; Bewältigungsstrategien

zu erlernen und Stressresilenz auszubauen. Sie wünscht sich hinreichend gestärkt zu sein, um angemessener mit überwältigendeb Gefühlen/Erlebnisse umzugehen, anstatt diese mit Suchtmitteln zu deckeln.
Aus diesem Grunde erhoffen wir einen positiven Bescheid.
Mit freundlichen Grüßen
Die Einverständniserklärung (Formular G2104) der Antragstellerin zur Weiterleitung an den Leistungsträger und an die Entwöhnungseinrichtung liegt vor.
11. Name und Beruf der / des Aufnehmenden Rösner Anne, Dipl. Sozialarbeiterin/-pädagogin
MSAT / MSNR
oder
Versiche
15755 Teupitz, den 15.7.2024
Ort, Datum
Unterschrift

Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité Berlin
Fachklinikum für Neurologle, Psychiatrie und Psychotherapie
Klinik für Psychlatrle, Psychotheraple und Psychosomatik Chefärztin:
Dr. med. Dipl.-Psych. T. Minx, MBA Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie
Buchholzer Str. 21
15755 Teupitz
Telefon: (03 37 66) 66-276
Telefax: (03 37 66) 66-128
t.minx@asklepios.com
www.asklepis.com/E.SILE
Toupllnden ArlF?99106885
Vorläufiger Entlassungsbrief
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, wir berichten über unsere Patientin Frau T., Jenny, geb. am 29.08.1998, Dorfstr. 25 a, 15738 Zeuthen, die sich vom 29.04.2024 bis zum 10.05.2024 in unserer stationären Behandlung befand.
Diagnose/n:
Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom
Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom
Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Analgetika Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ
Otitis externa, nicht näher bezeichnet

	F12.2
	F12.3
	F33.1
	F55.2
	F60.31

H60.9
Aktuelle Anamnese:
Die stationäre Aufnahme der im Haus bekannten Patientin erfolgte auf der Station 2.2 bei Drogenabhängigkeit. Die Patientin befand zuletzt vom 21.11.2023 bis 07.12.2023 in unserer stationären Behandlung; Nach der Entlassung habe sie aufgehört NSRI zu konsumieren aber 2,5 Wochen nach der Entlassung sei sie mit Cannabis rückfällig geworden. Aktuell konsumiere sie 1 g pro Monat. Der letzte Konsum sei gestern gewesen. Die Entzugserscheinungen kenne sie in Form von Schweißausbrüchen und innerer Unruhe. Nach der Entlassung möchte sie ihre Behandlung in der Tagesklinik KW fortsetzen.
Bei der Aufnahme sahen wir eine orientierte, freundliche Patientin. Sie distanziert sich von Suizidalität und bleibt freiwillig
Aktuelle soziale Belastungsfaktoren:
Arbeitslos

au
Ir v
Aktuelle somatische Beschwerden / Symptomatik:
Wurden verneint.
Psychiatrische Anamnese:
Posttraumatische Belastungsstörung als Kind.
Borderline (mit 8-9 JA diagnostiziert).

Dritte stationäre Aufnahme.
Eigenanamnese / Somatische Anamnese:
Keine Vorerkrankungen seien bekannt.
2 Sectio caesarea OP's (2016 und 2020).
Soziale Anamnese:
Ledig. Wohne mit ihren Kinder (3) in einer Mietwohnung.
Aktuell bekomme sie Bürgergeld und Pflegegeld. Früher habe sie als Verkäuferin, Reinigungskraft und Küchenhelfer gearbeitet.
Bekannte Allergien:
Keine bekannt.
Suchtanamnese:
Langjährige Cannabisabhängigkeit.
Methamphetamin (Crystal Meth) Konsum vor 8-9 Jahren.
Medikation bei Aufnahme:
ren.

Medikament Weg	Dosierung	Gültig von - bis
Chlorprothixen Chlorprothixen HCl 15mg FTA Oral	1- 1 - 1 Stk	ab 29.04.2024
Doxazosin Doxazosin 1mg TBL Oral	0 - 0 - 0 - 2 Stk	ab 29.04.2024
Doxepin Doxepin 25mg FTA Oral	Bedarfsmedikation : 1-2 xtgl. bei Unruhe 1 Stk je Einnahme Maximum je 24 h : 2 Stk	ab 29.04.2024

Untersuchungsbefunde:
Allgemeinmedizinisch - Internistischer Befund vom 29.04.2024:
Patientin in gutem AZ und EZ, Haut und sichtbare Schleimhäute gut durchblutet, keine kardiopulmonalen Dekompensationszeichen.
Kopf/Hals: Rachenring reizlos, keine Lymphknotenschwellung, keine Struma.
• Formular

Thorax: Cor: Herztöne rein und rhythmisch. Pulmo: Vesikuläratmen, keine RG.
Abdomen: Bauchdecken weich und indolent, Hepar und Lien nicht palpabel, Nierenlager bds. frei.
Extremitäten: Frei beweglich, Fußpulse regelrecht.
Neurologischer Befund vom 29.04.2024:
Kein Meningismus. Visus intakt. Pupillen isokor und rund. Prompte, seitengleiche direkte und konsensuelle Lichtreaktion. Augenbewegungen in allen Richtungen

intakt, keine Doppelbildwahrnehmungen. Kein Spontan-, kein Blickrichtungsnystagmus. Keine Sensibilitätsstörungen im Gesicht, keine mimischen Paresen. Hörvermögen beidseits regelrecht.
Armhalteversuch und Beinhalteversuch unauffällig, keine Paresen. Die Kraftentfaltung ist altersentsprechend und seitengleich Tonus und Trophik regelrecht. Keine Pyramidenbahnzeichen.
Finger-Nase-Versuch und Knie-Hacke-Versuch sicher. Romberg sicher.
Sensibilität allseits zu allen Qualitäten intakt. Keine vegetativen Störungen.
Keine aphasischen oder apraktischen Störungen.
Psychischer / Psychopathologischer Befund vom 29.04.2024:
Bewusstseinsklar, zu allen Qualitäten voll orientiert. Aufmerksamkeit und Konzentration normal. Keine groben mnestischen Defizite, keine formalen Denkstörungen. Keine Befürchtungen, Zwänge, Wahn oder Sinnestäuschungen, keine Ich-Störungen. Antrieb ausgeglichen, affektiv schwingungs- und modulationsfähig. Stimmung ausgeglichen, keine akute Suizidalität.
Diagnostik:
Ruhe EKG vom 29.04.2024:
Indifferenztyp, Sinusrhythmus, keine Erregungsrückbildungsstörungen. HF 76 BPM, Qtc-Zeit 406 ms.
Laborwerte:
Bezeichnung
Ref.-Bereich
Einheit
29.4.24 11:06
negativ
29.4.24 13:48
Tramadol
Status
Endbefun
d
folgt
Drogenscreening-Hinweis
Kreatinin i. H.
Cannabinole i. H.
CANNAP
Status
29 - 226
mg/di
нg/1
нg/1
- 28W
- positivit
- 100.0
Endbefun
Leukozyten
Erythrozyten
Hь
Hk
MCV

MCH
MCHC
Thrombozyten
3.6 - 11.8
3.8 - 5.2
7.3 - 9.8 0.35 - 0.4
84 - 100
1.75 - 2.1
20 - 22
150-370
Gpt/1
Tpt/1
mmol/1
1/1
fl
fmol
mmol/1
Gpt/1
d
12.3 4.13
7.40
0.36
88
1.79
20.4
287

Thorax: Cor: Herztöne rein und rhythmisch. Pulmo: Vesikuläratmen, keine RG.
Abdomen: Bauchdecken weich und indolent, Hepar und Lien nicht palpabel, Nierenlager bds. frei.
Extremitäten: Frei beweglich, Fußpulse regelrecht.
Neurologischer Befund vom 29.04.2024:
Kein Meningismus. Visus intakt. Pupillen isokor und rund. Prompte, seitengleiche direkte und konsensuelle Lichtreaktion. Augenbewegungen in allen Richtungen intakt, keine Doppelbildwahrnehmungen. Kein Spontan-, kein Blickrichtungsnystagmus. Keine Sensibilitätsstörungen im Gesicht, keine mimischen Paresen. Hörvermögen beidseits regelrecht.
Armhalteversuch und Beinhalteversuch unauffällig, keine Paresen. Die Kraftentfaltung ist altersentsprechend und seitengleich Tonus und Trophik regelrecht. Keine Pyramidenbahnzeichen.
Finger-Nase-Versuch und Knie-Hacke-Versuch sicher. Romberg sicher.
Sensibilität allseits zu allen Qualitäten intakt. Keine vegetativen Störungen.

Keine aphasischen oder apraktischen Störungen.
Psychischer / Psychopathologischer Befund vom 29.04.2024:
Bewusstseinsklar, zu allen Qualitäten voll orientiert. Aufmerksamkeit und Konzentration normal. Keine groben mnestischen Defizite, keine formalen Denkstörungen. Keine Befürchtungen, Zwänge, Wahn oder Sinnestäuschungen, keine Ich-Störungen. Antrieb ausgeglichen, affektiv schwingungs- und modulationsfähig. Stimmung ausgeglichen, keine akute Suizidalität.
Diagnostik:
Ruhe EKG vom 29.04.2024:
Indifferenztyp, Sinusrhythmus, keine Erregungsrückbildungsstörungen. HF 76 BPM, Qtc-Zeit 406 ms.
Laborwerte:
Bezeichnung
Ref.-Bereich
Einheit
29.4.24 11:06
negativ
29.4.24 13:48
Tramadol
Status
Endbefun
d
folgt
Drogenscreening-Hinweis
Kreatinin i. H.
Cannabinole i. H.
CANNAP
Status
29 - 226
mg/di
нg/1
нg/1
- 28W
- positivit
- 100.0
Endbefun
Leukozyten
Erythrozyten
Hь
Hk
MCV
MCH
MCHC
Thrombozyten
3.6 - 11.8
3.8 - 5.2
7.3 - 9.8 0.35 - 0.4
84 - 100
1.75 - 2.1

20 - 22
150-370
Gpt/1
Tpt/1
mmol/1
1/1
fl
fmol
mmol/1
Gpt/1
d
12.3 4.13
7.40
0.36
88
1.79
20.4
287

ASKLEPIOS
FACHKLINIKUM TEUPITZ
7
Г
Asklepios Fachklinikum Teupitz
Buchholzer Str. 21 • 15755 Teupitz
Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité Berlin
Fachklinikum für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik Chefärztin:
Dr. med. Dipl.-Psych. T. Minx, MBA Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie
Buchholzer Str. 21
15755 Teupitz
Telefon: (03 37 66) 66-276
Telefax: (03 37 66) 66-128
t.minx@asklepios.com
www.asklepig.com/E.SIZE
Trupllnden A%05?90106885
Vorläufiger Entlassungsbrief
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, wir berichten über unsere Patientin Frau T., Jenny, geb. am 29.08.1998, Dorfstr. 25 a, 15738 Zeuthen, die sich vom 29.04.2024 bis zum 10.05.2024 in unserer stationären Behandlung befand.
Diagnose/n:
Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Abhängigkeitssyndrom
Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide: Entzugssyndrom
Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen: Analgetika Emotional instabile Persönlichkeitsstörung: Borderline-Typ Otitis externa, nicht näher bezeichnet
F12.2
F12.3

F33.1
F55.2
F60.31
H60.9
Aktuelle Anamnese:
Die stationäre Aufnahme der im Haus bekannten Patientin erfolgte auf der Station 2.2 bei Drogenabhängigkeit. Die Patientin befand zuletzt vom 21.11.2023 bis 07.12.2023 in unserer stationären Behandlung. Nach der Entlassung habe sie aufgehört NSRI zu konsumieren aber 2,5 Wochen nach der Entlassung sei sie mit Cannabis rückfällig geworden. Aktuell konsumiere sie 1 g pro Monat. Der letzte Konsum sei gestern gewesen. Die Entzugserscheinungen kenne sie in Form von Schweißausbrüchen und innerer Unruhe. Nach der Entlassung möchte sie ihre Behandlung in der Tagesklinik KW fortsetzen.
Bei der Aufnahme sahen wir eine orientierte, freundliche Patientin. Sie distanziert sich von Suizidalität und bleibt freiwillig.
Aktuelle soziale Belastungsfaktoren:
Arbeitslos

Aktuelle somatische Beschwerden / Symptomatik:
Wurden verneint.
Psychiatrische Anamnese:
Posttraumatische Belastungsstörung als Kind.
Borderline (mit 8-9 JA diagnostiziert).
Dritte stationäre Aufnahme.
Eigenanamnese / Somatische Anamnese:
Keine Vorerkrankungen seien bekannt.
2 Sectio caesarea OP's (2016 und 2020).
Soziale Anamnese:
Ledig. Wohne mit ihren Kinder (3) in einer Mietwohnung.
Aktuell bekomme sie Bürgergeld und Pflegegeld. Früher habe sie als Verkäuferin, Reinigungskraft und Küchenhelfer gearbeitet.
Bekannte Allergien:
Keine bekannt.

Suchtanamnese:
Langjährige Cannabisabhängigkeit.
Methamphetamin (Crystal Meth) Konsum vor 8-9 Jahren.
Medikation bei Aufnahme:

Medikament	Weg	Dosierung	Gültig von - bis
Chlorprothixen			
Chlorprothixen HCl 15mg FTA Oral Doxazosin		1- 1 - 1 Stk	ab 29.04.2024
Doxazosin 1mg TBL	Oral	0 - 0- 0 - 2 Stk	ab 29.04.2024
Doxepin Doxepin 25mg FTA	Oral	Bedarfsmedikation : 1-2 xtgl. bei Unruhe 1 Stk je Einnahme Maximum je 24 h : 2 Stk	ab 29.04.2024

Untersuchungsbefunde:
Allgemeinmedizinisch - Internistischer Befund vom 29.04.2024:
Patientin in gutem AZ und EZ, Haut und sichtbare Schleimhäute gut durchblutet, keine kardiopulmonalen Dekompensationszeichen.
Kopf/Hals: Rachenring reizlos, keine Lymphknotenschwellung, keine Struma.

Thorax: Cor: Herztöne rein und rhythmisch. Pulmo: Vesikuläratmen, keine RG.
Abdomen: Bauchdecken weich und indolent, Hepar und Lien nicht palpabel, Nierenlager bds. frei.
Extremitäten: Frei beweglich, Fußpulse regelrecht.
Neurologischer Befund vom 29.04.2024:
Kein Meningismus. Visus intakt. Pupillen isokor und rund. Prompte, seitengleiche direkte und konsensuelle Lichtreaktion. Augenbewegungen in allen Richtungen intakt, keine Doppelbildwahrnehmungen. Kein Spontan-, kein Blickrichtungsnystagmus. Keine Sensibilitätsstörungen im Gesicht, keine mimischen Paresen. Hörvermögen beidseits regelrecht.
Armhalteversuch und Beinhalteversuch unauffällig, keine Paresen. Die Kraftentfaltung ist altersentsprechend und seitengleich Tonus und Trophik regelrecht. Keine Pyramidenbahnzeichen.
Finger-Nase-Versuch und Knie-Hacke-Versuch sicher. Romberg sicher.
Sensibilität allseits zu allen Qualitäten intakt. Keine vegetativen Störungen.
Keine aphasischen oder apraktischen Störungen.
Psychischer / Psychopathologischer Befund vom 29.04.2024:

Bewusstseinsklar, zu allen Qualitäten voll orientiert. Aufmerksamkeit und Konzentration normal. Keine groben mnestischen Defizite, keine formalen Denkstörungen. Keine Befürchtungen, Zwänge, Wahn oder Sinnestäuschungen, keine Ich-Störungen. Antrieb ausgeglichen, affektiv schwingungs- und modulationsfähig. Stimmung ausgeglichen, keine akute Suizidalität.
Diagnostik:
Ruhe EKG vom 29.04.2024:
Indifferenztyp, Sinusrhythmus, keine Erregungsrückbildungsstörungen. HF 76 BPM, Qtc-Zeit 406 ms.
Laborwerte:
Bezeichnung
Ref.-Bereich
Einheit
29.4.24 11:06
negativ
29.4.24 13:48
Tramadol
Status
Endbefun
d
folgt
Drogenscreening-Hinweis
Kreatinin i. H.
Cannabinole i. H.
CANNAP
Status
29 - 226
mg/di
ng/
нд/-
- 28W
- positivit
- 100.0
Endbefun
Leukozyten
Erythrozyten
Hb
Hk
MCV MCH
MCHC
Thrombozyten
3.6 - 11.8
3.8 - 5.2
7.3 - 9.8 0.35 - 0.4
84 - 100
1.75 - 2.1
20 - 22
150-370
Gpt/

Tpt/1
mmol/1
1/1
fl
fmol
mmol/l
Gpt/L
d
12.3 4.13
7.40
0.36
88
1.79
20.4
287

ASKLEPIOS
Asklepios Fachklinikum Teupitz
Frau
T., Jenny
Dorfstr. 25 a
15738 Zeuthen
Akademisches
Lehrkrankenhaus der Charité Berlin
Buchholzer Str. 21
15755 Teupitz
Datum: 10.05.2024
Verwaltungsbescheinigung
Frau T., Jenny; geb. 29.08.1998; wohnhaft Dorfstr. 25 a, 15738 Zeuthen war vom 29.04.2024 bis 10.05.2024 in unserer stationären Behandlung.
(Krankenschwester/-pfleger)
Asklepios Fachklinikum Teupitz
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Buchholzer Straße 21
15755 Teupitz
四 +49 33766-66-120
Seit
nO oE 2024

Patientin: Jenny T.
Geb.-Dat.: 29.08.1998
Fallnummer: 30106885
Bezeichnung
Benzodiazepine
Cocain
Cannabinoide
Methadon
Methamphetamin

Morphin/Opiate
Tricyclische
Ref.-Bereich
Einheit
29.4.24 11:06
negativ negativ
* POSITIV
negativ negativ negativ negativ
29.4.24 13:48
Anitidepressiva
Amphetamine
Ecstasy
negativ negativ
Laborwerte übernommen am: 08.05.2024 10:42
Therapie und Verlauf:
Die stationäre Aufnahme der Patientin erfolgte auf der suchtspezifischen Station 2.2 unseres Hauses zur psychiatrischen qualifizierten Entzugsbehandlung bei Cannabisabhängigkeit. Die Patientin erhielt die Möglichkeit, an den angebotenen Therapien (Ergotherapie, Musiktherapie, Aromatherapie, Akupunktur, themenzentrierte Einzel- und Gruppentherapie, Psychoedukation) teilzunehmen sowie die sozialarbeiterische Beratung zu nutzen. Die Behandlung erfolgte freiwillig. Klinisch entwickelte die Patientin in den Stunden nach Aufnahme ein vegetatives Entzugssyndrom mit Hyperhidrosis und innerer Unruhe, wogegen die vorbestehende Medikation mit Chlorprothixen und bedarfsgerechtem Doxepin fortgesetzt wurde. Darunter waren die Entzugssymptome rückläufig. Im weiteren Verlauf remittierte die Entzugssymptomatik vollständig.
Die Patn. konnte sich schnell in das Stationsleben integrieren und von dem angebotenen Programm profitieren. Sie wurde sie über die Möglichkeiten der Nachsorge und Rückfallprävention informiert.
Die Vitalparameter waren im Rahmen regelmäßiger Kontrollen im normalen Bereich. Laborchemisch zeigten sich keine relevanten Auffälligkeiten. Der EKG-Befund bei Aufnahme war unauffällig. Im Laufe der Behandlung klagte Frau T. über leichte Schmerzen und gelbes Sekret im linken Ohr. Bei otoskopischer Untersuchung war das Trommelfell intakt, nicht gerötet. Es fielen keine erhöhte Temperaturen auf. Bei Verdacht auf Otitis Externa wurde eine topische Antibiotikatherapie mit Ofloxazin wurde über 7 Tage verabreicht, darunter haben sich die Beschwerden deutlich verbessert.
Nach erfolgter Entzugsbehandlung entlassen wir Frau T. am 10.05.2024 in die Häuslichkeit und Ihre geschätzte ambulante Weiterbehandlung. Wir klärten die Patn. über die weiteren therapeutischen Möglichkeiten wie Suchtberatungsstellen, ambulante Selbsthilfegruppe, stationäre Krisen- und Entwöhnungstherapien auf. Sie vereinbarte eigenständig einen Termin bei der Suchtberatungsstelle Wildau für den 21.05.2024. Nach der Entlassung möchte sie für die ambulante Weiterbehandlung weiterhin unsere psychiatrische Institutsambulanz in Teupitz besuchen. Bei Entlassung bestand weder Suizidalität, noch Eigen- oder Fremdgefährdung. Die Möglichkeit zur Wiederaufnahme zur Krisenintervention bei drohendem Rückfall wurde besprochen.

Im Falle einer Wiederaufnahme bei Zustandsverschlechterung können Sie sich an die Zentrale Aufnahme für Psychiatrie (033766/66-404) in der Zeit von 08:00 Uhr bis 16:00 Uhr wenden.
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung

ASKLEPIOS
FACHKLINIKUM LÜBBEN
Γ
Asklepios Fachklinikum Lübben • Luckauer Straße 17 • 15907 Lübben
Familie T.
Dorfstr. 25a
15738 Zeuthen
Fachklinikum für Psychiatrie und Neurologie
Klinik f. Kinder- u. Jugendpsychiatrie, Psychotherapie u. Psychosomatik
Chefärztin Dr. med. A. Donchin
Tagesklinik/Institutsambulanz KW
Oberarzt D. Illy
Cottbuser Straße 53 a + b
15711 Königs Wusterhausen
Telefon: (0 33 75) 52667-10/-20
Telefax: (0 33 75) 52667-30
sek.tkkw.luebben@asklepios.com
www.asklepios.com/luebben
S.WINDHEIM / S.WINDHEIM
KFakhWWeterheuper20060P14p32024
Abschlussbrief Diagnostik
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, wir berichten über den Patienten T., Tilo, geb. am 31.12.2016, Dorfstr. 25a, 15738 Zeuthen, der sich zuletzt am 09.10.2024 in hiesiger ambulanter Behandlung befand.
Diagnose/n:
Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung
F90.0
Einweisungsmodus:
Der Patient stellte sich in Begleitung seiner sorgeberechtigten Mutter auf Überweisung von Frau Mosch
(MVZ) in unserer PIA zum Erstgespräch vor. Begleitet wurde die Familie von der Familienhelferin Frau Motz.
Vorstellungsanlass:
Es bestehe laut Tilos Mutter der Verdacht auf ein ADHS, da Tilo agiere "wie ein Flummi". Eine Abklärung sei vor allem durch die Kita angeregt worden. Die Einschulung sei für das aktuelle Schuljahr auf einer. regulären Schule geplant. Es bestehe Förderstatus im körperlich-motorischen Bereich. Man habe Sorge, dass Tilo den Anforderungen in der Schule nicht gerecht werden könne, weil er kaum bei der Sache bleiben könne. Die Frustrationstoleranz sei gering, besonders im Kontakt mit seiner Mutter. Tilo bestimme auch die Art wie sein Zimmer gereinigt werde und wirke hier teilweise zwanghaft. Alles müsse immer am gleichen Platz sein, die Mutter dürfe nur Dinge bewegen und reinigen, die Tilo selbst freigebe.

Die Mutter hätte ähnliche Tendenzen, sie seien allerdings nicht so ausgeprägt. Die Familienhilfe ergänzte jedoch, dass zu Beginn ihrer Arbeit in der Familie deutliche Zwänge bestanden hätten. Frau T. putze mindestens 2x/d die Wohnung, die Kinder müssten nach der Kita die Kleidung wechseln, alle, die von draußen reinkämen, müssten sich zunächst die Hände waschen, weil Ängste vor Keimen bestünden. Tilo sei umstellungserschwert, veränderte Abläufe könne er nicht gut tolerieren. Sozial sei er nicht Gesund werden. Gesund leben. www.asklepios.com

eingeschränkt, habe feste Freundschaften. Er sei in der Kita gut integriert, hier zeige er außer der ADHS-
Symptomatik
keinerlei Auffälligkeiten. Auf die Familienhelferin habe er anfänglich sehr skeptisch reagiert, als hätte er Sorge gehabt, dass sie die Familie trennen wolle. Seine Mutter begründete dies mit negativen Erfahrungen mit Betreuern aus der vorherigen I-Kita. Es wurde jedoch beschrieben, dass auch die anderen Geschwister mit Skepsis reagiert hätten.
Tilos Mutter beschrieb den in der 29. SSW geborenen Tilo als Spätentwickler, der für alles etwas mehr Zeit benötige. Auch für die Trennung seiner Eltern benötige Tilo mehr Zeit zur Verarbeitung als seine Geschwistern. Die motorische Entwicklung sei aufgrund der Frühgeburtlichkeit mit Halbseitenlähmung verzögert gewesen. Verständlich gesprochen habe Tilo erst mit 3 Jahren, vorher sei es erschwert gewesen, weil er eher geplappert und gezeigt habe. Die Geschwister wären ähnlich "langsam" gewesen.
beschrieb eine Unruhe, Konzentrationsschwache und phasenweise lautiere unnachvollziehbar wie ein Tier. Zudem beschrieb sie Tilo als ungeduldig, bei Wunschversagen reagiere er oft körperlich. Außerhalb von zuhause halte Tilo sich besser an Regeln. Die Familienhilfe beschrieb, dass Tilo bei Frust schnell ausfallend und sachaggressiv reagiere. In der Kita sei es gegenteilig, er werde dort als feinfühlig, empathisch und rücksichtsvoll beschrieben.
Die Geburt sei traumatisch gewesen, es habe geheißen "machen Sie sich keine Hoffnung". Die ersten Monate wären stark angstgeprägt gewesen. Diese Problematik sei weiterhin sehr präsent, eine therapeutische Aufarbeitung habe für Tilos Mutter bisher nicht stattgefunden. Insgesamt zeigte sich seine Mutter belastet durch eigene Erfahrungen aus der Vergangenheit, die nun im Rahmen einer Tagesklinik-Behandlung aufgefangen werden solle. Parallel wurden deutlich zwanghafte

Verhaltensweisen : thematisiert. Sie beschrieb weiterhin anhaltende Angste, die sie manchmal daran hindern würden, Tilo etwas zuzutrauen, bzw. loszulassen.
Anamnestisch werden eine PTBS und eine Depression benannt.
Beschriebene Symptome bei Tilo im Sinne einer zwanghaften oder sozialverhaltensgestörten
Symptomatik erscheinen hier vor allem im Rahmen der Häuslichkeit aufzutreten.
Familienanamnese:
Mutter: LRS und Konzentrationsschwäche, PTBS und Depressionen, anamnestisch Hinweise für
Zwangserkrankung
Tagesklinik geplant
Herzerkrankungen bei den Großeltern ms und vs bekannt.
Soziale Anamnese:
Der Patient lebe mit seiner Mutter (*1998) und 2 weiteren Geschwistern in einer Mietwohnung und habe ein eigenes Zimmer.
Die Eltern sind getrennt seit 2023. Der Vater sei ebenfalls sorgeberechtigt und sehe Tilo an den Wochenenden. Geschwister: Djamila (*2016) und Liam (*2020)
Beruflicher Hintergrund der Eltern: Die Mutter sei arbeitssuchend, der Vater in Ausbildung zum
Pflegehelfer.
In der Freizeit besuche Tilo gern den Spielplatz und baue Lego.
Sozial sei er ausreichend gut eingebunden.
Tilo wurde in diesem Jahr eingeschult.
Körperliche Entwicklung:
Frühgeborenes nach Notkaiserschnitt in der 29. SSW mit Plazentaablösung
Halbseitenlähmung nach postpartalem Schlaganfall
OP Achillessehne, OP nach Armbruch

ASKLEPIOS
FACHKLINIKUM LÜBBEN
Seite 317
Patient: Tilo T.
Geb.-Dat.: 31.12.2016
Fallnummer: 20061113
Nierenschaden, Fußfehlstellung (geschient)
Geburtsgewicht: 1043g; Größe: 45cm. Postpartale Adaptation geprägt von Schlaganfall beim Kind mit : resultierender Halbseitenlähmung, Ikterus, =2-Mangel, Trinkstörung. Man habe der Mutter damals gesagt, sie solle sich keine Hoffnung machen. Tilo sei 3 Mo gestillt worden. Er habe eine Schrumpfniere.
Insgesamt habe er als Säugling
4 Monate im Krankenhaus verbracht. Laut der Km wird. das
Schlafverhalten als unauffällig und das Temperament des Kindes als "normal" beschrieben. Frühkindliche Auffälligkeiten werden verneint. Die Meilensteine der frühkindlichen Entwicklung: Freies Laufen bei Halbseitenlähmung mit 2 1/2 Jahren.
Erste Wörter mit 1 1/2 Jahren, verständliche Sprache nach 3. Lj.
Einmaliger Krampfanfall im 1. Lj. Die Sauberkeitserziehung sei ab dem 4. Lj. abgeschlossen gewesen;
erneutes Einnässen oder Einkoten wird verneint.
Psychiatrische Anamnese:

SPZ - Befunde werden nachgereicht seit 1 1/2 Jahren FH
I-Status motorische Entwicklung
Medienkonsumanamnese:
reguliert, 30min Tablet/d
Medikamentenanamnese:
leer
Psychopathologischer Befund bei Aufnahme:
7;Ajähriger Patient, äußeres Erscheinungsbild altersentsprechend, trägt Schiene am re Fuß, gepflegt.
Patient ist wach, bewusstseinsklar und zu allen Qualitäten orientiert.
Psychomotorik: unauffälliger Antrieb, zu Beginn abgewandt und zurückgenommen bis spärlich im Kontakt, kein Blickkontakt. Erst im Verlauf des Gespräches etwas aufgelockerter, nimmt dann auch von sich aus Kontakt auf, schaut in die Augen.
Denken: kein Anhalt für formale oder inhaltliche Denkstörungen, Wahn oder Phobien. Zwanghafte und oppositionell-aggressive Tendenzen in der Häuslichkeit beschrieben.
Keine Wahrnehmungs- oder Ich-Störungen.
Stimmung, Affekt: ausgeglichen, spielt, lässt sich nur schwer in den Kontakt holen. Schwingungsfähigkeit dabei erschwert überprüfbar.
Bestenfalls durchschnittliche Intelligenz.
Kein SVV. Keine Suizidalität, verbal und sachaggressive Tendenzen ausschließlich in der Häuslichkeit beschrieben. Kein Anhalt für akute Eigen- oder Fremdgefährdung.
Diagnostik
Psychologische Diagnostik:
KiTAP (Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung - Kinderversion) ohne Medikation vom 13.08.2024:
Befund:
Alertness: Dieser Test erfasst die Verarbeitungsgeschwindigkeit (T-Wert: 57; durchschnittlich) sowie die Stabilität der Arbeitsweise (T-Wert: 43; durchschnittlich).
Daueraufmerksamkeit: Bei dieser Aufgabe wird die kontinuierliche Zuwendung der Aufmerksamkeit über eine längere Zeitspanne („Konzentration") geprüft. Mit 200 Fehlern (I-Wert: < 20) wurde eine weit

unterdurchschnittlich hohe Fehleranzahl erreicht. Mit 7 Auslassern (T-Wert: 51) lag dieser Wert im durchschnittlichen Bereich.
Geteilte Aufmerksamkeit: Die Testung der Fähigkeit zur Teilung der Aufmerksamkeit ergibt einen Gesamtwert (T-Wert: 56) im durchschnittlichen Bereich.
Go/Nogo: In diesem Test wird die Fähigkeit überprüft unter Zeitdruck eine angemessene Reaktion auszuüben und eine unangemessene zu unterdrücken. Mit 11 Fehlern wurde eine unterdurchschnittlich hohe Fehlerzahl (T-Wert: 29) bei einer überdurchschnittlichen Reaktionszeit (T-Wert: 65) erreicht.
Verhaltensbeobachtung: Tilo geht zunächst schüchtern und zurückhaltend in den Kontakt. Im weiteren Verlauf ist er zunehmend aufgeschlossen und kommentiert sein

Tun während der Testung. Eine motorische Unruhe ist nicht erkennbar, es fällt Tilo jedoch schwer, seine Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten.
Beurteilung:
In dieser Testung ergaben sich deutliche Hinweise auf einen impulsiven Arbeitsstil.
WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for children) ohne Medikation vom 10.09.2024:
Befund:
Sprachverständnis (SV): 86
Visuell-Räumliche Verarbeitung (VRV): 105
Fluides Schlussfolgern (FS): 103
Arbeitsgedächtnis (AGD); 82
Verarbeitungsgeschwindigkeit (VG): 80
Gesamt-IQ: 84, Prozentrang (PR) 14, 90% Vertrauensintervall 80 - 89 (obere Grenze unterdurchschnittlicher Intelligenzbereich)
Verhaltensbeobachtung: Tilo geht zunächst unsicher und abwehrend in den Kontakt, im weiteren Verlauf wirkt er zugewandt und schwingungsfähig. Während der Testung zeigt er ein unterschiedlich ausgeprägtes Instruktionsverständnis, gerade der Untertest Zahlen nachsprechen bereitet ihm Schwierigkeiten in der Umsetzung. Insgesamt arbeitet Tilo überwiegend motiviert und zügig, er zeigt dabei keine Anzeichen motorischer Unruhe.
Beurteilung:
Da der Gesamt-IQ-Wert auf einem heterogenen Leistungsprofil basiert, sollte er in diesem Fall nur eingeschränkt interpretiert und durch die Index-Werte und begleitende Diskrepanzanalyse ergänzt werden. Klinisch signifikante Differenzen auf Hauptskalenebene ergeben sich zwischen Sprachverständnis und Visuell-Räumliche Verarbeitung, zwischen Sprachverständnis und Fluides Schlussfolgern, zwischen Visuell-Räumliche Verarbeitung und Arbeitsgedächtnis, zwischen Visuell-Räumliche Verarbeitung und Verarbeitungsgeschwindigkeit sowie zwischen Fluides Schlussfolgern und Verarbeitungsgeschwindigkeit.
Zudem liegen die Werte Nonverbaler Index (97) und Allgemeiner Fähigkeitsindex (kristalline, Intelligenz und visuelle Verarbeitung; 95) deutlich über dem Wert Kognitiver Leistungsindex (Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit; 78). Dies lässt Rückschlüsse auf eine Aufmerksamkeitsstörung zu, hier wird aufgrund der Einschränkungen im Sprachverständnis eine sprachfreie Re-Testung unter behandelter Symptomatik empfohlen.
Beurteilungsbögen DISYPS-III: SCREEN, ADHS und SSV vom 07.10.2024:

Befund:
DISYPS-III: SCREEN ausgefüllt: KM 12/23
Werte im Grenzbereich
zur Auffälligkeit (Stanine 7): Screening Entwicklungs- und Ausscheidungsstörung (ENTW-SCREEN), Screening Autismus (AUT-SCREEN)

auffälliger Bereich (Stanine 8): Screening ADHS (ADHS-SCREEN), Screening Kontaktverhalten (KON-SCREEN)
ausgeprägt auffälliger Bereich (Stanine 9): Screening SSV (SSV-SCREEN), Screening Angst (ANG-SCREEN), Screening Depression (DEP-SCREEN), Screening Zwang & Tic (ZWATIC-SCREEN), Screening Internal (INT-SCREEN), Screening External (EXT-SCREEN), Funktionsbeeinträchtigung & Leidensdruck (FL-SCREEN)
DISYPS-III: SCREEN ausgefüllt: EZ. 06/24
Werte im Grenzbereich zur Auffälligkeit (OB): Screening Entwicklungs- und Ausscheidungsstörung
(ENTW-SCREEN), Screening Autismus (AUT-SCREEN)
auffälliger Bereich (OB): Screening ADHS (ADHS-SCREEN), Screening Kontaktverhalten (KON-SCREEN)
ausgeprägt auffälliger Bereich (OB): Screening Angst (ANG-SCREEN), Screening Depression (DEP-SCREEN), Screening External (EXT-SCREEN), Screening Internal (INT-SCREEN), Screening SSV (SSV-SCREEN), Screening Zwang & Tic (ZWATIC-SCREEN), Screening Gesamtsymptomatik (GES-SCREEN), Funktionsbeeinträchtigung & Leidensdruck (FL-SCREEN)
Norm: --- Jungen, 7 bis 10 Jahre
Skala: T
DISYPS-III: FBB-ADHS-V ausgefüllt: KM 12/23: auffälliger Bereich (OB): Funktionsbeeinträchtigung/Leidensdruck (FL-ADHS-V)
DISYPS-III: FBB-ADHS ausgefüllt: EZ 06/24: auffälliger Bereich (OB): Unaufmerksamkeit (UA)
ausgeprägte Auffälligkeit (OB): Hyperaktivität/Impulsivität HY-IM), Gesamtsymptomatik ADHS (Ges-
ADHS), Funktionsbeeinträchtigung/Leidensdruck (FL-ADHS)
Kompetenzen: Ausdauer, Aufmerksamkeit und Reflexivität (OB): gering Die beschriebenen Verhaltensprobleme bestehen seit mind. 6 Monaten.
DISYPS-III: FBB-SSV ausgefüllt: KM 12/23
Werte im Grenzbereich zur Auffälligkeit (Stanine 7): Aggressiv-dissoziales Verhalten (AG-DISS),
Begrenzte Prosoziale Emotionalität (BPE)
auffälliger Bereich (Stanine 8): Oppositionelles Verhalten (OPP), Gesamtsymtomatik SSV (GES-SSV), Disruptive Affektregulationsstörung und Reizbarkeit (DAF-R), Funktionsbeeinträchtigung/Leidensdruck
SSV (FL-SSV)
Kompetenzen: Prosoziales Verhalten (K-PSV) (Staninen 7): hoch (hier liegen Verständnisschwierigkeiten beim Ausfüllen nahe)
DISYPS-III: FBB-SSV ausgefüllt: EZ 06/24
alle Werte im unauffälligen Bereich
Kompetenzen: Prosoziales Verhalten (K-PSV) (OB): durchschnittlich

Fallnummer: 20061113
Differenzialdiagnostische Überlegungen/Schlussfolgerung:
Wir sahen einen 7-jährigen Patienten, der zunächst schüchtern und zurückhaltend in den Kontakt ging Im weiteren Verlauf zeigte sich Tilo zunehmend aufgeschlossen und wirkte motiviert an den Testungen mit, es fiel ihm jedoch schwer, seine Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Zusammenfassend ergab sich nach Auswertung der ausführlichen Anamnese, der Fremdbeurteilungsbögen sowie der hier durchgeführten psychologischen Testdiagnostik und klinischen Verhaltensbeobachtung die Diagnose einer einfachen Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung. Die Leistungsdiagnostik ergab einen Gesamt-IQ an der oberen Grenze zum unterdurchschnittlichen Intelligenzbereich, da das Ergebnis auf einem heterogenen Leistungsprofil basierte, war hier nur eine eingeschränkte Interpretation möglich. Die Werte Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit lagen im unterdurchschnittlichen Intelligenzbereich. Zudem lagen die Werte Nonverbaler Index (97) und Allgemeiner Fähigkeitsindex (kristalline, fluide Intelligenz und visuelle Verarbeitung; 95) deutlich über dem Wert Kognitiver Leistungsindex (Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit; 78). Dies ließ einen zusätzlichen Rückschluss auf : eine Aufmerksamkeitsstörung zu, aufgrund der Einschränkungen im Sprachverständnis wird eine sprachfreie Re-Testung unter behandelter Symptomatik empfohlen.
Die beschriebenen Verhaltensauffälligkeiten sahen wir im Zusammenhang mit der gestellten Diagnose und als
Reaktion auf die unterschiedlichen Belastungsfaktoren (Frühgeburtlichkeit Halbseitenlähmung, Sprachentwicklungsverzögerung, Trennung der Eltern, psychische Problematik der Mutter). Differanzialdiagnostisch ergeben sich anamnestisch zudem Hinweise auf eine Zwangsstörung bzw. auf das Vorliegen einer Autismus-Spektrum-Störung (umstellungserschwertes Verhalten), die zur Einschätzung eine genauere Beobachtung erfordern. Aufgrund der Komplexität der Symptome wird zur besseren Einordnung der Symptomatik und zur Feststellung des tatsächlichen Hilfebedarfs eine vertiefende Diagnostik im Rahmen einer tagesklinischen Behandlung bzw. eine Aufnahme durch unsere stationsäquivalente Betreuung (StäB) unter Einbeziehung des familiären Rahmens empfohlen.
Empfehlungen:
medikamentöse Behandlung mittels Stimulanzien
-
-
Weiterführung der Betreuung durch die Familienhilfe unterstützende Maßnahmen in der Schule in Absprache mit den Lehrerinnen, u.a.
Nachteilsausgleich, Anpassung der Lernbedingungen
- ggf. Ergotherapie zur Unterstützung im Umgang mit der Aufmerksamkeitsproblematik bei Bedarf ergänzende Aufnahme einer ambulanten Psychotherapie
- ggf. tagesklinische Aufnahme zur weiterführenden Diagnostik bzw. Weiterbehandlung durch das Team hiesiger stationsäquivalenten Betreuung (StäB) sprachfreie Re-Testung (Leistungsdiagnostik) unter behandelter Symptomatik empfohlen

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
M. Schmid
Oberärztin

S. Windheim
Therapeut/-in

OBERLIN KLINIK
Oberlinklinik gGmbH • Rudolf-Breitscheid-Straße 24 • 14482 Potsdam
Frau
Anne Mösch
FÄ für Kinder- und Jugendmedizin
Köpenicker Straße 29
15711 Königs Wusterhausen
Ansprechpartner
Dr. med. Stefan Blume
Chefarzt
Abteilung
Kinder- und Neuroorthopädie
Kontakt
Tel.: 0331 763-5742
Fax: 0331 763-5740
kinderorthopaedie @oberlinhaus.de
Unser Zeichen UD - BRIC
Datum 24.05.2024
Familie
T., Tilo (M) - geb. am 31.12.2016, wohnhaft: Dorfstr. 25a in 15738 Zeuthen
Sehr geehrte Frau Kollegin,
wir berichten über Tilo, der am 19.04.2024 in unserer kinder-/neuroorthopädischen Sprechstunde vorgestellt wurde.
Diagnose:
ICP nach FG 30. SSW (Arteria-Media-Infarkt links)
Unilaterale, spastische Zerebralparese rechts (GMFCS II)
Schrumpfniere rechts nach Nierenvenenthrombose (V. a. AT3-Mangel)
Leichte Arm- und Handgebrauchsstörung rechts Residuelles Innenrotationsgangbild rechts
Z. n. z-förmiger Achillessehnenverlängerung 09/2021 mit jetzt guter Funktion bei noch residuellem Spitz-Sicheltonus
Anamnese:
Siehe vorausgehende Berichte, zuletzt Sprechstunde 05/2023.
Tilo ist weiterhin frei mobil. Für Herbst ist jetzt die Einschulung in eine Regel-Grundschule vorgesehen. Hier bittet die Mutter um Einschätzung, inwieweit er am Sportunterricht teilnehmen kann. Sie berichtet, dass der rechte Fuß wieder einwärts rotiert und fragt nach Orthesenversorgung an. Es wird ansonsten über keine Beschwerden berichtet.
Aktuell sind keine spezielle Fußfassung und auch keine Lagerungsschienen mehr im Einsatz.
Physiotherapeutische Beübung ist geplant.

Tel.: 0331 763-4312 | Fax: 0331 763-4322 | info@oberlin-klinik.de | www.oberlin-klinik.de
Gesellschafter: Verein Oberlinhaus
Geschäftsführung: Thomas Neubauer, Alexander Mommert, Dr. med. Hansjörg Lohbrunner
Gerichtsstand: Amtsgericht Potsdam | HRB 20086 P | USt-IdNr.: DE 252 092 291
Bankverbindung: Evangelische Bank eG | IBAN: DE76 5206 0410 0008 0250 96 | BIC: GENODEF1EK1
Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e. V.
Ein Unternehmen im OBERLINHAUS
endocert
Im Verbund der
Diakonie $
15Q
OBERLINHAUS

T., Tilo - geb. am 31.12.2016
Klinischer Befund:
Siebenjähriger Junge. Wie gehabt sehr bewegungsmotiviert, läuft im Sprechzimmer umher und erkundet verschiedene Gegenstände. Dabei durchaus auch Einsatz der rechten Hand, je nach Bedarf. Ansonsten zieht der rechte Arm in eine Beugepronationsstellung, die er aber eigenaktiv korrigieren kann. Es wird vornehmlich die linke Hand benutzt.
Leichter Schultertiefstand rechts. Ansonsten aber freie Beweglichkeit in Schulter, Ellenbogen und Handgelenk. Aktive Supination nur bis etwa 20° möglich, dann mit Bewegung des gesamten
Rumpf mit leichter kyphotischer Haltungsinsuffizienz, eigenaktiv gut aufrichtbar. In Oberkörpervorneige keine gravierende Skoliose erkennbar.
Becken annähernd horizontal, kein Anhalt für gravierende Beinlängendifferenz.
Hüften und Knie weitestgehend frei beweglich. Rotationsdifferenz an beiden Hüften.
Außen-/Innenrotation rechts 30-0-70°, links 40-0-50°
Lokalbefund rechter Fuß:
Allenfalls dezente Spitz-Sicheleinstellung, Fußhebung pronierend auslösbar.
Dorsalextension , Sichelkomponente lässt sich mit wenig Kraft vollständig auflösen.
Im Stand gut aufgebautes Längsgewölbe.
Patella beidseits sicher zentriert.
Empfehlung/Procedere:
An der rechten Hand besteht weiterhin eine leichte Funktionsbeeinträchtigung. Somit sollte versucht werden, die Hand im Alltag viel einzusetzen. Funktionelle Verbesserungen werden ja nur durch repetitiven Einsatz der Hand zu erwarten sein. Für eine gezielte CIMT-Behandlung erscheint er uns mental noch nicht ausreichend stabil, hier könnte eine frühzeitige Frustration resultieren.
Am rechten Fuß besteht nach unserer Einschätzung weiterhin ein gutes Korrekturergebnis nach Achillessehnenverlängerung. Die milde Sichelkomponente korrigiert sich spontan unter Körperlast. Die Einwärtsrotationsführung des Fußes resultiert aus einer zu vermutenden Schenkelhalsantetorsion und wird durch Orthesen nicht zu beeinflussen sein. Hier weitere klinische Verlaufsbeobachtung

Für die weitere Lagerungsbehandlung zur Nacht verordnen wir heute eine unilaterale ADM-Schiene, die ihn dann dynamisch in die Korrekturstellung drückt. Ansonsten bitte Wiedervorstellung zur klinischen Verlaufskontrolle in etwa einem Jahr.
Inwieweit die Einschulung in eine Regelgrundschule für ihn erfreulich oder frustran verläuft, wird sich im Verlauf zeigen. Nach unserer Einschätzung kann er an allen sportlichen Betätigungen teilnehmen. Sicherlich werden bestimmte Übungen, die ein bimanuelles Arbeiten erforderlich machen, nicht möglich sein. Wir würden ihn dennoch jetzt nicht vom Sportunterricht befreien.
Wir bitten um Wiedervorstellung in einem Jahr.
Mit freundlichen Grüßen
Oberlinklinik gGmbH
Dr. med. Stefan Blume
Chefarzt
Kinder- und Neuroorthopädie
Ulrich Drohla
Oberarzt
Kinder- und Neuroorthopädie

OBERLIN KLINIK
Oberlinklinik gGmbH • Rudolf-Breitscheid-Straße 24 • 14482 Potsdam
Frau
Anne Mösch
FÄ für Kinder- und Jugendmedizin
Köpenicker Straße 29
15711 Königs Wusterhausen
Ansprechpartner
Dr. med. Stefan Blume
Chefarzt
Abteilung
Kinder- und Neuroorthopädie
Kontakt
Tel.: 0331 763-5742
Fax: 0331 763-5740
kinderorthopaedie@oberlinhaus.de
Unser Zeichen UD - BRIC
Datum 31.03.2025
以：
Familie
T., Tilo (M) - geb. am 31.12.2016, wohnhaft: Dorfstr. 25a in 15738 Zeuthen
Sehr geehrte Frau Kollegin,
wir berichten über Tilo, der am 24.01.2025 in unserer kinder-/neuroorthopädischen Sprechstunde vorgestellt wurde.
Diagnose:
Unilaterale, spastische Zerebralparese rechts (GMFCS II)
Z. n. FG 30. SSW (Arteria-Media-Infarkt links)
Schrumpfniere rechts nach Nierenvenenthrombose (V. a. AT3-Mangel)
Leichte Arm- und Handgebrauchsstörung rechts Residuelles Innenrotationsgangbild rechts

Z. n. z-förmiger Achillessehnenverlängerung 09/2021 mit jetzt guter Funktion bei noch residuellem Spitz-Sicheltonus
Dezente Beinlängendifferenz links -0,5 cm
Kyphotische Haltungsinsuffizienz (eigenaktiv korrigierbar)
Anamnese:
Siehe vorausgehende Berichte, zuletzt Vorstellung 19.04.2024.
Keine wesentliche Befundänderung. Die verordnete ADM-Schiene wurde jetzt zum Tagesgebrauch mit in die Schule gegeben. Dies sorgt dort verständlicherweise für Verwunderung.
Ansonsten weiterhin keine spezielle Fußfassung.
Er klagt nicht über Beschwerden.
Die rechte Hand zeigt weiterhin eine gewisse Gebrauchsstörung, wird jedoch bei Erfordernis auch eingesetzt.
Oberlinklinik gGmbH | Orthopädische Fachklinik | Rudolf-Breitscheid-Str. 24 | 14482 Potsdam
ende Cert
Tel.: 0331 763-4312 | Fax: 0331 763-4322 | info@oberlin-klinik.de | www.oberlin-klinik.de
Gesellschafter: Verein Oberlinhaus
Geschäftsführung: Thomas Neubauer, Alexander Mommert, Dr. med. Hansjörg Lohbrunner
Gerichtsstand: Amtsgericht Potsdam | HRB 20086 P | USt-IdNr.: DE 252 092 291
Im Verbund der Diakonie $
Bankverbindung: Evangelische Bank eG | IBAN: DE76 5206 0410 0008 0250 96 | BIC: GENODEF1EK1
Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e. V.
15G
OBERLINHAUS
Ein Unternehmen im OBERLINHAUS

OBERLIN KLINIK
Oberlinklinik gGmbH • Rudolf-Breitscheid-Straße 24 • 14482 Potsdam
Frau
Anne Mösch
FÄ für Kinder- und Jugendmedizin
Köpenicker Straße 29
15711 Königs Wusterhausen
Ansprechpartner
Dr. med. Stefan Blume
Chefarzt
Abteilung
Kinder- und Neuroorthopädie
Kontakt
Tel.: 0331 763-5742
Fax: 0331 763-5740
kinderorthopaedie@oberlinhaus.de
Unser Zeichen UD - BRIC
Datum 24.05.2024
Familie

T., Tilo (M) - geb. am 31.12.2016, wohnhaft: Dorfstr. 25a in 15738 Zeuthen
Sehr geehrte Frau Kollegin,
wir berichten über Tilo, der am 19.04.2024 in unserer kinder-/neuroorthopädischen Sprechstunde vorgestellt wurde.
Diagnose:
ICP nach FG 30. SSW (Arteria-Media-Infarkt links)
Unilaterale, spastische Zerebralparese rechts (GMFCS II)
Schrumpfniere rechts nach Nierenvenenthrombose (V. a. AT3-Mangel)
Leichte Arm- und Handgebrauchsstörung rechts Residuelles Innenrotationsgangbild rechts
Z. n. z-förmiger Achillessehnenverlängerung 09/2021 mit jetzt guter Funktion bei noch residuellem Spitz-Sicheltonus
Anamnese:
Siehe vorausgehende Berichte, zuletzt Sprechstunde 05/2023.
Tilo ist weiterhin frei mobil. Für Herbst ist jetzt die Einschulung in eine Regel-Grundschule vorgesehen. Hier bittet die Mutter um Einschätzung, inwieweit er am Sportunterricht teilnehmen kann. Sie berichtet, dass der rechte Fuß wieder einwärts rotiert und fragt nach Orthesenversorgung an. Es wird ansonsten über keine Beschwerden berichtet.
Aktuell sind keine spezielle Fußfassung und auch keine Lagerungsschienen mehr im Einsatz.
Physiotherapeutische Beübung ist geplant.
Oberlinklinik gGmbH | Orthopädische Fachklinik | Rudolf-Breitscheid-Str. 24 | 14482 Potsdam
Tel.: 0331 763-4312 | Fax: 0331 763-4322 | info@oberlin-klinik.de | www.oberlin-klinik.de
Gesellschafter: Verein Oberlinhaus
Geschäftsführung: Thomas Neubauer, Alexander Mommert, Dr. med. Hansjörg Lohbrunner
Gerichtsstand: Amtsgericht Potsdam | HRB 20086 P | USt-IdNr.: DE 252 092 291
Bankverbindung: Evangelische Bank eG | IBAN: DE76 5206 0410 0008 0250 96 | BIC: GENODEF1EK1
Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e. V.
Ein Unternehmen im OBERLINHAUS
endoCert
Im Verbund der
Diakonie 品
МНВ «КАОБМЕСНЫ:
15G
OBERLINHAUS

Klinischer Befund:
Siebenjähriger Junge. Wie gehabt sehr bewegungsmotiviert, läuft im Sprechzimmer umher und erkundet verschiedene Gegenstände. Dabei durchaus auch Einsatz der rechten Hand, je nach Bedarf. Ansonsten zieht der rechte Arm in eine

Beugepronationsstellung, die er aber eigenaktiv korrigieren kann. Es wird vornehmlich die linke Hand benutzt.
Leichter Schultertiefstand rechts. Ansonsten aber freie Beweglichkeit in Schulter, Ellenbogen und Handgelenk. Aktive Supination nur bis etwa 20° möglich, dann mit Bewegung des gesamten Armes.
Rumpf mit leichter kyphotischer Haltungsinsuffizienz, eigenaktiv gut aufrichtbar. In Oberkörpervorneige keine gravierende Skoliose erkennbar.
Becken annähernd horizontal, kein Anhalt für gravierende Beinlängendifferenz.
Hüften und Knie weitestgehend frei beweglich. Rotationsdifferenz an beiden Hüften.
Außen-/Innenrotation rechts 30-0-70°, links 40-0-50°
Lokalbefund rechter Fuß:
Allenfalls dezente Spitz-Sicheleinstellung, Fußhebung pronierend auslösbar.
Dorsalextension
+10/+20°
, Sichelkomponente lässt sich mit wenig Kraft vollständig auflösen.
Im Stand gut aufgebautes Längsgewölbe.
Patella beidseits sicher zentriert.
Empfehlung/Procedere:
An der rechten Hand besteht weiterhin eine leichte Funktionsbeeinträchtigung. Somit sollte versucht werden, die Hand im Alltag viel einzusetzen. Funktionelle Verbesserungen werden ja nur durch repetitiven Einsatz der Hand zu erwarten sein. Für eine gezielte CIMT-Behandlung erscheint er uns mental noch nicht ausreichend stabil, hier könnte eine frühzeitige Frustration resultieren.
Am rechten Fuß besteht nach unserer Einschätzung weiterhin ein gutes Korrekturergebnis nach Achillessehnenverlängerung. Die milde Sichelkomponente korrigiert sich spontan unter Körperlast. Die Einwärtsrotationsführung des Fußes resultiert aus einer zu vermutenden Schenkelhalsantetorsion und wird durch Orthesen nicht zu beeinflussen sein. Hier weitere klinische Verlaufsbeobachtung.
Für die weitere Lagerungsbehandlung zur Nacht verordnen wir heute eine unilaterale ADM-Schiene, die ihn dann dynamisch in die Korrekturstellung drückt. Ansonsten bitte Wiedervorstellung zur klinischen Verlaufskontrolle in etwa einem Jahr.
Inwieweit die Einschulung in eine Regelgrundschule für ihn erfreulich oder frustran verläuft, wird sich im Verlauf zeigen. Nach unserer Einschätzung kann er an allen sportlichen Betätigungen teilnehmen. Sicherlich werden bestimmte Übungen, die ein bimanuelles Arbeiten erforderlich machen, nicht möglich sein. Wir würden ihn dennoch jetzt nicht vom Sportunterricht befreien.
Wir bitten um Wiedervorstellung in einem Jahr.
Mit freundlichen Grüßen
Oberlinklinik gGmbH
Dr. med. Stefan Blume
Chefarzt
Kinder- und Neuroorthopädie
Ulrich Drohla
Oberarzt
Kinder- und Neuroorthopädie

110303-01440
Originalpapier nur, wenn dieser Hinweis in Gründruck erscheint
LAND BRANDENBURG

Landesamt für Soziales und Versorgung | PF 10 01 23 | 03001 Cottbus
Frau
Nadine Koppenhagen
Postfach 1361
15203 Frankfurt (Oder)
Landesamt
für Soziales und Versorgung
Schwerbehindertenrecht
Lipezker Str. 45
03048 Cottbus
GZ.: 10505048
GZ. bitte bei Rückantwort angeben!
Service-Nr: (0355) 2893-800
Fax:
(0331) 27548-4523
Internet:
www.lasv.brandenburg.de
service@lasv.brandenburg.de
Leitweg-ID für E-Rechnungen:
12-121096894459866-05
Umsatzsteuer-IdNr.: DE3436727226
Frankfurt (Oder), den 17. Dezember 2024
Jenny Andrea T., wohnhaft Dorfstr. 25 A, 15738 Zeuthen
Feststellungsbescheid
Sehr geehrte Frau T.,
auf den am 01.10.2024 eingegangenen Antrag ergeht folgende Entscheidung:
Der Grad der Behinderung (GdB) beträgt 30.
Ein höherer GdB konnte nicht festgestellt werden.
Sie gehören zum Personenkreis der Menschen mit Behinderungen.
Ein Schwerbehindertenausweis steht Ihnen nicht zu.
Diese Entscheidung ist wirksam ab 01.10.2024.
Begründung
Die Auswirkungen aller vorliegenden Gesundheitsstörungen und die damit verbundene Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben in der Gesellschaft bestimmen die Höhe des GdB (S
152 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch -SGB IX-).
Behinderungen sind nicht nur vorübergehende Funktionsbeeinträchtigungen, die auf einem regelwidrigen körperlichen, geistigen oder seelischen Zustand oder auf Sinnesbeeinträchtigungen beruhen und einen GdB von wenigstens 10 erreichen. Regelwidrig ist der Zustand, der nicht für das Lebensalter typisch ist. Als nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als 6 Monaten.
Liegen mehrere Beeinträchtigungen vor, so ist der GdB nach den Auswirkungen der Beeinträchtigungen in ihrer Gesamtheit unter Berücksichtigung ihrer wechselseitigen Beziehungen festzustellen (§ 152 Abs. 3 SGB IX). Rein rechnerische Methoden dürfen zur Bestimmung des GdB nicht angewandt werden.
Besucheranschriften
Lipezker Str. 45
Haus 6
03048 Cottbus

Robert-Havemann-Str. 4
15236 Frankfurt (Oder)
Zeppelinstr. 48
14471 Potsdam
Besuchszeiten
Nach vorheriger Terminabsprache
0355 2893-800
Telefonische Servicezeiten
Mo, Do 8 bis 12 und 13 bis 15 Uhr
Di 8 bis 12 und 13 bis 18 Uhr
Fr 8 bis 12 Uhr
tenthiat set 2009
odt bonfundonie

Ansprüche auf Zusatz Menschen oder eine Er nicht erworben.
Eine Bescheinigung
Mitteilunr
- 2 -
Zur Aufklärung des Sachverhaltes wurden erforderliche medizinische Unterlagen gemäß den Angaben im Antrag eingeholt. Soweit Unterlagen von Ihnen zur Verfügung gestellt worden sind, wurden sie ebenfalls berücksichtigt (§ 20 SGB X).
Grundlage der Entscheidung sind die Bewertungskriterien der Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV). Unter Einbeziehung unseres Ärztlichen Dienstes erfolgte eine Auswertung aller vorliegenden medizinischen Unterlagen.
Durch das Dezernat Schwerbehindertenrecht erfolgte die abschließende Würdigung der Schwerbehindertenangelegenheit anhand der gesetzlichen Bestimmungen.
Folgende Gesundheitsstörung wurde berücksichtigt:
- Psychische Störung (Depressive Störung).
Die Feststellung von Merkzeichen kommt nicht in Betracht, weil der GdB nicht wenigstens 50 beträgt.
Ausweisausstellung
Ein Ausweis steht Ihnen nicht zu, da der GdB nicht mindestens 50 beträgt und damit auch nicht die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch vorliegt.
Rechtsbehelf
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim
Landesamt für Soziales und Versorgung - Schwerbehindertenrecht - Lipezker Str. 45, Haus 6
03048 Cottbus
schriftlich, in elektronischer Form nach § 36a Absatz 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB I), schriftformersetzend nach § 36a Absatz 2a des Ersten Buches Sozialgesetzbuch und §
9a Abs. 5 des Onlinezugangsgesetzes oder zur Niederschrift zu erheben.
110303-01440
Hinweise
Ein Widerspruch per einfacher E-Mail entspricht nicht der gesetzlich geforderten Form.
Gleichstellung mit einem schwerbehinderten Menschen:

Behinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung (GdB) von 30 oder 40 haben die Möglichkeit, bei der Agentur für Arbeit die Gleichstellung mit einem schwerbehinderten Menschen zu beantragen. Ein derartiger Antrag ist jedoch nur dann begründet, wenn Erwerbsfähigkeit besteht und Sie infolge Ihrer Behinderung ohne Gleichstellung einen geeigneten Arbeitsplatz nicht erlangen können oder wenn Ihr derzeitiger Arbeitsplatz infolge der Behinderung gefährdet Gefährdungen Ihres Arbeitsplatzes aus sonstigen, z. B. betriebsbedingten Gründen, können nicht zu einer Gleichstellung mit einem schwerbehinderten Menschen führen.

gen gemäß den al worden sind
010108-01441
Originalpapier nur, wenn dieser Hinweis in Gründruck erscheint
Ansprüche auf Zusatzurlaub, unentgeltliche Beförderung, Altersrente für schwerbehinderte Menschen oder eine Erhöhung des Grades der Behinderung werden durch eine Gleichstellung nicht erworben.
Eine Bescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt ist beigefügt.
Mitteilungs- und Mitwirkungspflichten
Sie sind verpflichtet, uns folgende Änderungen mitzuteilen:
- Besserung oder Wegfall einer Gesundheitsstörung
- Feststellung einer Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) aufgrund eines anerkanntenArbeitsunfalles oder anerkannter Berufskrankheit durch eine andere DienststelleNamenswechsel
• Änderung der Wohnanschrift im Inland, Verzug ins Ausland
Änderung der Staatsangehörigkeit
• bei Ausländern und Staatenlosen: Entziehung oder Änderung des Aufenthaltsstatus
Mit freundlichen Grüßen
Landesamt für Soziales und Versorgung
Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

Bericht der Kindertagesstätte
Name des Kindes: geb :
T., Tilo
31.12.2016
Kita:
Kita „Kinderkiste"
Dorfstr.23
15738 Zeuthen
Tilo wird seit Januar 2023 in unserer Kindertagesstätte in einer altersgemischten Gruppe (2,5 - 5 Jahre) gemeinsam mit 27 Kindern betreut.
pädagogische Einschätzung des Kindes
a)
lebenspraktische Fähigkeiten
- Selbständigkeit
Fähigkeiten und Aufgabenverständnis im lebenspraktischen Bereich sind altersgerecht,
Alltagsabläufe bewältigt er nach Aufforderungen und situationsabhängig mit Begleitung (z.B. Offnen und Verschließen der Kleidung, An-und Auskleiden)

Motivation zur Einhaltung der Tischregeln (z.B. Sitzen, Besteckhaltung)
- hygienische Gewohnheitenwerden tätigkeitsbezogen mit Begleitung ausgeführtWC-nutzung mit Begleitung
- Selbstbestimmungäußert seine Wünsche und Bedürfnisse verbal, z.T. laut lässt Körperkontakt bereitwillig zu

b)
Sozial-emotionale Fähigkeiten
- Kontaktverhalten im sozialen Umfeld beobachtet intensivorientiert sich an Tätigkeiten und Handlungen der anderen Kinder kein Trotzverhaltenzufällige Kontakte mit anderen Kindern, keine feste Freundschaft hält Blickkontaktsehr offen, Distanzverhalten gegenüber fremden Personen nichtangemessen Kommunikation sehr mitteilungsfreudigAntworten in verschiedenen Wissensbereichen stehen häufig nicht im Zusammenhang zur Frage spricht Kinder u.a. Personen von sich aus an,

c)
- Äußerung seiner BedürfnisseAußerungen häufig nicht situationsentsprechend äußert sich verbal auffallend kleinkindhaft, Streben nach Aufmerksamkeit, reagiert ungeduldig
- Äußerung von Gefühlen verbalisiert Ängstenimmt Lob sehr offen an und erfreut sich daran Freude wird durch Lachen ausgedrückt gibt einfache Werturteile ab
- Motivation, Interesse, Verhaltensbeschreibung des Kindes zeigt wiederkehrende Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitätenin Lernsituationen anfangs bestrebt
- kann Handlungsabläufe im Alltag teilweise organisieren ;wirkt im Selbstwertgefühl herabgesetzt, traut sich in Lernsituationen wenig zu; Motivation für die Bewältigen der Aufgaben notwendig zeitweise abrufbare Leistungen im Bereichen Kognition (unzureichende, nicht altersgerechten Umweltkenntnisse; motorische Unruhe in Lernsituationen) ungeduldig bei Wartezeiten in der Gruppe (z.B. Gespräche im Morgenkreis)

sprachliche Fähigkeiten
- allgemeines Sprachverständnis in sozialen Situationen altersentsprechendes Sprach- und Aufgabenverständnisverständnis in Alltagssituationen
einfache Wörter und Satzstellungen müssen bei Lernangeboten angewendet werden
bei Lernaufgaben ist visuelle Darstellung vorteilhaft, mitunter orientiert er sich aktiv an den Handlungen Anderer hinterfragt wenn er Aufgaben nicht versteht
- sprachliche Äußerungen
Lautbildung /Artikulation sauber
Probleme bei der Anwendung grammatikalischer Regeln (z.B. Artikel, Pluralbildung, Konjugation)
Wortschatz unzureichend / nicht altersgerecht keine Anwendung sowie eingeschränktes Verständnis von Oberbegriffen spricht überwiegend in Wortgruppen, nach Aufforderung in Mehrwortsätzen berichtet einfach über Erlebnisse; räumlicher und zeitlicher Kontext nicht altersgerecht
bestätigt Berichte anderer Kinder mit „ ich auch" Sprechtempo angemessen erfragt Informationen

verbalisiert Bitte um Unterstützung; zeigt kooperative Herangehensweise
„Da musst du Geduld mit mir haben."
antwortet auf stark vereinfachte Fragen/ häufig nicht zielgerichtet
Lagebezeichnungen werden verstanden

d)
e)
- Sprechbereitschaft
kommuniziert gern Erfolge z.B. im lebenspraktischen Bereich führt Monologe und Dialoge in der Gruppe, zeigt wenig Phantasie z.B. bei Bildbeschreibungen
motorische Fähigkeiten
- Freude an Bewegung oder Bewegungsarmut gibt von sich aus an, die rechte Hand ist kaputt bewegungsfreudiges Kind, bei Gruppenaktivitäten individuelle Begleitungund Motivation erforderlichmotorische Unruhe
- Fortbewegung, Bewegungsübergänge auffälliges Gangbild, rechte Seite wird nachgezogen geht leicht vorgebeugt, fehlende Körpermitte allgemein im Bewegungsablauf verlangsamt
- Haltung und Tonus
- leichtes Zittern bei AnstrengungGleichgewichtsübungen mit UnterstützungFußstellung rechts auffälligrechte Hand wird nicht automatisch als Hilfshand genutzt/ fehlendeEinbeziehung der rechten Körperteile
- Bewegungsqualität im grob- und feinmotorischen Bereich kann Ball werfen, nutzt KinderdreiradStifthaltung und Führung links im 3-Punkt-Griff Nutzung der Schere ausschließlich mit Unterstützung, wirkt teilweiseunbeholfen, Hilfestellungen werden gut umgesetzt
- Bewegungsplanung, -anpassung, -dosierung, -durchführung gezielte Auge-Hand-Koordination eingeschränkt Hand-Hand-Koordination und Kreuzen der Körpermittellinie herabgesetzt Hüpfen beidseits mit erhöhter Muskelspannung, vom BewegungsablaufmöglichEinbeinsprung links (Ausweichbewegungen im Oberkörper erkennbar,keine Automatisierung)
Wahrnehmung
- AufmerksamkeitKonzentrations- und Aufmerksamkeitsspanne deutlich verkürzt auffällige Reizoffenheithäufige Methoden- und Materialwechsel notwendig Körperwahrnehmung, KörperschemaKörperbild und Körperschema unzureichend entwickeltZuordnung Körperteile (einschließlich Finger) und Benennung nicht detailliert (z.B. Arm= Hand)

f)
- Orientierung im Raumgute Orientierung in der KiTakennt alle Räumlichkeiten und bewegt sich sicher und selbständig in denRaumen
- Sehen und Hörenauditive Wahrnehmung unauffällig (z.B. kann ihm bekannte einfache Umgebungsgeräusche und Tiere differenzieren und teilweise benennen visuelle Wahrnehmung fraglich, da der Kopf bei Bearbeitung von
Aufgaben schräg gehalten wird
- Empfindlichkeiten
keine
kognitive Fahigkeiten

- Aufgabenverständnis
im lebenspraktischen Bereich gut bei routinemäßigen Abläufen aufmerksames Zuhören bei verbaler Vermittlung der Lernaufgaben, jedoch
eingeschränktes Aufgabenverständnis
individuelle Begleitung und Demonstration sind stets notwendig für die selbstständige Umsetzung der Inhalte
- Konzentrationwährend individueller Spielhandlung altersgerecht zeigt Ausdauer und kann sich ausreichend in reizarmer Umgebungfokussieren
- Merkfähigkeit
gibt Teile von Inhalte von Geschichten wieder,/ berichtet ansatzweise und kleinkindhaft von Erlebnissen mit sprachlichen Auffälligkeiten
kennt Lieder und Gedichte, gibt kurze Textteile wieder
- Differenzierungsfähigkeitbenennt erste Unterschiede und Gegensätze differenziert einfache Materialeigenschaften
- puzzelt gernbenennt sicher Farben und ordnet sie zu Formen : Kreis wird erkannt, Viereck und Dreieck unsicher
- Leistungsbereitschaftbenötigt viel Zuspruch, Motivation für neue Inhalte, lässt sich ermutigentraut sich selbst wenig zu)bevorzugt praktische Tätigkeiten
- Verständnis für mathematische Grundfunktionen zeigt Interesse an Zahlen (zählt sicher bis 13)simultanes Erfassen bis 4
einfaches Mengenverständnis „viel-wenig" Nachlegen von Formen gelingt bedingt

- Entwicklung von Lösungsstrategien, Analysieren, Übertragungsfähigkeit, Umweltwissen, Orientierungsfähigkeit benötigt aktive Unterstützung und Motivation bei der Lösungsfindung Umweltwissen nicht altersgerecht entwickelt einfache Ordnungssysteme z. B. Treppensteckbrett. bemerkt wiederkehrende Zusammenhänge aus dem Alltag
9)
Spielverhalten
- Spielebene, Spielumsetzung in Ansätzen Rollenspiel mit Kindern der Gruppe begleitet sein Spiel sprachlich bevorzugt Bausteine, nutzt Zusatzmaterial benötigt Zeit, um in sein Spiel zu finden hantiert viel mit Materialien
- soziales Spielverhalten in der Gruppebemüht sich aktiv um seine Einbeziehung in Spielgruppen keine feste Freundschaft, zufällige Spielkontakte zu einzelnen Kindern
- Selbständigkeitkann sich über einen längeren Zeitraum selbstständig beschäftigen (auch im didaktischen Bereich)
- Einhalten von Regeln
- impulsives Allgemeinverhalten kann Regeln und Absprachen im Alltag einhalten, wenn sievereinfacht, z.T. demonstriert und näher erläutert wurden sowie wiederkehrend sindim Spiel: - werden Tischregelspiele gemeinsam mit Erwachsenen genutzt
- finden erste Absprachen über Spielinhalte mit Kindern statt
Zusammenfassung
Aufgrund der Hemiparese der rechten Körperhälfte kommt es zu erheblichen Schwierigkeiten im motorischen Bereich sowie der Wahrnehmung.
Seine motorischen Fähigkeiten müssen verbessert und stabilisiert werden, der Wahrnehmungsbereich sowie seine Grundkenntnisse sollten erweitert werden.

Tilo zeigt ein geringes Selbstwertgefühl und kann sich nur unzureichend selbst einschätzen. Sein Ich-Gefühl muss gestärkt werden, er sollte befähigt werden eigene Bedürfnisse zu erkennen, angemessen zu benennen und relevant reagieren.
Empfehlung zu weiterführenden Maßnahmen
medizinische und heilpädagogische Diagnostik / Antrag Frühförderung in der Kita
04.0225
ausrocke
Datum, Unterschrift des Erstellers
Unterschrift der Personensorgeberechtigten

OBERLIN KLINIK
Oberlinklinik gGmbH • Rudolf-Breitscheid-Straße 24 • 14482 Potsdam
Frau
Dr. med. Jeannette Coutelle
Kinderärztin
Badstr. 32
13357 Berlin
Ansprechpartner
Dr. med. Stefan Blume
Chefarzt
Abteilung
Kinder- und Neuroorthopädie
Kontakt
Tel.: 0331 763-5742
Fax: 0331 763-5740
kinderorthopaedie@oberlinhaus.de
Unser Zeichen REB - BRIC
Datum 12.10.2022
Lebenshilfe gGmbH - SPZ; Herr Dr. med. Chr.
Michael; Ärztlicher Leiter; Blumberger Damm 158;12679 Berlin
T., Tilo (M) - geb. am 31.12.2016, wohnhaft: Dorfstr. 25a in 15738 Zeuthen
Sehr geehrte Frau Kollegin,
wir berichten über Tilo, der am 14.09.2022 in unserer kinder-/neuroorthopädischen Sprechstunde vorgestellt wurde.
Diagnose:
ICP nach FG 30. SSW
Arteria-Media-Infarkt links spastische Hemiparese rechts
Schrumpfniere links nach Nierenvenenthrombose dystone-teilkontrakte Arm- und Handgebrauchsstörung rechts
Gangstörung
Innentorsion rechte Hüfte
Arm- und Beinlängendifferenz
Antithrombin-III-Mangel
Arm- und Beinlängendifferenz rechts Zustand nach OP 14.09.2021:
Z-förmige Achillessehnen-Verlängerung, dorsales perilaterales Release bei vormals hochkontraktem Spitz-Supinationsfuß rechts.
Mechanische Irritation bei Vorhandensein eines Fadengranuloms im mittleren Narbenbereich nach z-förmiger Achillessehnenverlängerung und dorsalem peritalarem Release vom 14.09.2021

Oberlinklinik gGmbH | Orthopädische Fachklinik | Rudolf-Breitscheid-Str. 24 | 14482 Potsdam
Tel.: 0331 763-4312 | Fax: 0331 763-4322 | info@oberlin-klinik.de | www.oberlin-klinik.de
Gesellschafter: Verein Oberlinhaus | Geschäftsführung: Andreas Koch, Dr. med. Hansjörg Lohbrunner
Gerichtsstand: Amtsgericht Potsdam | HRB 20086 P | USt-IdNr.: DE 252 092 291
Bankverbindung: Evangelische Bank eG | IBAN: DE76 5206 0410 0008 0250 96 | BIC: GENODEF1EK1
Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e. V.
Ein Unternehmen im OBERLINHAUS
15C
OBERLINHAUS
Im Verbund der
Diakonies
Christliche Kliniken
Potsdam

T., Tilo - geb. am 31.12.2016
Anamnese:
Tilo wird heute erneut von seiner Mutter in unserer Sprechstunde vorgestellt. Die Mutter berichtet, dass Tilo die Unterschenkel-Nachtlagerungsschale im postoperativen Verlauf nicht toleriert habe. Das Gangbild sei unverändert, jedoch bemerke er gelegentlich Schmerzen im Bereich der Achillessehne. Hier sei eine Auffälligkeit im Bereich der Narbe erkennbar gewesen.
Dabei handele es sich um eine Erhebung der Narbe, die Tilo vor allem im Schuhwerk (höheres Schuhwerk) störe und regelmäßig für Schmerzen verantwortlich sei.
Nun wird eine entsprechende Abklärung gewünscht.
Klinischer Befund:
Gangbild auf der Ebene in Vollbelastung mit deutlich verkürzter Abrollphase rechts. Leichter
Zehenspitzenstand und -gang.
Beinachse physiologisch.
Beckengeradstand. Kein Rippenbuckel, keine Lendenwuist, Wirbeisäule im Lot.
Knie- und Hüftgelenke mit freier ROM.
Im Bereich des rechten Fußes zeigt sich am dorsalen Bereich der Narbe eine Hervorhebung von 0,5 x 1 cm. Hier ist eine derbe Resistenz tastbar. Diese ist nicht verschieblich und druckdolent, am ehesten ein Fadengranulom. Ansonsten ist die Narbe verschlossen und reizlos. In entspannter Situation bei Kniestreckung wird eine Dorsalextension von 15° erreicht. In Kniebeugung positiver Silfverskjöld-Test.
Procedere:
Wir haben den oben genannten Befund ausführlich mit Tilo bzw. seiner Mutter besprochen. Bei anhaltender mechanischer Irritation des Fadengranuloms im Bereich der rechten Narbe sehen wir die Indikation zur Entfernung des Granuloms. Aufgrund der Vorgeschichte mit Arteria-Media-Infarkt sowie spastischer Hemiparese ist hier ein ambulantes Setting nicht möglich. Die operative Intervention sollte stationär mit mindestens einer Übernachtung durchgeführt werden.

Aufgrund der guten Dehnung in Ruhe mit Dorsalextension von 15° sehen wir keine Indikation zur intraoperativen Gipsanlage. Im Vorfeld sollte (bei präoperativer Vorbereitung) ein Rezept für eine Unterschenkel-Nachtlagerungsschale mit Dorsalextension von 15° rechts ausgestellt werden. Am Tag der Wiedervorstellung in der Ambulanz kann dann der entsprechende Abdruck genommen werden, damit die Unterschenkel-Nachtlagerungsschale für den postoperativen Verlauf bereits vorhanden ist.
Wir führten erstmalig eine ausführliche Aufklärung durch. Die Mutter ist mit dem Procedere einverstanden.
Mit freundlichen Grüßen
Oberlinklinik gGmbH
Dr. med. Stefan Blume
Chefarzt
Kinder- und Neuroorthopädie
Dr. med. Rasmus Ebel
FA f. Orthopädie/Unfallchirurgie Kinder- und Neuroorthopädie

OBERLIN KLINIK
Oberlinklinik gGmbH • Rudolf-Breitscheid-Straße 24 • 14482 Potsdam
Frau
Nora Koch
Teterower Ring 48
12619 Berlin
Abteilung:
Kinder- und Neuroorthopädie
Chefarzt Dr. med. Stefan Blume
Kinderorthopädie:
Telefon: 0331 763-5742
Fax: 0331 763-5740
kinderorthopaedie@oberlinhaus.de
Datum: 08.11.2022
Station A
vorlaufiger
endgültiger Entlassbrief
T., Tilo (M) - geb. am 31.12.2016, wohnhaft: Dorfstr. 25a in 15738 Zeuthen
Sehr geehrte Frau Kollegin,
Wir berichten über o. g. Patient, der sich vom 07.11.2022 - 08.11.2022 in unserer stationären Behandlung befand.
Diagnosen:
Hypertrophie des Peritendineums bei subcutanem Fadengranulom nach Achillessehnenverlängerung in Wundmitte rechts bei Spitzfuß 09/2021
Nebendiagnose(n):
ICP nach FG 30. SSW
Arteria-Media-Infarkt links spastische Hemiparese rechts
Schrumpfniere rechts nach Nierenvenenthrombose
Frgl. AT3-Mangel
dystone-teilkontrakte Arm- und Handgebrauchsstörung rechts
Gangstörung

Innentorsion rechte Hüfte hochkontrakter Spitz-Supinationsfuß rechts Arm- und Beinlängendifferenz
Therapie:
Resektion des Granuloms und partielle Resektion des hypertrophen Peritendineums mit Naht des Peritendineums und primärem Wundverschluss (intracutan resorbierbar)
Datum
07.11.2022
Oberlinklinik gGmbH | Orthopädische Fachklinik | Rudolf-Breitscheid-Str. 24 | 14482 Potsdam
Tel.: 0331 763-4312 | Fax: 0331 763-4322 | info@oberlin-klinik.de | www.oberlin-klinik.de
Gesellschafter: Verein Oberlinhaus | Geschäftsführung: Thomas Neubauer, Dr. med. Hansjörg Lohbrunner
Gerichtsstand: Amtsgericht Potsdam | HRB 20086 P | USt-IdNr.: DE 252 092 291
Bankverbindung: Evangelische Bank eG | IBAN: DE76 5206 0410 0008 0250 96 | BIC: GENODEF1EK1
Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e. V.
Ein Unternehmen im OBERLINHAUS
15C
OBERLINHAUS
Im Verbund der Diakonie E
endoCert
Christliche Klinik
Potsdam

T., Tilo (M) - geb. am 31.12.2016
Grund der Aufnahme:
Zur Vorgeschichte verweisen wir freundlicherweise auf die vorangegangene Korrespondenz. Tilo beklagt Schmerzen im Bereich des OP Gebietes, so dass Lagerungsschalen nicht toleriert worden. Nun erfolgte die stationäre Aufnahme zur operativen Intervention bei oben genannter Diagnose.
Aufnahmebefund:
Gangbild auf der Ebene in Vollbelastung mit deutlich verkürzter Abrollphase rechts. Leichter
Zehenspitzenstand und
Beinachse physiologisch.
Beckengeradstand.
Rippenbuckel, keine Lendenwulst, Wirbelsäule im Lot. Knie- und Hüftgelenke mit freier ROM.
Im Bereich des rechten Fußes zeigt sich am dorsalen Bereich der Narbe eine Hervorhebung von 0,5 x 1 cm. Hier ist eine derbe Resistenz tastbar. Diese ist nicht verschieblich und druckdolent, am ehesten ein Fadengranulom. Ansonsten ist die Narbe verschlossen und reizlos. In entspannter Situation bei Kniestreckung wird eine Dorsalextension von 15° erreicht. In Kniebeugung positiver Silfverskjöld-Test.
Verlauf: Nach entsprechender Vorbereitung und Aufklärung konnte am 07.11.2022 die o.g.

Operation problemlos erfolgen. Tilo konnte mit physiotherapeutischer Anleitung unter schmerzadaptierter
Vollbelastung
remobilisiert
Die postoperative
Schmerzsymtomatik war schnell regredient. Die Wunden heilten primär und reizlos.
Zum Entlassungszeitpunkt ist Tilo auf der Ebene und der Treppe frei mobilisiert.
Entlassungsbefund: Wunden reizlos, trocken, DMS intakt. Freie Mobilisation auf der Ebene und der Treppe. Abdrücke für Lagerungsschalen wurden genommen.
Medikation bei Entlassung:
Novamin 250mg
1-1-1-1 bei Bedarf
Prozedere: Wir empfehlen Wundkontrollen, die Steristrips sollen für 14 Tage postoperativ belassen werden, die Entfernung des Nahtmaterials entfällt bei Resorbierbarkeit.
Mobilisation bis zur schmerzadaptierte Vollbelastung weiter steigern, Schonen für 3 Wochen bis zur Wundheilung empfohlen, Vermeiden von Spitzenbelastungen für 4 Wochen.
Des weiteres bitten wir um weitere Dehnungsbehandlung der Achillessehne.
Weiterhin bitten wir um Wiedervorstellung am 24.11.2022 um 14.30 Uhr zur Wundkontrolle und Anpassen der Lagerungsschalen.
Nachfolgende Versorgungseinrichtung: Ihre und unsere Ambulanz. Entlassung in die Häuslichkeit.
Bei Wiedervorstellung bringen Sie bitte einen gültigen Uberweisungsschein von Ihrem niedergelassenen Arzt mit.

OBERLIN KLINIK
Oberlinklinik gGmbH • Rudolf-Breitscheid-Straße 24 • 14482 Potsdam
Frau
Nora Koch
Kinder- und Jugendärztin
Teterower Ring 48
12619 Berlin
Ansprechpartner
Dr. med. Stefan Blume
Chefarzt
Abteilung
Kinder- und Neuroorthopädie
Kontakt
Tel.: 0331 763-5742
Fax: 0331 763-5740
kinderorthopaedie@oberlinhaus.de
Unser Zeichen UD - BRIC
Datum 15.12.2022
区 :
Familie
T., Tilo (M) - geb. am 31.12.2016, wohnhaft: Dorfstr. 25a in 15738 Zeuthen
Sehr geehrte Frau Kollegin,

wir berichten über Tilo, der am 25.11.2022 in unserer kinder-/neuroorthopädischen Sprechstunde vorgestellt wurde.
Diagnose:
Persistierende Schwellung über Achillessehne trotz Granulomausschneidung am 07.11.2022
ICP nach FG 30. SSW
Arteria-Media-Infarkt links spastische Hemiparese rechts
Schrumpfniere rechts nach Nierenvenenthrombose
Frgl. AT3-Mangel
dystone-teilkontrakte Arm- und Handgebrauchsstörung rechts
Gangstörung
Innentorsion rechte Hüfte hochkontrakter Spitz-Supinationsfuß rechts Arm- und Beinlängendifferenz
Hypertrophie des Peritendineums bei subkutanem Fadengranulom nach Achillessehnenverlängerung in Wundmitte rechts bei Spitzfuß 09/2021
Anamnese:
Bei Zustand nach Spitzfuß-OP vor 1½ Jahren war es im Bereich der Achillessehne zu einem Fadengranulom gekommen. Hier bestand eine etwa erbsengroße Schwellung. Hier hatten wir vor etwa 2½ Wochen eine Ausschneidung an Parthenon und Achillessehne vorgenommen.
Heutige Wiedervorstellung erfolgt zur klinischen Befundkontrolle.
Oberlinklinik gGmbH | Orthopädische Fachklinik | Rudolf-Breitscheid-Str. 24 | 14482 Potsdam
Tel.: 0331 763-4312 | Fax: 0331 763-4322 | info@oberlin-klinik.de | www.oberlin-klinik.de
Gesellschafter: Verein Oberlinhaus | Geschäftsführung: Thomas Neubauer, Dr. med. Hansjörg Lohbrunner
Gerichtsstand: Amtsgericht Potsdam | HRB 20086 P | USt-IdNr.: DE 252 092 291
Bankverbindung: Evangelische Bank eG | IBAN: DE76 5206 0410 0008 0250 96 | BIC: GENODEF1EK1
Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e. V.
15G
OBERLINHAUS
endoCert
Ein Unternehmen im OBERLINHAUS
Im Verbund der Diakonie E
Christliche Kliniken
Potsdam

Ver der zur
lit fr berl
ne ara
١٢٠
Klinischer Befund:

OP-Narbe selbst ist reizlos geschlossen. Im Bereich des vormaligen Granuloms besteht weiterhin eine ca. 2 x 1 cm große Schwellung. Diese scheint harmonisch spindelförmig von der Achillessehne auszugehen. Hier besteht kein wesentlicher Druckschmerz.
Tilo läuft dennoch frei. Die Schuhe üben hier keine Scheuerreizung aus.
Procedere:
Zweieinhalb Wochen nach Operation würden wir zunächst den Spontanverlauf noch beobachten.
Wir gehen zunächst davon aus, dass es sich um noch einen perioperativen Reizzustand handelt, möglicherweise auch Rest-Hämatom. Sollte sich der Befund nicht innerhalb von zwei bis drei Monaten bessern, bitte noch einmal Vorstellung bei uns. Ansonsten planen wir eine Wiedervorstellung in einem halben Jahr. Hierzu wurde heute bereits ein Termin vereinbart:
22.05.2023 um 12.30 Uhr. Bitte erneut aktuelle Uberweisung mitgeben.
Übrige Therapie und Anwendung der Hilfsmittel wie gehabt.
Mit freundlichen Grüßen
Oberlinklinik gGmbH
Dr. med. Stefan Blume
Chefarzt
Kinder- und Neuroorthopädie
ти
Ulrich Drohla
Oberarzt
Kinder- und Neuroorthopädie

damit jeder dazu gehört
Lebenshilfe gGmbH • Blumberger Damm 158 • 12679 Berlin
Frau
Nora Koch
Teterower Ring 48
12619 Berlin
0 Lebenshilfe
BERLIN
Kinder- und Jugendambulanz/ Sozialpädiatrisches Zentrum
Marzahn der Lebenshilfe gGmbH Blumberger Damm 158
12679 Berlin
Fon 030. 542 90 37
Fax 030. 541 40 75
spz.marzahn@lebenshilfe-
berlin.de
www.lebenshilfe-berlin.de
Berlin, den 16.03.2022
Tilo T., geb. am 31.12.2016
Logopädischer Wiederholungsbefund
Logopädische Diagnose: asynchrone Sprachentwicklungsstörung auf syntaktisch-morphologischer Ebene
angewendeter Test: Patholinguistische Diagnostik bei SES
Testdatum: 05.03.2020, 12.03.2020

04.03.2022
Lebensalter: 3 Jahre 2 Monate
5 Jahre 2 Monate
Norm: T-Wert 40-60
100
70
T-Wert
57
54
748
44
40
30
20
17
Wortverstandnis Verben
Wortoroduktion Verben
Wortverstandnis Nomen
Wortproduktion
Nomen
017
0-45-
Wortverständnis Adjektive
Wortverstandnis Prapositionen
Begriffsklassifik. Zielbilder korrekt
Begriffsklassifik. Ablenker korrekt
W-Fragen
Unika
Plural
Akkusativ / Dativ
Lebenshilfe gGmbH Heinrich-Heine-Straße 15
10179 Berlin
Vorsitzender des Aufsichtsrates
Ludger Gröting
Geschäftsführer
Erik Friedrich, Falk Jarling
Bank für Sozial-wirtschaft
Konto 31 434 00
BLZ 100 205 00
BIC: BFSWDE33BER
IBAN: DE67100205000003143400
Steuer-Nr. 27/028/31598
Handelsregister
Charlottenburg
HRB 44109 B

T-Wert
Phonemdifferenzierung
Wortproduktion Nomen

Wortproduktion Verben
Wortverständnis Nomen
62
Wortverständnis Verben
54
Wortverständnis Adjektive
Wortverständnis Präpositionen
Begriffsklassifik. Zielbilder korrekt
017 045
8 48
I--56:
Begriffsklassifik. Ablenker korrekt
W-Fragen
Unika
13
Plural
17
Akkusativ / Dativ
100
4
54
Norm: T-Wert 40-60

- Seite 2 -
1. Artikulation:
→ Motilität: leicht eingeschränkte Zungen- und Lippenkraft und -koordination
→ phonologische Auffälligkeiten: nein
→ phonetische Auffälligkeiten: nein
2. Wortschatz:
→ rezeptiver Wortschatz: unauffällig
→ produktiver Wortschatz: unauffällig
3. Grammatik:
→ Syntax: Satzlänge / -struktur: HS, NS, MWA → Morphologie: Auffälligkeiten in der Pluralbildung, V2 nicht sicher erworben → Verständnis für syntaktische Strukturen: unauffällig
4. Kommunikationsverhalten:
→ Turn-taking: unauffallig
→ non-verbales Kommunikationsverhalten: unauffällig
→ Schwierigkeiten in der Gestaltung von Gesprächssituationen: nein
Zusammenfassung:
Die logopädische Diagnostik fand alleine in der Integrationseinrichtung mit einer ihm bekannten Therapeutin statt. Tilo verhielt sich offen, sehr unkonzentriert und ablenkbar, sowie motorisch unruhig. Insgesamt ergibt sich eine asynchrone Sprachentwicklungsstörung auf syntak-tisch-morphologischer Ebene.
Es ist derzeit keine logopädische Therapie auf Grund oben beschriebener Verhaltensauffälligkeiten durchführbar. Es findet eine Beratung und Übungsanleitung der KE und der Erzieher statt. Die logopädische Diagnostik und ggf. Indikation für

eine Therapie soll im III. Quartal wiederholt werden. Überdies ist eine psychologische Diagnostik geplant.
Tilo erhält Physiotherapie über das SPZ Marzahn. Die externe Ergotherapie nehmen die ke nicht mehr wahr.
Dr. med. C. Michael
FA für Kinder- u. Jugendmedizin FA für Kinder- u. Jugendpsychiatrie
Leiter des SPZ
Janina Walter
Logopädin

damit jeder dazu gehört
© Lebenshilfe
BERLIN
Lebenshilfe Berlin • Blumberger Damm 158 • 12679 Berlin
Frau
Nora Koch
Teterower Ring 48
12619 Berlin
Kinder- und Jugendambulanz
Sozialpädiatrisches Zentrum
Marzahn der Lebenshilfe gGmbH Blumberger Damm 158
12679 Berlin
Fon 030. 542 90 37
Fax 030. 541 40 75
spz.marzahn@lebenshilfe-
berlin.de
www.lebenshilfe-berlin.de
Berlin, den 27.06.2022
Tilo T., geb. am 31.12.2016
Ergotherapeutischer Befund
Testdaten: MOT und COPM: 09.05.2022; FEW und COPM: 21.06.2022
Allgemeine Beobachtungen:
Tilo kam in Begleitung seiner Eltern zur motorischen Überprüfung (MOT) und mit seiner Mutter in den Raum. Er nahm ohne Probleme Kontakt auf, hatte ein adäquates Nähe-Distanz-Verhalten. Er konnte sagen, dass er 5 Jahre alt ist und dies mit seinen Fingern zeigen. Im Raum angekommen wollte er gleich und im weiteren Verlauf häufiger, seinen hohen Bewegungsdrang ausleben. Trotzt seiner leichten Hemiparese rechts scheint er viel Freude daran zu haben. Über den Plan konnte er gut reguliert werden, musste allerdings immer wieder aufgefordert werden, darauf zu schauen und ihn zu nutzen. Sein Aufgabenverständnis war meist gegeben. Zuhören und Abwarten fiel ihm sichtlich schwer. Teils agierte er voreilig und hektisch. Eine Korrektur seiner Handlungen nahm er nur ungern an, reagierte mit Entzug und Verweigerung. Die Mutter lobte ihn dann immer wieder für seine tolle Bereitschaft, überhaupt mitzumachen. Daher gelang ihm die Durchführung bis zum Ende. Tilo malte auf den Proto-kollbogen seinen Namen. Er konnte ohne Probleme bis 10 abzählen. Seine rechte Hand setzte er häufig ein, nicht nur zum Halten. Das Kreuzen der Körpermitte ist ihm gut möglich.

Aufgrund seiner Hemiparese hat er Probleme im Gleichgewicht, beim Rennen, Springen und Hüpfen sowie Greifen. Viele Bewegungen verlaufen langsam, teilweise auch bedacht.
Im Anschluss erfolgte ein Gespräch mit der Mutter (COPM). Tilo fiel es ausgesprochen schwer, sich selbst zu beschäftigen. Er störte immer wieder unser Gespräch, an Absprachen hielt er sich kaum.
Zur Überprüfung der Visuellen Wahrnehmung (FEW) kam Tilo in Begleitung seiner Mutter nach langer Pause zum Folgetermin. Der Umzug der Familie ist erfolgt. Die Mutter schien sehr gestresst und fühlte sich mit allem allein gelassen. Die allgemeine Hitze, der lange An-fahrtsweg und der übermüdete jüngere Bruder Tilos verstärkten dies. Trotzdem blieb sie erst einmal im Raum und schaute Tilo zu. Alsbald musste sie sich um den Kleinen kümmern, da er ziellos im Raum umherlief. Trotzdem war Tilo in der Lage, sich auf die Aufgaben einzulas-sen. Sein Aufgabenverständnis war gegeben, er hörte zu und wartete ab. Die Menge 4 an der Hand erkannte er bedingt, musste sie einzeln an seinen Fingern abzählen. Begriffe wie

oben/unten oder auch Mitte sind ihm bekannt. Konkrete und klar strukturierte Aufgaben schienen ihm zu liegen. Aufgrund seiner leichten Hemiparese rechts konnte er die Blätter nicht gut fixieren. Daher bekam er diesbezüglich leichte Unterstützung. In der Pause wollte er spielen. Dies verlief anfangs genauso chaotisch wie bei seinem Bruder. Um Ruhe in die Situation zu bringen, blieb Tilo dann allein im Raum, sodass wir den Test zügig beendeten.
Während der Auswertung des Testes spielte Tilo mit Magnetstäben und bekam einen konkreten Auftrag. Dies erfolgte dann relativ selbstständig. Während es Gespräches mit der Mutter konnte er sich dagegen nur schwer zurückhalten.
MOT:
- konnte sicher vorwärts balancieren, schnell Punkte malen, Zielwerfen auf eine Scheibe sicher, durch einen Reifen steigen
- hatte ein leicht reduziertes Reaktionsvermögen, eine mäßige Sprungkraft, konnte kurzzeitigKörperspannung aufnehmen

- es fiel ihm schwer, mit den Füßen ein Tuch hochzuheben, koordinierte Bewegungen oder mit Richtungswechsel auszuführen, Arbeitstempo und Bewegungsgeschwindigkeit stark verzögert, statische Gleichgewicht erschwert, etwas Auffangen nur bedingt möglich, Körperspannung halten erschwert

Mit dem T-Wert von 37 befindet sich seine motorische Entwicklung knapp unterhalb seiner
Altersnorm.

COPM:

Tilo hat eine Hemiparese rechts mit leichter Ausprägung. Er benutzt die Hand häufig, da er Rechtshänder ist. Sie ist funktionell und taktil eingeschränkt einsetzbar, Kraftdosierung ist bedingt möglich.

Selbstversorgung:

- kann sich allein und richtig herum an- und ausziehen, rechte Seite benötigt er unterstützend, grobe Verschlüsse kann er bedienen
- Toilettengang Hilfe bei der Hose nötig, Hände waschen selbstständig, Duschen mit Beaufsichtigung, Zähne putzen mit Unterstützung, dosiert Zahnpaste selbstständig
- Umgang mit Besteck möglich, schneidet Obst/Gemüse, dabei Messer rechts
- Tagesablauf bekannt, wenig Unterstützung nötig, Abendritual und Nachtruhe problemlos
- hilft im Haushalt, bringt z. B: Müll weg und deckt Tisch
- räumt sein Zimmer auf Produktivitat:
- kennt Gruppenregeln und halte sie ein
- ungeduldig bei Zuhören und Abwarten
- motorisch unruhig
- malt und schneidet gerne, basteln weniger
- spielt gern Brett- und Würfelspiele, kennt die Regeln
- gern Puzzle, auch mit Autos und Eisenbahn
- baut und konstruiert gern, mag Rollenspiele Freizeit:
- malt und bastelt, schaut gern Bücher an
- auch Medien, im Winter mehr als im Sommer, max. 30 Minuten, KM möchte es meiden
- draußen gern und viel, rennen und Ballspielen, in der Natur bewegen gern springen, schaukeln, rutschen, mit Hilfestellung klettern

- fährt Roller und Laufrad, Fahrrad mit Stützrädern
- Sportverein noch nicht, Empfehlung schwierig, geringe Frustrationstoleranz, aufgrund Hemiparese nicht so leistungsfähig Soziales Leben (Familie, Freunde, Kontakte knüpfen):

Tilo lebt mit seinem jüngeren Bruder (2) und der älteren Schwester (6) sowie vorrangig seiner Mutter in einem Haushalt. Der Vater scheint trotzdem eine große Rolle zu spielen, inwiefern eine räumliche Trennung vorliegt, ist unklar. Es erfolgte aktuell ein Umzug nach Hohen-schönhausen, es gibt weiterhin 2 Hasen in der Familie. Tilo kann Kontakte knüpfen und hat
Freunde.

Tilo ist sehr begeisterungsfähig und offen für Neues. Er beobachtet und merkt sich viel, interessiert sich für Natur und alles was elektrisch ist. Er hilft gern, ist aufmerksam und kann trösten.
FEW:

%	Auge-Hand	Raum-Lage	Co-pieren	Figur-Grund	Räuml.-Beziehung	Gestalt-schliessen	Visuo-mot-Geschw.	Form-konstanz	Gesamt	Motor redu-	Motor. Integriert	MOT 4-6 T-Wert
91												
84												
75												
63												
50												
37					X							
25										27		
16												
9									14		10	37

- Stifthaltung erfolgte mit links vorrangig im Drei-Punkt-Griff, fixierte aufgrund der Hemiparese nur mäßig das Blatt, je komplexer die Aufgabe, umso höher der Stiftaufdruck, demnach weniger Fixierung möglich, versuchte innerhalb der Spur zu bleiben
- die gleiche Lage von Figuren erkannte er nur bedingt wieder, zeigte häufig spiegelverkehrtes Bild
- Nachzeichnen gelang bedingt, konnte gerade Linien, + und O malen, •, X und A gelangen noch nicht
- übereinanderliegende Formen konnte er sehr sicher wiedererkennen, unterschied dabei auch bedingt ähnliche Formen wie O/O oder */*
- Punkte verbinden nach Vorlage gelang, schwierig bei diagonalen Linien, erkannte Fehler, korrigierte sie bedingt, traf nicht sicher den Anfangspunkt, wollte teils spiegelverkehrt malen
- eine Figur gedanklich zu vollenden gelang bedingt
- auf Tempo malen erschwert, fühlte sich von den vielen Formen unter Druck gesetzt, bemalte 4 Formen, alle Linien über den Rand hinaus
- Formen in veränderter Darstellung wiedererkennen gelang nur malig Der Gesamtwert befindet sich knapp unterhalb seines Altersnormbereiches.

Der motorisch reduzierte Bereich (nur Zeigen) fällt dabei deutlich besser aus als der Bereich der visuell motorischen Integration (Zeichnen mit dem Stift).
Er hat eine besondere Stärke in dem Bereich „Figur-Grund-Unterscheidung" und leichte Schwächen in den Bereichen „Lage im Raum", „Kopieren" und

„Visuomotorische Geschwin-digkeit*.

sat ist unbar euerteme groise Kolle zu spielen, inwie-
fern eine räumliche Trennung vorliegt, ist unklar. Es erfolgte aktuell ein Umzug nach Hohen-schönhausen, es gibt weiterhin 2 Hasen in der Familie. Tilo kann Kontakte knüpfen und hat
Freunde.
Tilo ist sehr begeisterungsfähig und offen für Neues. Er beobachtet und merkt sich viel, interessiert sich für Natur und alles was elektrisch ist. Er hilft gern, ist aufmerksam und kann trösten.
FEW:

									Ge-	Motor	Motor.	MOT
	Auge-Hand	Raum-Lage	Co-pieren	Figur-Grund	Rauml.-Bezie-hung	Gestalt-schliessen	Visuo-mot-Geschw.	Form-konstanz	samt	reduziert	Integriert	4-6 T-Wert
91												
84												
75												
63												
50												
37										27		
25											10	37
16									14			

- Stifthaltung erfolgte mit links vorrangig im Drei-Punkt-Griff, fixierte aufgrund der Hemiparese nur mäßig das Blatt, je komplexer die Aufgabe, umso höher der Stiftaufdruck, demnach weniger Fixierung möglich, versuchte innerhalb der Spur zu bleiben
- die gleiche Lage von Figuren erkannte er nur bedingt wieder, zeigte häufig spiegelverkehrtes Bild
- Nachzeichnen gelang bedingt, konnte gerade Linien, + und O malen, I, X und 4 gelangen noch nicht
- übereinanderliegende Formen konnte er sehr sicher wiedererkennen unterechied dobei

1 Chlar

Tilo T., geb. am 31.12.2016
Seite 4
Ergebnis: Die Mutter wünscht sich noch Unterstützung für Tilo in der Selbstversorgung beim Wechseln der Bekleidung, insbesondere der Hosen. Das größte Problem für sie sind die Anwendung der Schienen und Orthesen. Es kommt zu Diskussionen, da Tilo sie ablehnt, sogar versteckt. Er sieht sie weniger als Unterstützung, eher als Belastung an, daher fehlt ihm die Motivation, sie zu tragen. Aus der Beobachtung haben sich weiterhin Probleme in der Konzentration und Aufmerksamkeit ergeben, zuhören und abwarten fallen ihm schwer, bei klar strukturierten Aufgaben gelingt es ihm deutlich besser. Aufgrund seiner Hemiparese kommt es zu den typischen Aus-fallerscheinungen, die aber bei Tilo eher gering ausgeprägt sind. Seine rechte betroffene Seite setzt er aktiv im Alltag ein, diesbezüglich benötigt er wenig zusätzliche Aufforderung.
So half er am Ende der Stunde beim Entfernen des Sandes, den er aus den Schuhen gekippt hatte. Das Benutzen von Handfeger und Schaufel erfolgte zielgerichtet, schien bekannt.
Es besteht Förderbedarf im visuellen Wahrnehmungsbereich, Hand-Hand-Koordination und Feinmotorik. Klare Strukturen und Vorgaben sind sinnvoll, um die Konzentrationsfähigkeit und Ausdauer zu verbessern. Die Therapie kann im SPZ angeboten werden und ist von der Mutter gewünscht. Aus unserer bisherigen Erfahrung heraus wird die Umsetzung aufgrund des Fahrtweges wahrscheinlich schwierig werden. Die Mutter lehnt momentan eine externe Betreuung ab.
Dr. C. Michaeh
FAf. Kinder- u. Jugendmedizin FA f. Kinder u. Jugendpsychiatrie
Leiter der Ambulanz
I. Elstner
Fachergotherapeutin f. Pädiatrie

Charité I Campus Virchow-Klinikum I 13344 Berlin
Frau Dr. F. Temmler
FA f. Kinder-u. Jugendmedizin
Teterower Ring 48
12619 Berlin
Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)
für chronisch kranke Kinder
Leitung: Prof. Dr. Angela M. Kaindl
Abteilung Neuropädiatriel
Entwicklungsneurologie/Neonatologie
Komm. Leitung: Dr. Katrin Drossel
Tel.
Fax.
+49 (0)30 450 566 408
+49 (0)30 450 566 911
spz-neuropaediatrie@charite.de
spz.charite.de
Datum: 22.08.2018 / kr Fall-Nr.: 0312128478
Qualität und Entwicklung in Praxen*

Nachrichtlich:
* Familie T., Torgauer Str. 47, 12627 Berlin

Diagnosen:		
Achse 1:	Somatische Diagnosen:	
	Eutrophes FG, 30 + 3 SSW, GG 1.470 g	(P07.3G, P07.11G)
	Z. n. AT3-Mangel	
	Nierenvenenthrombose links	(P29.8G)
	Schrumpfniere links	
	V.a. renalen Hypertonus	
	Infarkt der Arteria cerebri media links	(163.5G)
	Hemiparese rechtsseitig	(G81.1G)
	Knick-Senkfuß rechts, verdecktem Spitzfuß	
	Mikrocephalie	(Q02.0G)
Achse 2:	Intelligenz/Entwicklung:	
	Motorische Entwicklungsstörung	(F82.9G)
	Achse 3: Psychiatrisch/psychologische Diagnosen:	nicht vergeben
	Achse 4: Psychosozialer Hintergrund:	nicht vergeben

Betr.:
T., Tilo, *31.12.2016 wohnh.: Torgauer Str. 47, 12627 Berlin
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, wir berichten Ihnen über o.g. Jungen, der uns am 17.08.2018 mit korrigiert 1 Jahr und 5 Monaten in der SPZ-Abteilung Neuropädiatrie vorgestellt wurde.
Zwischenanamnese: Die Kindsmutter ist mit der Entwicklung des Kindes zufrieden. Tilo zeigt eine dezente Beeinträchtigung der rechten Körperhälfte.
Grobmotorik: Krabbeln seit April 2018 (13 Monate), rechte Hand gefaustet, linke Hand offen, Hochziehen zum Stand April 2018. Seitschritte an Möbeln aktuell, er schiebt Stühle und Kisten vorwärts, läuft mit Fußinnenrandbelastung. Will gern über Dinge klettern, rechter Fuß überwiegend in Innenrandbelas-tung, geht vom Stand zum Boden herunter.
Therapien: Physiotherapie pausiert, letztes Rezept ging bis Mai 2018.
Kita: Ab 1.10.2018 ist eine Eingewöhnung in die Kita vorgesehen, I-Status A wird beantragt.
Sprachentwicklung: Worte: aua, Mila, nein, Mama, Papa, gutes Sprachverstehen.

Spielentwicklung: er spielt schön und ausdauernd, steckt Ringe auf einen Stab. Räumt Dinge aus und ein, steckt Förmchen.
CHARITÉ - UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN
Gliedkörperschaft der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin
Augustenburger Platz 1 | 13353 Berlin | Telefon +49 30 450-50/ www.charite.de

Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) für chronisch kranke Kinder
Fortsetzung Arztbrief:
T., Tilo, geb. 31.12.2016
2
22.8.2018
Ernährung: unauffällig
Schlafverhalten: unauffällig
Somatische Daten: Gewicht 10,6 kg (P50), Länge 84,0 cm (P75), KU 44,8 cm (knapp < P3). RR:
104/66 mm HG, Puls 104
Untersuchungsbefund: freundlich zugewandter Junge, Pupillenreaktion direkt und indirekt unauffällig, Blickfolgebewegungen nach oben und unten unauffällig, Rachen reizlos, Pulmo, Cor, Abdomen unauf-fällig, Hoden beidseits deszendiert. Greift gut mit der linken Hand, rechte Hand wird als Hilfshand be-nutzt. Neurologische Untersuchung: Reflexe: ASR rechts verbreitert, links unauffällig, PSR rechts verbreitert und kräftiger auslösbar, Tonus des rechten Fußes erhöht, Knick-Senkfuß rechts, verdeckter
Spitzfuß.
Physiotherapeutischer Befund: Tilo stellt sich selbständig hin mit einbeiniger Fußbelastung und Handstütz. Er spielt gern im M-Sitz, wechselt seine Position, zeigt verschiedene Übergangspositionen (seitliches Sitzen). Verbreitertet PSR, erhöhter Widerstand zur schnellen Dehnung des Triceps surae Beidseits Knick-Senkfuß, rechts mehr als links, aktiver Spitzfuß, volle mediale Fußsohlenbodenkontakt aufgrund der Knickfüße. OSG Plantarflexion/ Dorsalextension KE rechts 35/0/15 sehr langsam, Plant-arflexion/Dorsalextension KF 35/0/25. Obere Extremität Gelenke sind noch frei, Spiegelbewegungen.
Plan: Konsil mit Orthopäden wegen Empfehlung für Ringorthesen, evtl. Beratung wegen Handarm-schienen. Beginn der Physiotherapie bis zur nächsten Wiedervorstellung, Rezept Ergotherapie, wenn
Labor:
EEG vom 17.8.2018: durch unsere EEG-Abteilung auf dem 13.9.2018, 12.30 Uhr, verschoben.
Ultraschall Niere: Termin am 17.8. wurde leider versehentlich vergessen, neuer Termin für den
6.9.2018 vereinbart.
Sonographie Nieren und ableitende Harnwege vom 06.09.2018: Befund: Harnblase gering gefüllt, mittelständig, glatt konturiert. Ureteren nicht erweitert. Nieren mit rechts 63 x 28 x 40 mm und links 30 x 16 x 12 mm bei bekannten Schrumpfniere links asymmetrisch groß, glatt konturiert, orthotop rechts mit normaler Parenchymbreite und -echogenität, Kelche und Nierenbecken beidseits nicht erweitert. Rektum mit ca. 24 mm stuhlgefüllt.
Beurteilung: Unauffällige Niere rechts, ausgeprägte, bekannte

Schrumpfniere link. Nierenarteriendoppler bei unruhigem Kind und durch unruhiges Geschwisterkind überforderte Mutter nicht durchführbar.
Labor vom 06.09.18: l I/T Quotient maschinell 0.003; Natrium HP 140 [136-145 mmol/]; Kalium HP 4.3
[3.4-4.5 mmol/l]; Calcium 2.52 [2.25-2.75 mmol/l]; Chlorid 109 P+ [97-107 mmol/i]; anorg. PO4 HP 1.32 [1.00-1.95 mmol/l]; Eisen 13.4 [5.2-16.3 umo//l]; Transferrin-Sättigung HP 21.0 [16.0-45.0 %]; Kreatinin (Jaffé) HP 0.34 [0.24-0.41 mg/di]; geschätzte GFR (eGFR n Schwart n.berechenbar [ml/min]; geschätzte GFR (eGFR Cystatin >90.0 [ml/min]; Albumin HP 44.9 (38.0-54.0 g/]; Cystatin C HP 1.11 [0.50-1.00 mg/l]; Transferrin HP 2.54 [g/l]; Ferritin HP 20.1 (6.0-67.0 Mg/l]; Aik.Phosphatase HP- 230 [142-335 U/l]; kleines Blutbild (EDTA) X; Differenzierung (maschinell) X; Hämoglobin 12.0 [10.2-13.4 g/di]; Hämatokrit (I/l) 0.353 [0.315-0.405 //]; Erythrozyten 5.0 [3.7-5.2 /pll; Leukozyten 7.91 [6.00-15.00 /nl]; Thrombozyten 319 (220-490 /nl]; MCV 71.0 P- [72.0-93.0 fl]; MCH 24.1 [23.5-31.0 pg]; MCHC 34.0 [30.0-35.0 g/dl];
MPV 9.3 [7.0-12.0 fl]; RDW-CV 14.9 [11.5-15.0 %]; Neutrophile absolut 2.50 [1.50-8.70 /nl]; unreife Granulozyten absolut 0.010 [<0.050 /nil; Lymphozyten absolut 4.88 [3.00-10.00 /ni]; Monozyten absolut 0.42 [0.15-1.20 /nl]; Eosinophile absolut 0.09 [0.03-0.70 /nl; Basophile absolut 0.01 [0.00-0.20 /nl];
Labor vom 21.08.18: I/T Quotient maschinell 0.004; Natrium HP 135 P- [136-145 mmol/l]; Kalium HP 4.4 [3.4-4.5 mmol/l]; Chlorid 97 [97-107 mmol/l]; Eisen 4.2 P- [5.2-16.3 umol/l]; Transferrin-Sättigung HP 6.6 P- [16.0-45.0 %]; Kreatinin (Jaffé) HP 0.41 [0.24-0.41 mg/dil; geschätzte GFR (eGFR n Schwart n. berechenbar [ml/min]; geschätzte GFR (eGFR Cystatin 83.9 [ml/min]; Harnstoff HP 23 [11-36 mg/di); Protein HP 70 [56-75 g/l]; Cystatin C HP 1.22 [0.50-1.00 mg/l]; Transferrin HP 2.55 (g/]; Ferri-tin HP 22.5 [6.0-67.0 g/]; kleines Blutbild (EDTA) X; Differenzierung (maschinell) X; Hämoglobin 12.4
[10.2-13.4 g/di]; Hämatokrit (l/l) 0.363 [0.315-0.405 l/]; Erythrozyten 5.1 [3.7-5.2 /pll; Leukozyten 4.67
P- [6.00-15.00 /nl]; Thrombozyten 247 [220-490 /nl]; MCV 71.0 P- [72.0-93.0 fl]; MCH 24.2 [23.5-31.0 pg); MCHC 34.2 [30.0-35.0 g/dl]; MPV 9.7 [7.0-12.0 fl]; RDW-CV 15.3 P+ [11.5-15.0 %]; Neutrophile

CHARITÉ
CharitéCentrum für Frauen-, Kinder und Jugendmedizin mit Perinatalzentrum und Humangenetik
Charité I Campus Virchow-Klinikum I 13344 Berlin
Frau
Dipl. med Temler
Teterower Ring 48
12619 Berlin
Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)
für chronisch kranke Kinder
Leitung: Prof Dr. Angela M. Kaindl
Abteilung Neuropädiatrie/ Entwicklungsneurologie/Neonatologie
Komm. Leitung: Dr. Katrin Drossel Tel.
+49 (0)30 450 566 408
Fax. +49 (0)30 450 566 912
spz-neuropaediatrie@charite.de

spz.charite.de
Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Neurologie
Leitung: Prof. Dr. Angela M. Kaindi
Ouantat und Entwicklung in
Praxch
Datum: 04.03.2019 / lö/Wa
FallNr.: 0312559567
Nachrichtlich:
Familie T.
Betr.:
T., Tilo, *31.12.2016 wohnh.: Torgauer Str. 47, 12627 Berlin
Diagnosen:
Achse 1:
Somatische Diagnosen:
Eutrophes FG, 30 + 3 SSW, GG 1.470 g
Z. n. AT3-Mangel
Nierenvenenthrombose links
Schrumpfniere links
V.a. renalen Hypertonus
Infarkt der Arteria cerebri media links Hemiparese rechtsseitig
Knick-Senkfuß rechts, verdecktem Spitzfuß
Mikrocephalie
Achse 2:
Intelligenz/Entwicklung:
Motorische Entwicklungsstörung
Achse 3:
Psychiatrisch/psychologische Diagnosen:
Achse 4:
Psychosozialer Hintergrund:
(P07.3G, P07.11G) (P29.8G)
(163.5G)
(G81.1G)
(Q02.0G)
(F82.9G)
nicht vergeben
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,
Tilo wurde am 4.3.2019 im chronologischen Alter von 26 Monaten und korrigierten Alter von 23 Monaten entwicklungspsychologisch mit dem Bayley III untersucht.
Zwischenanamnese:
Verhaltensbeobachtung: Tilo ist ein freundlicher Junge und machte die Untersuchung gut mit.
Ausdauer-Aufmerksamkeitsfähigkeit und Konzentration sind als altersgerecht zu beschreiben. Er besucht eine Kita und er hat sich dort gut eingelebt.
Sprache- und Sprachverständnis: Tilo konnte den gestellten Aufgaben folgen, seinen Wortschatz konnte ich nicht beurteilen, er spricht wenig. Die Mutter berichtet das er 2 Wortsätze wie Mama komm, Mama Hunger spricht. Sein Sprachverständnis erschien bei der Untersuchung altersgerecht, allerdings kam er bei komplexeren Aufgaben an seine Grenzen. Die Sprachentwicklung sollte im Auge behalten

Gliedkörperschaft der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin
Augustenburger Platz 1 | 13353 Berlin | Telefon +49 30 450-50 www.charite.de

Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) für chronisch kranke Kinder
Fortsetzung Arztbrief: T., Tilo, * 31.12.2016
04.03.2012
Tilo hat ein Farb-Formen und Mengenverständnis entwickelt. Tilo konnte die Farben und Formen zuordnen.
Beckenübersicht 1.2.2019: Unauffällige Darstellung des Beckenskelettes. Geringe Coxa valga links.
Kein Nachweis einer Dysplasie oder einer Luxation.
Kinderorthopädisches Konsil: Hemiparese rechts aktuell weiter konservative Behandlung. Wieder-vorstellung in 1 Jahr, Röntgen-Beckenübersicht 2022.
Ultraschall Nieren 6.9.2018: unauffällige Niere rechts, ausgeprägte bekannte Schrumpfniere links.
Nierenarteriendoppler bei unruhigem Kind und begleitenden unruhigen Geschwisterkind nicht durchführbar.
Somatische Daten: Gewicht 11,1 kg (P10), Körperlänge 87,5 cm (P 25-50), Kopfumfang 45,2 cm (1,8 cm < P3) Blutdruck 98/73 mmHg, Puls 111bpm.
Untersuchungsstatus: pädiatrisch-internistischer Status unauffällig, Tilo läuft frei, Gangbild:
Hemiparese rechts, Tonus rechts deutlich erhöht, im Bereich der Hand und des Fußes. Hemiparese
GMFCS 1-2.
Untersuchungsverfahren und -ergebnisse/ Bayley Scales of Infant Development (BSID-III):
Tilos Gesamtergebnis in der mentalen Skala der BSID Ill lag mit einem Rohwert von 68 und so mit einem Skalenwert von 105 bei einem Konfidenz Intervall von 95°(94-114) und einem Prozentrang von
63 im Normal Bereich.
Zusammenfassung/Empfehlung:
Mit einem Entwicklungsindex von 105 verläuft die kognitive Entwicklung bei Tilo insgesamt alters-gerecht. Die Konzentrations- Ausdauerfähigkeit und Aufmerksamkeit sind als altersgerecht zu Die Sprachentwicklung/Sprachverständnis ist bei Tilo noch unsicher, sollte im Auge behalten werden.
Die motorische Entwicklung ist bei Tilo erfreulich verlaufen. Er hat das freie Laufen erreicht und zeigt den typischen Hemigang re. Tilo setzte seine re. Hand als Hilfs- und Haltehand ein. Tilo bekommt regelmäßig Ergotherapie zur Förderung der motorischen Entwicklung.
Das Ergebnis wurde im Anschluss mit der Mutter ausgewertet.
Die Möglichkeit des Beantragung eines Schwerbehindertenausweises und einer Pflegestufe wurde erörtert. Fortführung der Ergotherapie einmal wöchentlich sowie des Schwimmen 1 x/2 Wochen Empfehlung:
1) Ein Hand-Assessment mit dem BOT ist für den 4.4.2019 empfohlen und kann im SPZ
durchgeführt werden.
Vorstellung in der Nierensprechstunde mit Ultraschall Nieren und Nierenarteriendoppler im

Herbst 1019
Im Herbst 2019 Wiedervorstellung in der neuropädiatrischen Sprechstunde und EEG-Verlaufskontrolle
4) Röntgen Beckenübersicht und kinderorthopädische Beurteilung erneut im Januar 2020
Für Rückfragen stehen wir zur Verfügung.
Mit freundlichen, kollegialen Grüßen
Dr. R. D
Oberärztin
Komm. Leiterin Abt. Neuropädiatrie/ Entwicklungsneurologie/ Neonatologie
ELdl
Dr. E. Walch
FÄ für Pädiatrie mit Schwerpunkt Neuropädiatrie
+10/
_öffle
Physiotherapeutin

CHARITÉ
CharitéCentrum für Frauen-, Kinder- und Jugendmedizin mit Perinatalzentrum und Humangenetik
Charité I Campus Mitte I 10098 Berlin
An die Kinderarztpraxis Dr. med. F. Temler Teterower Ring 48
12619 Berlin
Klinik für Neonatologie
Direktor Prof. Dr. Christoph Bührer
http://neonatologie.charite.de
Station 107i
Tel.: 030 450 516 064
Fax: 030 450 516 910
Datum: 16.01.2017 / JB
FallNr.: 0310638421
Nachrichtlich:
Pränataldiagnostik:
Sozialpädiatrisches Zentrum - Fachbereich Neonatologie, CVK, Hauspost
* Sana Klinikum Lichtenberg, Klinik für Kinder-und Jugendmedizin, Neonatologie, Fanningerstraße 32, 10365 Berlin
Betrifft stationär
Mutter wohnhaft
T., Tilo, * 31.12.2016
vom 14.01.2017 bis zum 05.02.2017
T., Jenny, * 29.08.1988
Torgauerstraße 47, 12627 Berlin
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, wir berichten Ihnen über o.g. Kind.
Diagnosen
eutrophes Frühgeborenes (GG 1470 g, 30+6 SSW)
Perinatale Asphyxie respiratorische Insuffizienz
Infektion (late onset)
Nierenvenenthrombose links

Hypalbuminämie
Proteinurie
Hypotone Dehydratation
AT-III-Mangel
Infarkt A. cerebri media links
Hirnödem
Linksherzversagen
Renaler Hypertonus
Apnoe-Bradykardie-Syndrom
2 MRGN NeoPäd (KRINKO) Enterobacter cloacae rectal
Klinik für Neonatologie
Campus Virchow Klinikum
Augustenburger Platz 1
13353 Berlin
Tel.: 030 450 566 122
Fax: 030 450 566 922
Campus Charité Mitte
Charitéplatz 1
10117 Berlin
Tel.: 030 450 516 052
Fax: 030 450 516 921
Therapie/Prozeduren
- Zentrale ZugängeArterienkatheter (Radialis)Einschwemmkatheter
- KreislaufVolumengabePropranololMilrinone
- Respiration

vom 15.01. bis 18.01.2017
vom 14.01. bis 20.01.2017
am 14.01.2017
vom 14.01. bis 28.01.2017
vom 14.01. bis 18.01.2017
CHARITÉ - UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN
Gliedkörperschaft der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin
Telefon +49 30 450-50 | www.charite.de

CHARITÉ
CharitéCentrum für Frauen-, Kinder- und Jugendmedizin mit Perinatalzentrum und Humangenetik
Charité | Campus Virchow Klinikum | 13353 Berlin
Frau
Dipl.-Med. Felicitas Temler Ärztin für Kinderheilkunde
Teterower Ring 48
12619 Berlin
Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Neurologie
Direktorin: Prof. Dr. Angela M. Kaindl
Station 28/29
Tel.: + 49 (0)30 450 - 566 382
Fax: + 49 (0)30 450 - 566 928
Anmeldung

Poliklinik Neuropädiatrie
Tel.: + 49 (0)30 450 - 566 625
Fax: + 49 (0)30 450 - 566 953
E-mail: neuropaediatrie@charite.de
Sozialpädiatrisches Zentrum
Tei.: + 49 (0)30 450-566 188
Notfallambulanz der Kinderklinik
Tel.: + 49 (0)30 450 - 566 128
Berlin:
02.11.2017 / MG
Fall-Nr.: 0311381600
Nachrichtlich:
図
SPZ-Neuropädiatrie im Hause (Dr. Walch)
* Tilo T., Torgauer Str.47, 12627 Berlin
2 MRGN Keim rektal
Vorläufiger Arztbrief
Sehr geehrte Frau Kollegin,
wir berichten Ihnen über den Patienten T. Tilo, geb. am 31.12.2016, wohnhaft: Torgauer Str. 47,
12627 Berlin, der sich vom 30.10.2017 bis zum 02.11.2017 in unserer stationären Betreuung befand.
Diagnosen:
Eutrophes FG, 30 + 3 SSW, GG 1.470 g
(P07.3G, P07.11G)
Nierenvenenthrombose links
(P29.8G)
AT3-Mangel
Infarkt der Arteria cerebri media links
(163.5G)
V.a. zentrale Muskeltonus- und Koordinationsstörung rechts (G80.9V)
Renaler Hypertonus
Aufnahmegrund: Diagnostik bei Z.n. Frühgeburtlichkeit und Nierenvenenthrombose
Anamnese:
Bekanntes Frühchen der 31.SSW, wird im SPZ von Frau Dr. Walch betreut. Stationäre Aufnahme zur ausführlichen Diagnostik geplant. Bei Z.n. Arteria cerebri media Infarkt links aktuell Seitendifferenz zuungunsten der rechten Seite, V.a. zentrale Muskeltonus- und Koordinationsstörung rechtsseitig. Bei Z.n. Nierenvenenthrombose wurde eine Vorstellung in der Gerinnungssprechstunde gebahnt.
Tilo entwickelt sich prächtig laut Mutter, seit einigen Tagen etwas Schnupfen und subfebrile
Temperaturen.
Medikation bei Aufnahme: Keine
Klinischer Status: 10 Monate alter, korrigiert 8 Monate alter Junge in gutem AEZ/adipösem EZ o.a., KL 77 cm (P82), KG 14,1 kg (2kg >P99), KU 41,6 cm (2cm<P3).
Pädiatrisch-intern: Kardiopulmonaler Auskultationsbefund und abdomineller Tastbefund unauffällig, Rachenring minimal gerötet. Äußeres Genitale unauffällig

männlich, Hoden deszendiert. Keine phänotypischen Auffälligkeiten. Große Gelenke frei beweglich, Wirbelsäule gerade.
Neurologisch: Wach, freundlich, Kontaktaufnahme altersentsprechend, lautiert Doppelsilben, Pupillen isokor, Lichtreaktion direkt und indirekt seitengleich und prompt, Okulomotorik unauffällig, Mimik
CHARITÉ - UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN
Gliedkörperschaft der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin Augustenburger Platz 1 I 13353 Berlin I Telefon +49 30 450-50I
www.charite.de

CHARITÉ
CharitéCentrum für Frauen-, Kinder- und Jugendmedizin mit Perinatalzentrum und Humangenetik
Charité I Campus Virchow Klinikum I 13353 Berlin
Frau
Dipl.-Med. Felicitas Temler Ärztin für Kinderheilkunde
Teterower Ring 48
12619 Berlin
Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Neurologie
Direktorin: Prof. Dr. Angela M. Kaindl
Station 28/29
Tel.: + 49 (0)30 450 - 566 382
Fax: + 49 (0)30 450 - 566 928
Anmeldung
Poliklinik Neuropädiatrie
Tel.: + 49 (0)30 450 - 566 625
Fax: + 49 (0)30 450 - 566 953
E-mail: neuropaediatrie@charite.de
Sozialpädiatrisches Zentrum
Tei.: + 49 (0)30 450-566 188
Notfallambulanz der Kinderklinik
Tel.: + 49 (0)30 450 - 566 128
Berlin:
02.11.2017 / MG
Fall-Nr.: 0311381600
Nachrichtlich:
図
SPZ-Neuropädiatrie im Hause (Dr. Walch)
* Tilo T., Torgauer Str.47, 12627 Berlin
2 MRGN Keim rektal
Vorläufiger Arztbrief
Sehr geehrte Frau Kollegin,
wir berichten Ihnen über den Patienten T. Tilo, geb. am 31.12.2016, wohnhaft: Torgauer Str. 47,
12627 Berlin, der sich vom 30.10.2017 bis zum 02.11.2017 in unserer stationären Betreuung befand.
Diagnosen:
Eutrophes FG, 30 + 3 SSW, GG 1.470 g

(P07.3G, P07.11G)
Nierenvenenthrombose links
(P29.8G)
AT3-Mangel
Infarkt der Arteria cerebri media links
(163.5G)
V.a. zentrale Muskeltonus- und Koordinationsstörung rechts (G80.9V)
Renaler Hypertonus
Aufnahmegrund: Diagnostik bei Z.n. Frühgeburtlichkeit und Nierenvenenthrombose
Anamnese:
Bekanntes Frühchen der 31.SSW, wird im SPZ von Frau Dr. Walch betreut. Stationäre Aufnahme zur ausführlichen Diagnostik geplant. Bei Z.n. Arteria cerebri media Infarkt links aktuell Seitendifferenz zuungunsten der rechten Seite, V.a. zentrale Muskeltonus- und Koordinationsstörung rechtsseitig. Bei Z.n. Nierenvenenthrombose wurde eine Vorstellung in der Gerinnungssprechstunde gebahnt.
Tilo entwickelt sich prächtig laut Mutter, seit einigen Tagen etwas Schnupfen und subfebrile
Temperaturen.
Medikation bei Aufnahme: Keine
Klinischer Status: 10 Monate alter, korrigiert 8 Monate alter Junge in gutem AEZ/adipösem EZ o.a., KL 77 cm (P82), KG 14,1 kg (2kg >P99), KU 41,6 cm (2cm<P3).
Pädiatrisch-intern: Kardiopulmonaler Auskultationsbefund und abdomineller Tastbefund unauffällig, Rachenring minimal gerötet. Äußeres Genitale unauffällig männlich, Hoden deszendiert. Keine phänotypischen Auffälligkeiten. Große Gelenke frei beweglich, Wirbelsäule gerade.
Neurologisch: Wach, freundlich, Kontaktaufnahme altersentsprechend, lautiert Doppelsilben, Pupillen isokor, Lichtreaktion direkt und indirekt seitengleich und prompt, Okulomotorik unauffällig, Mimik

Monozyten absolut	/nl	0.20-1.90	0.59	0.13 P-
Eosinophile absolut	/nl	0.05-0.90	0.00 P-	0.00 P.
Basophile absolut	/nl	0.00-0.20	0.01	0.01
Retikulozyten	/nl	25.0-130.0	46.9	
Reti% gemessen		0.70-3.20	0.98	

Reti.produktion sindex			0.6	
Ret-Hb	Pg	28.5-34.5	28.5	
Quick (TPZ)	%	70-130	81	
INR		0.90-1.25	1.15	
aPTT	sek.	30.0-46.0	48.7 P+	

Gerinnungsdiagnostik vom 02.11.2017
Befunde bei Entlassung ausstehend. Werden nachgereicht.
EEG-Nr.: 2167/17 Messdatum: 30.10.2017
Klinik/Fragestellung: Infarkt der Arteria cerebri media links
Kommentar der TA: Wachzustand, Augen offen, Abbruch nach 8 Min., Kind den ganzen Tag noch nichts gegessen und getrunken, schreit und wehrt sich, MRT heute noch Befund: Stark Artefakt-überlagertes EEG. Hintergrundaktivität ca. 4 Hz, altersentsprechend. Bei starker Artefakt-Überlagerung kein sicherer Hinweis für epilepsietypische Potentiale (ETP) oder eine regionale Hirnfunktionsstörung. Keine Befunderweiterung unter Hyperventilation und FS
Beurteilung: Artefakt-gestörtes EEG ohne eindeutigen Hinweis für epilepsietypische Potentiale (ETP) oder eine regionale Hirnfunktionsstörung. Bei fortbestehendem klinischem Anhalt für Krampfanfälle evtl. Kontrolle im Schlaf im Verlau
Echokardiographie vom 01.11.2017:
Befund: Leber- und Lungenvenen normal mündend, Atrioventrikuläre und Ventrikuloarterielle
Konkordanz
Septen intakt, AV- und arterielle Klappen suffizient und ohne Stenosen
RV und LV Funktion gut, keine Dyskinesien, RVOT, Pulmonalbifurkation, RPA und LPA unauffällig (®
PDA)
LVOT, AoAsc, AoBogen und AoDesc unauffällig (o ISTA), kein PE
M-Mode (mm):LVDd 24,2; LVDs 17; IVSd 5,7; PWd 5, FS 30%. Plan. EF 66. TAPSE: 1,3cm.
Doppler (m/s): TV,8/ ; MV,8/1; PV 1; AoV 1, Isthmus 1,5
EKG: SR, Steiltyp, Hf 136/min. PQ 120 ms, QRS 50 ms, QTc 411 ms. Keine Hypertrophiezeichen, keine ERBS, keine ES.
Beurteilung: Kein Hinweis für Vitium cordis/Kardiomyopathie oder PHT
Bildgebung:
MR Kopf vom 30.10.2017:
Klinik, Fragestellung, Rechtfertigende Indikation:
Mediainfarkt der ACM li. Operculum, Putamen, Palidum.
3 Tesla, Kopfspule, Lokalisationssequenzen, axiale T2*, axiale T2 TIRM, arterielle TOF, axiale T1-
Flash, sagittale T2-TSE, axiale EPI DWI.
Vergleich mit Voraufnahmen vom 16.01.2017.
Zustand nach vorbeschriebenem Mediainfarkt mit jetzt Parenchymdefekten im Stammganglienbereich und frontoparietalen Operculum links. Konsekutive evacuo Erweiterung des linken Seitenventrikels sowie Ausdünnung des Corpus callosum. Keine frischen oder in der Zwischenzeit aufgetretenen Infarkte. Normale intrakranielle, arterielle Hauptstammgefäße.

Normales Cerebrum im Übrigen. Altersgerechte Myelinisierung®
Nasennebenhöhlen nur partiell belüftet. Freie Mastoide und Paukenhöhlen.
Lymphknoten in den miterfassten Halsabschnitten.
Beurteilung:
Zustand nach Mediainfarkt links.
Verlauf und Beurteilung:

Klinik für Pädiatrie m. S. Neurologie Direktorin: Prof. Dr. Angela M. Kaindl
Fortsetzung Arztbrief: T., Tilo, geb. 31.12.2016
Wir nahmen Tilo geplant zur umfangreichen Diagnostik auf. Während des stationären Aufenthaltes entwickelte Tilo Fieber bis 40°C, welches sich unter kurzzeitiger Antibiose und Antipyrese gut senken ließ. Jederzeit kardiorespiratorisch stabil. Die kardiologische Untersuchung war unauffällig. Kein Anhalt für einen Herzfehler, einer Kardiomyopathie oder eine pulmonale Hypertonie. Auch im EEG zeigten sich keine epilepsietypischen Potentiale
In der MRT Untersuchung leichte Erweiterungen der Seitenventrikel zu sehen, die vereinbar sind mit dem stattgehabten Mediainfarkt. Derzeit keine Behandlung möglich.
Die ausführliche Besprechung der Befunde wird im SPZ durch Frau Dr. Walch erfolgen.
Wir konnten Tilo in gutem Allgemeinzustand am 02.11.2017 in die Häuslichkeit entlassen.
Es erfolgte ein rektaler Abstrich bei bekanntem 2-MRGN Keim.
Entlassungsbefund: Guter Allgemeinzustand, fieberfrei
Empfohlene / Mitgegebene Medikation bei Entlassung:
Keine
Patient erhielt einen Medikationsplan ja nein X
Empfehlungen:
Veranlasste Verordnungen:
Nachfolgende Versorgungseinrichtung: Nächster Termin im SPZ: 08.11.2017
Mitgegebene Befunde:
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern unter den im Briefkopf genannten Rufnummern oder der zuständigen Stationsstützpunktnummer 030 450-666455 zur Verfügung.
Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Prof. Dr. Angela M. Kaindl
Direktorin der Klinik
Dr. C. Prager
Oberärztin
LBal
L. Barbera
Assistenzärztin

F07678046

Original durch BARMER qual. elektronisch signiert und archiviert - ID
9998999_RB_83E544CF863241608
C7E5A4B0269CBBD

CHARITÉ
CharitéCentrum für Frauen-, Kinder und Jugendmedizin mit Perinatalzentrum und Humangenetik
Charté I Campus Virchow-Klinikum I 13344 Berlin
Familie T.
Torgauer Str. 47
12627 Berlin
BAR
27. SEP. 2019
10103 - Berlia Ave
Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)
für chronisch kranke Kinder
Leitung: Prof Dr. Angela M. Kaindl
Abteilung Neuropädiatrie/ Entwicklungsneurologie/Neonatologie
Komm. Leitung: Dr. Katrin Drossel
Tel. +49 (0)30 450 566 408
Fax. +49 (0)30 450 566 912
spz-neuropaediatrie @charite.de
spz.charite.de
Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Neurologie
Leitung: Prof. Dr. Angela M. Kaindi
Datum: 19.09.2019 / 1ö/Wa
FallNr.: 0313146142
Entwicklung in
Nachrichtlich:
Betr.:
T., Tilo, *31.12.2016 wohnh.: Torgauer Str. 47, 12627 Berlin
Zur Vorlage bei der Krankenkasse: Beantragung einer SPZ Doppelbetreuung
Diagnosen:
Achse 1:
Somatische Diagnosen:
Eutrophes FG, 30 + 3 SSW, GG 1.470 g
Z. n. AT3-Mangel
Nierenvenenthrombose links
Schrumpfniere links
V.a. renalen Hypertonus
Infarkt der Arteria cerebri media links Hemiparese rechtsseitig
Knick-Senkfuß rechts, verdecktem Spitzfuß
Mikrocephalie
(P07.3G, P07.11G) (P29.8G)
(163.5G)
(G81.1G)
(Q02.0G)
Achse 2:
Intelligenz/Entwicklung:
Motorische Entwicklungsstörung
(F82.9G)
Achse 3: Psychiatrisch/psychologische Diagnosen:
Achse 4: Psychosozialer Hintergrund:

nicht vergeben
Sehr geehrte Damen und Herren,
Wie Sie aus den oben genannten Diagnosen sehen liegt bei Tilo eine eine Hemiparese rechtsseitig nach zerebralem Infarkt sowie eine Schrumpfniere bei Nierenvenenthrombose vor. Die diagnostische und medizinische Betreuung (Kinderneurologie, Kindernephrologie, Entwicklungsneurologie) erfolgt in unserem Hause. Therapeutisch soll das Kind wohnortnah im SPZ Hellersdorf betreut werden und seine Therapien erhalten.
Wir beantragen deshalb für das 1. und 3. Quartal 2020 die zusätzliche Betreuung des Kindes im SPZ der Charité Fachbereich Neuropädiatrie.
CHARITE - UNIVERSITATSMEDIZIN BERLIN
Gliedkörperschaft der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin
Augustenburger Platz 1 I 13353 Berlin I Telefon +49 30 450-50 I www.charite.de

Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) für chronisch kranke Kinder
Fortsetzung Arzibrief: T., Tilo, * 31.12.2016
19.09.2019
Grund der Doppelbetreuung in diesen Quartalen ist die neuropädiatrische und kindernephrologische Einschätzung, die weiterführende Diagnostik und die Koordination der erforderlichen Therapien.
Ziel der medizinischen Versorgung und therapeutischen Betreuung des Kindes ist die Teilhabe unseres Patienten am gesellschaftlichen Leben nach SGB XII § 53 Abs. 1.
Wir bitten um Kostenübernahme für die zusätzliche Betreuung des Kindes für das 1. und .Quartal
2020 im SPZ Neuropädiatrie der Charité.
Mit freundlichen Grüßen i.V. Terr
Dr. K. Drossel
Oberärztin
Komm. Leiterin Abt. Neuropädiatrie/ Entwicklungsneurologie/ Neonatologie
Dr. E. Walch
FÄ für Pädiatrie mit Schwerpunkt Neuropädiatrie
Original durch BARMER qual. elektronisch signiert und archiviert - ID 9998999_RB_83E544CF863241608C7E5A4B0269CBBD

OBERLIN KLINIK
Oberlinklinik gGmbH • Rudolf-Breitscheid-Straße 24 • 14482 Potsdam
Herr
Dr.med. Christian Michael
Blumberger Damm 158
12679 Berlin
Abteilung:
Kinder- und Neuroorthopädie
Chefarzt Dr. med. Stefan Blume
Kinderorthopädie:
Telefon: 0331 763-5742
Fax: 0331 763-5740
kinderorthopaedie@oberlinhaus.de

Datum: 17.09.2021
Station A
endgültiger Entlassbrief
T., Tilo (M) - geb. am 31.12.2016, wohnhaft: Torgauer Str. 47 in 12627 Berlin
Sehr geehrter Herr Kollege,
Wir berichten über o. g. Patient, der sich vom 14.09.2021 - 17.09.2021 in unserer stationären Behandlung befand.
Diagnosen:
Hochkontrakter Spitz-Supinationsfuß rechts
Nebendiagnose(n):
ICP nach FG 30. SSW
Arteria-Media-Infarkt links spastische Hemiparese rechts
Schrumpfniere links nach Nierenvenenthrombose
Dystone-teilkontrakte Arm- und Handgebrauchsstörung rechts
Gangstörung
Innentorsion rechte Hüfte
Arm- und Beinlängendifferenz
Antithrombin-III-Mangel
Arm- und Beinlängendifferenz rechts
Therapie:
Z-förmige Verlängerung der Achillessehne, dorsales Peritaleres Release, Redressionsliege gipses22 /info@berlin-klinik.de /www.oberlin-klinik.de
Gesellschafter: Verein Oberlinhaus I Geschäftsführung: Andreas Koch, Oliver Pommerenke
Gerichtsstand: Amtsgericht Potsdam I HRB 20086 P I USt-IdNr.: DE 252 092 291
Bankverbindung: Evangelische Bank eG I IBAN: DE76 5206 0410 0008 0250 96 I BIC: GENODEF1EK1
Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e. V.
15C.
OBERLINHAUS
Im Verbund der Diakonie
Ein Unternehmen im OBERLINHAUS
Datum
14.09.2021
Verbund christli
Brandenburg

15.09.2021 - Seite 2 von 3
T., Tilo - geb. am 31.12.2016
Grund der Aufnahme: Tilo wurde uns ambulant aufgrund von fortgeschrittener und hochgradig kontrakter Spitzfußstellung vorgestellt, die er aktiv nicht mehr Absenken kann und die auch passiv nicht mehr ausreichend zu korrigieren ist.
Aufnahmebefund:
4- jähriger Patient; Größe:110 cm, Gewicht: 23. AZ gut und EZ gut. orientiert.
Motorik: intakt.
Sensibilität: intakt.
Stand und Gang:
Becken-Retrotorsion rechts, rechts etwas mehr einwärtsdrehende, beckenbreite Schrittspur.

Links physiologisches Abrollen und sichere dynamische Knie-Stabilität.
Rechter Fuß wird ausschließlich in hoher Spitz-Supinationsstellung belastet, entsprechende Ausgleichsflexion des rechten Kniegelenkes. Im Stand kommt er zum vollen Streckanschlag.
Rumpf symmetrisch, rechter Arm mit assoziierter Abduktions-Innenrotations-Flexionsfehlstellung.
Handgelenk in hochgradiger Ulnar-Flexion-Pronation.
Passiv:
Hüftgelenke: Abduktion beiderseits über 60°, Horizontalabduktion/-adduktion seitengleich 50-0-25*; kein Streckdefizit; Außen-/Innenrotation rechts 10-0-70°.
1 links 25-0-50°.
Kniegelenke achsengerecht und band-stabil, beiderseits 0-0-160°
Füße: rechter Fuß auch unbelastet in hochgradiger Spitz-Supinationsstellung.
Auf Streichreiz links kraftvolle dynamische Hebung, rechts keine Hebung.
Passiv korrigiert: die Supinationsstellung rechts kann noch aufgelöst werden, Spitzfußanteil -30/-10° (mit und ohne Transmission).
Linker Fuß problemlos auf +10/+25° einstellbar.
Verlauf: Am 14.09.2021 erfolgte der oben genannte operative Eingriff in komplikationsloser Allgemeinanästhesie. Postoperativ wurde zunächst eine Unterschenkelgipslonguette angelegt.
Zur primären Schmerztherapie erfolgte die Anlage eines peripheren Schmerzkatheters. Nach passagerer Bettruhe erfolgte die physiotherapeutisch geleitete Mobilisation unter Entlastung des operierten Beines. Nach Konsolidierung der Weichteile konnte am 16.09.2021 die Anlage eines zirkulären Unterschenkelliegecastes erfolgen. Im weiteren Verlauf war Tilo mit Rollstuhl mobil.
Entlassungsbefund: Reizlos anliegender Cast. Die periphere Durchblutung, Motorik und Sensibilität waren intakt. Tilo ist auf Stationsebene mit Rollstuhl mobil.
Medikation bei Aufnahme:
Medikation bei Entlassung:
Novaminsulfon 200mg(=8 Tropfen) 1-1-1-1
Ibuprofen 125 mg (= 4 ml) 1-1-1
Hilfsmittelverordnungen:
Unterschenkelnachtlagerungsschale links nach Gipsabdruck
Leihrollstuhl für 6 Wochen

Vorhandene Hilfsmittel:
Unterschenkel-Orthese rechts (Fa. Krügel): seit dem dritten Lebensjahr, sei kaum anwendbar gewesen, aktuell ausgewachsen.
Für die rechte Hand sei um das dritte Lebensjahr eine Silikon-Orthese gebaut worden, auch diese sei nicht anwendbar gewesen (blutig gescheuert). Weggelassen.
Derzeit hat er eine Unterarm-Hand-Nachtlagerungsschiene, diese kann nur im Schlaf angelegt werden, wird dann unterschiedlich lange (zum Teil ganznächtig) toleriert.
Prozedere: Wir bitten um die weiteren Kontrollen des anliegenden Castes. Bei Beschwerden im Cast bitten wir um umgehende Wiedervorstellung. Im Zweifel muss der Cast abgenommen werden.
Fortführen der Mobilisierung unter Entlastung des operierten Beines. Bei prolongierter Einnahme von Novaminsulfon bitten wir um ambulante Kontrollen des Blutbildes zum Ausschluss einer Agranulozytose.

Der Wechsel auf einen Gehcast ist für den 15.10.2021 um 08:30 Uhr in unserer kinderorthopädischen Sprechstunde vorgesehen. Dort wird je nach lokalem Befund über einen Lastaufbau mit neu angelegtem Gehcast entschieden. Hier wird dann auch die Unterschenkelnachtlagerungsschale angepasst.
Die endgültige Castabnahme ist für den 05.11.2021 um 09:30 Uhr in unserer kinderorthopädischen Sprechstunde vorgesehen.
Nachfolgende Versorgungseinrichtung: Ihre und unsere Ambulanz. Entlassung in die Häuslichkeit.
Bei Wiedervorstellung bringen Sie bitte einen gültigen Überweisungsschein von Ihrem niedergelassenen Arzt mit.
Verbindlichen Dank für die Einweisung Ihres Patienten. Für Rückfragen stehen Ihnen die Arzte der Station A und ein Ansprechpartner zum Entlassmanagement unter Tel. 0331-7635721/23 zur Verfügung.
Mit freundlichen und kollegialen Grüßen
Oberlinklinik gGmbH
Dr. med. Stefan Blume
Chefarzt
Kinder- und Neuroorthopädie
Julia Schmidt
Assistentzärztin
Kinder- und Neuroorthopädie

OBERLIN KLINIK
Oberlinklinik I Rudolf-Breitscheid-Str. 24 I 14482 Potsdam
Lebenshilfe gGmbH - SPZ
Herr Dr. med. Christian Michael
Arztlicher Leiter
Blumberger Damm 158
12679 Berlin
Ansprechpartner
Dr. med. Gert Pietsch
Leiter
Abteilung
Ambulantes Zentrum für Menschen mit
Behinderung
Kontakt
Tel.: 0331 763-4691
Fax: 0331 763-4692
azmb@oberlinhaus.de
Unser Zeichen: pie - eng Datum: 03.02.2021
T., Tilo, *31.12.2016,
12627 Berlin; Torgauer Str. 47
Sehr geehrter Herr Kollege, ich berichte über die neuroorthopädische Konsiluntersuchung Ihres o. g. Patienten am 29.01.2021.
Diagnosen:
ICP nach FG 30. SSW
Arteria-Media-Infarkt links spastische Hemiparese rechts
Schrumpfniere links nach Nierenvenenthrombose ? AT3-Mangel
dystone-teilkontrakte Arm- und Handgebrauchsstörung rechts

Gangstörung
Innentorsion rechte Hüfte hochkontrakter Spitz-Supinationsfuß rechts Arm- und Beinlängendifferenz
Anamnese:
Zweit-Para.
Älteres und jüngeres Geschwisterkind sind gesund.
Bei Plazentaruptur Not-Sectio 30. SSW, 1.470 g.
Vermutlich unter AT3-Mangel ist es dann zum Hirninfarkt linksseitig wie auch zur Nierenvenenthrombose links gekommen.
Wegen Letzterer ist er aus der Entbindungsklinik Sana-Klinikum frühzeitig in die Charité verlegt worden, dann dort für zwölf Wochen Neonatologie.
Mit Entlassung nach Hause ist die Hemiparese bereits bekannt gewesen, entsprechend frühzeitige Physiotherapie.

T., Tilo * 31.12.2016
Anbindung ans SPZ-Charité/Virchow-Klinikum (seit Januar 2020 Doppel-Betreuung über SPZ
Marzahn).
Laufbeginn mit zwei Jahren.
Hat sich stetig weiterentwickelt.
Laufstrecke heute bis zu 3 km, dann allerdings Verweigerung wegen Schmerzen im Fuß.
Treppauf und treppab mit einhändiger Geländerführung.
Roller und Laufrad werden gut beherrscht.
Linkshänder, rechte Hand wegen dystoner Fehlstellung nur verzögert im Greifeinsatz, letztlich aber auch feinmotorisch aktiv.
Die Eltern leben getrennt, heutige Vorstellung mit dem Vater Herrn Botzler.
Gesundheitsfürsorge liegt bei beiden Eltern.
Integrations-Kita „Notenhopser".
Normalerweise Physiotherapie 1 xV in der Kita; zusätzlich Heilpädagogik und Psychomotorik im SPZ, derzeit alles Corona-unterbrochen.
Kognitive Situation ist gut.
Es habe einen Krampfanfall unklarer Ursache gegeben, danach unauffällig, keine Dauermedikation.

Sprachentwicklung altersentsprechend.
Keine Schluckprobleme.
Blasen- und Darmkontrolle sind sicher.
Internistisch: die Schrumpfniere ist kompensiert.
Bzgl. seiner Gerinnungsstörung liegen jetzt keine Detailangaben vor In jedem Fall hat er damals nach Entbindung für drei Monate gespritzt werden müssen (Heparin?); seitdem keine spezifische Behandlung.
Hilfsmittel:
Unterschenkel-Orthese rechts (Fa. Krüger): seit dem dritten Lebensjahr, zuletzt vor vier Monaten, sei kaum anwendbar gewesen, aktuell ausgewachsen.
Für die rechte Hand sei um das dritte Lebensjahr eine Silikon-Orthese gebaut worden, auch diese sei nicht anwendbar gewesen (blutig gescheuert). Weggelassen.
Derzeit hat er eine Unterarm-Hand-Nachtlagerungsschiene, diese kann nur im Schlaf angelegt werden, wird dann unterschiedlich lange (zum Teil ganznächtig) toleriert.
Keine aktuellen Schmerzen.
Hauptproblem und Vorstellungsgrund ist der Spitzfuß rechts.
Befund:
4-jähriger, fröhlicher Junge, lebhaft, kooperationsbemüht.
Stand und Gang:
Becken-Retrotorsion rechts, rechts etwas mehr einwärtsdrehende, beckenbreite Schrittspur.
Links physiologisches Abrollen und sichere dynamische Knie-Stabilität.
Rechter Fuß wird ausschließlich in hoher Spitz-Supinationsstellung belastet, entsprechende Ausgleichsflexion des rechten Kniegelenkes. Im Stand kommt er zum vollen Streckanschlag.

Rumpf symmetrisch, rechter Arm mit assoziierter Abduktions-Innenrotations-Flexionsfehlstellung.
Handgelenk in hochgradiger Ulnar-Flexion-Pronation.
Passiv:
Hüftgelenke: Abduktion beiderseits über 60°, Horizontalabduktion/-adduktion seitengleich 50-0-25°; kein Streckdefizit; Außen-/Innenrotation rechts 10-0-70° , links 25-0-50°
Kniegelenke achsengerecht und band-stabil, beiderseits 0-0-160°
Füße: rechter Fuß auch unbelastet in hochgradiger Spitz-Supinationsstellung.
Auf Streichreiz links kraftvolle dynamische Hebung, rechts keine Hebung.
Passiv korrigiert: die Supinationsstellung rechts kann noch aufgelöst werden, Spitzfußanteil -30/-10° (mit und ohne Transmission).
Linker Fuß problemlos auf +10/+25° einstellbar.
Rechter Arm: Schulter stabil.
Ellenbogen passiv voll streckbar.
Supinationseinschränkung rechts 50° (links 100°).
Handgelenk rechts steht spontan in 60° Ulnarflexion, aktiv mühsam bis -15° aufrichtbar, passiv Langfingerbeuger sind bereits transmissionsabhängig verkürzt.
Daumen adduziert.
Es besteht bereits eine Armlängendifferenz, nicht exakt ausgemessen.
Beinlängendifferenz wenigstens -12 mm rechts.

Beurteilung/Empfehiung:
Bei bekanntem linksseitigem Media-Infarkt besteht eine ausgeprägte spastisch-dystone Hemiparese rechts, bei guter kognitiver Situation.
Die Greiffunktion rechts ist vor allem durch die dystone Fehlstellung des Handgelenkes bedingt.
Die bisherigen Versuche, das Handgelenk mit einer „weichen" Tagesfunktionsschiene in eine bessere Greifausgangsstellung zu bringen, sind offensichtlich frustran verlaufen.
Theoretisch müsste eine solche Aufrichtung aber möglich sein und sollte auch weiterhin angestrebt werden, um den Gebrauch der rechten Hand zu erleichtern und sie damit im Bewegungs- und Funktionskonzept gut zu repräsentieren.
Problematisch dabei ist die bereits eingetretene Verkürzung der Langfingerbeuger: mit aufgerichtetem Handgelenk werden die Langfinger relativ stark in die Flexion hineinschließen.
Dennoch sollte die Funktionsschiene nur bis zur Hohlhand reichen, die Finger müssen frei bleiben, um das Greifen zu ermöglichen.
Hier muss also vor allem durch die Physiotherapie mit weiterer Dehnung gearbeitet werden.
Mit der Nacht-Lagerungsschiene (die wir heute nicht gezeigt bekommen) werden die Langfinger hoffentlich in einer ausreichenden Streck-Dehnung gelagert werden, sodass damit zumindest eine weitere Kontrakturzunahme verhindert werden kann.
Neben Anwendung dieser Schiene verordnen wir jetzt also noch einmal eine Silikon-Funktionsorthese.
Ob und wie diese dann anwendbar ist, muss vor allem durch die begleitende Ergotherapie kontrolliert werden, ggf. auch kurzfristige erneute Vorstellung in der Neuroorthopädie.

CHARITÉ
Charité I Campus Virchow-Klinikum I 13344 Berlin
Frau Dr. F. Temmler
FÀ f. Kinder-u. Jugendmedizin
Teterower Ring 48
12619 Berlin
Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)
für chronisch kranke Kinder
Leitung: Prof Dr. Angela M. Kaindi
Abteilung Neuropädiatriel
Entwicklungsneurologie/Neonatologie
Komm. Leitung: Dr. Katrin Drossel
Tel.
Fax.
+49 (0)30 450 566 408
+49 (0)30 450 566 911
spz-neuropaediatrie@charite de
spz.charite.de
Datum: 22.08.2018 / kr Fall-Nr.: 0312128478

Diagnosen:	
Achse 1:	

Somatische Diagnosen:		
	Eutrophes FG, 30 + 3 SSW. GG 1.470 g	(P07.3G, P07.11G)
	Z. n. AT3-Mangel	
	Nierenvenenthrombose links	(P29.8G)
	Schrumpfniere links	
	V.a. renalen Hypertonus	
	Infarkt der Arteria cerebri media links	(163.5G)
	Hemiparese rechtsseitig	(G81.1G)
	Knick-Senkfuß rechts, verdecktem Spitzfuß	
	Mikrocephalie	(Q02.0G)
Achse 2:	Intelligenz/Entwicklung:	
	Motorische Entwicklungsstörung	(F82.9G)
Achse 3: Psychiatrisch/psychologische Diagnosen:		nicht vergeben
	Achse 4: Psychosozialer Hintergrund:	nicht vergeben

Nachrichtlich:
2 Familie T., Torgauer Str. 47, 12627 Berlin
Betr.:
T., Tilo, *31.12.2016 wohnh.: Torgauer Str. 47, 12627 Berlin
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,
wir berichten Ihnen über o.g. Jungen, der uns am 17.08.2018 mit korrigiert 1 Jahr und 5 Monaten in der SPZ-Abteilung Neuropädiatrie vorgestellt wurde.
Zwischenanamnese: Die Kindsmutter ist mit der Entwicklung des Kindes zufrieden. Tio zeigt eine dezente Beeinträchtigung der rechten Körperhälfte.
Grobmotorik: Krabbeln seit April 2018 (13 Monate), rechte Hand gefaustet, linke Hand offen, Hochziehen zum Stand April 2018. Seitschritte an Möbeln aktuell, er schiebt Stühle und Kisten vorwärts, läuft mit Fußinnenrandbelastung. Will gern über Dinge klettern, rechter Fuß überwiegend in Innenrandbelas-tung, geht vom Stand zum Boden herunter.
Therapien: Physiotherapie pausiert, letztes Rezept ging bis Mai 2018
Kita: Ab 1.10.2018 ist eine Eingewöhnung in die Kita vorgesehen, I-Status A wird beantragt.
Sprachentwicklung: Worte: aua, Mila, nein, Mama, Papa, gutes Sprachverstehen.
Spielentwicklung: er spielt schön und ausdauernd, steckt Ringe auf einen Stab. Räumt Dinge aus und ein, steckt Förmchen.

CHARITE - UNIVERSITATSMEDIZIN BERLIN
Gliedkörperschaft der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin
Augustenburger Platz 1 I 13353 Berlin / Telefon +49 30 450-50 I www.charite.de

Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) für chronisch kranke Kinder
Fortsetzung Arztbriet: T., Tilo, geb. 31.12.2016
2
22.8.2018
Ernährung: unauffällig
Schlafverhalten: unauffällig.
Somatische Daten: Gewicht 10,6 kg (P50), Lange 84,0 cm (P75), KU 44,8 cm (knapp < P3). RR:
104/66 mm HG, Puls 104
Untersuchungsbefund: freundlich zugewandter Junge, Pupillenreaktion direkt und indirekt unauffällig.
Blickfolgebewegungen nach oben und unten unauffallia. Rachen reizlos, Pulmo, Cor. Abdomen unauf-fallio. Hoden beidseits deszendiert. Greift gut mit der linken Hand, rechte Hand wird als Hilfshand be-nutzt. Neurologische Untersuchung: Reflexe: ASR rechts verbreitert, links unauffällig, PSR rechts verbreitert und kräftiger auslösbar, Tonus des rechten Fußes erhöht, Knick-Senkfuß rechts, verdeckter
Spitzfuß
Physiotherapeutischer Befund: Tilo stellt sich selbständig hin mit einbeiniger Fußbelastung und Handstütz. Er spielt gern im M-Sitz, wechselt seine Position, zeigt verschiedene Übergangspositionen (seitliches Sitzen). Verbreitertet PSR, erhöhter Widerstand zur schnellen Dehnung des Triceps surae.
Beidseits Knick-Senkfuß, rechts mehr als links, aktiver Spitzfuß, volle mediale Fußsohlenbodenkontakt aufgrund der Knickfüße. OSG Plantarflexion/ Dorsalextension KE rechts 35/0/15 sehr langsam, Plant-arflexion/Dorsalextension KF 35/0/25. Obere Extremität Gelenke sind noch frei, Spiegelbewegungen.
Plan: Konsil mit Orthopäden wegen Empfehlung für Ringorthesen, evtl. Beratung wegen Handarm-schienen. Beginn der Physiotherapie bis zur nächsten Wiedervorstellung, Rezept Ergotherapie, wenn
Kita beginnt.
Labor:
EEG vom 17.8.2018: durch unsere EEG-Abteilung auf dem 13.9.2018, 12.30 Uhr, verschoben Ultraschall Niere: Termin am 17.8. wurde leider versehentlich vergessen, neuer Termin für den
6.9.2018 vereinbart.
Sonographie Nieren und ableitende Harnwege vom 06.09.2018: Befund: Harnblase gering gefullt, mittelständig, glatt konturiert. Ureteren nicht erweitert. Nieren mit rechts 63 x 28 x 40 mm* und links 30 x 16 x 12 mm bei bekannten Schrumpfniere links asymmetrisch groß, glatt konturiert, orthotop rechts mit normaler Parenchymbreite und -echogenität, Kelche und Nierenbecken beidseits nicht erweitert. Rektum mit ca. 24 mm stuhlgefüllt. Beurteilung: Unauffällige Niere rechts, ausgeprägte, bekannte Schrumpfniere link. Nierenarteriendoppler bei unruhigem Kind und durch unruhiges Geschwisterkind überforderte Mutter nicht durchführbar
Labor vom 06.09.18: I I/T Quotient maschinell 0.003; Natrium HP 140 [136-145 mmol/i]: Kalium HP 4.3

[3.4-4.5 mmol/I); Calcium 2.52 (2.25-2.75 mmol/i]; Chlorid 109 P+ (97-107 mmol/l); anorg, PO4 HP 1.32 [1.00-1.95 mmol/); Eisen 13,4 (5.2-16.3 umol/l]; Transferrin-Sättigung HP 21.0 [16.0-45.0 %]: Kreatinin (Jaffé) HP 0.34 [0.24-0.41 mg/di]; geschätzte GFR (eGFR n Schwart n berechenbar (ml/min); geschätzte GFR (eGFR Cystatin >90.0 [ml/min]; Albumin HP 44.9 (38.0-54.0 g/l]: Cystatin C HP 1.11 [0.50-1.00 mg/l); Transferrin HP 2.54 (g/l]; Ferritin HP 20.1 (6.0-67.0 g/l]; Alk Phosphatase HP 230 [142-335 U/l]; kleines Blutbild (EDTA) X; Differenzierung (maschinell) X; Hämoglobin 12.0 [10.2-13.4 g/di]; Hamatokrit (1/l) 0.353 [0.315-0.405 II]; Erythrozyten 5.0 (3.7-5.2 /pl]: Leukozyten 7.91 [6.00-15.00 /ni]; Thrombozyten 319 (220-490 /nl]; MCV 71.0 P- [72.0-93.0 fi); MCH 24.1 [23.5-31.0 pg]: MCHC 34.0 [30.0-35.0 g/di);
MPV 9.3 [7.0-12.0 fi]; RDW-CV 14.9 [11.5-15.0 %]: Neutrophile absolut 2.50 [1.50-8.70 /nij; unreife Granulozyten absolut 0.010 [<0.050 /ni]; Lymphozyten absolut 4.88 [3.00-10.00 /ni]; Monozyten absolut 0.42 [0.15-1.20 /ni]; Eosinophile absolut 0.09 [0.03-0.70 /nil; Basophile absolut 0.01 [0.00-0.20 /nl]:
aPTT falsches Volumen [26.0-40.0 sek.]:
Labor vom 21.08.18: I/T Quotient maschinell 0.004; Natrium HP 135 P- [136-145 mmol/l]; Kalium HP 4.4 [3.4-4.5 mmol/l]; Chlorid 97 (97-107 mmol/l); Eisen 4.2 P- (5.2-16.3 umol/l]; Transferrin-Sättigung HP 6.6 P- [16.0-45.0 %]; Kreatinin (Jaffé) HP 0.41 [0.24-0.41 mg/di); geschätzte GFR (eGFR n Schwart n. berechenbar [ml/min]; geschätzte GFR (eGFR Cystatin 83.9 [ml/min]; Harnstoff HP 23 [11-36 mg/di]; Protein HP 70 [56-75 g/l]; Cystatin C HP 1.22 [0.50-1.00 mg/l]; Transferrin HP 2.55 [g/l]; Ferri-tin HP 22.5 [6.0-67.0 Mg/l]; kleines Blutbild (EDTA) X; Differenzierung (maschinell) X; Hämoglobin 12.4
[10.2-13.4 g/di); Hämatokrit (i/l) 0.363 [0.315-0.405 II]; Erythrozyten 5.1 (3.7-5.2 /pl); Leukozyten 4.67
P- [6.00-15.00 /nl]; Thrombozyten 247 (220-490 /nij; MCV 71.0 P- [72.0-93.0 fi); MCH 24.2 [23.5-31.0 Pg): MCHC 34.2 [30.0-35.0 g/di]; MPV 9.7 [7.0-12.0 fl]; RDW-CV 15.3 P+ (11.5-15.0 %]; Neutrophile

22 8.2018
absolut 2.56 [1.50-8.70 /nl]; unreife Granulozyten absolut 0.010 [<0.050 /nlj; Lymphozyten absolut 1.20
P- [3.00-10.00 /nl]; Monozyten absolut 0.85 [0.15-1.20 /ni]; Eosinophile absolut 0.03 [0.03-0.70 /nl]:
Basophile absolut 0.02 [0.00-0.20 /nlj: Retikulozyten 26.7 [25.0-105.0 /nl); Reti% gemessen 0.52 [0.50-2.20 %]: Reti produktionsindex 0.3; unreife Thrombozyten 0.0 [1.1-6.1 %]: Ret-Hb 28.9 [28.5-34.5 pg);
Quick (TPZ) 76 [70-130 %]: INR 1.18 [0.90-1.25]; aPTT 41.9 P+ [26.0-40.0 sek.]: Thrombinzeit / Hepa-rinmethode 11.0 [<13.0 sek.]; Fibrinogen 2.57 [1.60-4.00 g/l]; AT3 89 [80-120 %); Faktor VIII 101 [50-150 %); Ristocetin-Co-Faktor 116 [50-160 %]; von Willebrand Antigen 115 (50-160 %]: VWF: Collagen-bindungs-Akt. 108 (60-130 %): D-Dimere 0.44 [<0.50 mg/l];G
29+6 5SW
Geamtbeurteilung: Tilo ist ein FG, das nach 30 3 SSW mit einem GG von 1.400 g im Sana-Klinikum Lichtenberg geboren wurde. Es liegt ein Infarkt der Arteria cerebri

media linksseitig vor sowie eine Nie-renvenenthrombose links mit einer Schrumpfniere links. Klinisch zeigen sich eine Mikrocephalie, eine Hemiparese rechtsseitig mit Knick-Senkfuß rechts, verdecktem Spitzfuß. Krampfanfälle seien bislang nicht aufgetreten, eine EEG-Verlaufskontrolle wird am 13.9.2018 durchgeführt, wir empfehlen zeitnah auch die Ultraschallverlaufskontrolle der Niere und ein nephrologisches Konsil bei Schrumpfniere rechts. Termine wurden der Familie mitgeteilt.
Eine Wiedervorstellung im SPZ Neuropädiatrie zur neuropädiatrischen und kinderorthopädischen Beurteilung ist für Januar 2019 vorgesehen mit der Frage, ob eine Orthesenversorgung notwendig. ist.
Regelmäßige Blutdruckkontrollen beim Kinderarzt sowie Empfehlung auch für Ultraschallkontrollen über Kinderarzt. Ein Termin in der nephrologischen Sprechstunde ist für den 13.9.2018 veranlasst. Ggfs
Kontrolle in der Hämatologie bei dezenter aPTT-Erhöhung Mit freundlichen Grüßen
Df. K. Dressel
Oberärztin
Komm. Leiterin Abt. Neuropädiatrier
Entwicklungsneurologie/ Neonatologie
Dr. E. Walch
FÄ für Pädiatrie mit Schwerpunkt Neuropädiatne
Inicoronato
Physiotherapeut
Soonabele
Ergotherapeutin

CHARITÉ
Charité I Campus Virchow-Klinikum I 13344 Berlin
Nachrichtlich:
M Familie T.
Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)
für chronisch kranke Kinder
Leitung: Prof. Dr. Angela M. Kaindl
Abteilung Neuropädiatriel
Entwicklungsneurologie/Neonatologie
Komm. Leitung: Dr. Katrin Drossel Tel.
Fax.
+49 (0)30 450 566 408
+49 (0)30 450 566 911
spz-neuropaediatrie@charite.de
spz.charite.de
Berlin, den 05.09.2018 / Kr
FallNr.: 0312128478
Quatität und
Entwicklung in
Ärztliche Bescheinigung zur Vorlage im KJGD/Jugendamt
Betr.: erhöhter sozialpädagogischer Förderbedarf
Tilo T., geb. am: 31.12.2016, wohnhaft: Torgauer Str. 47, 12627 Berlin,
Diagnosen:
Achse 1: Somatische Diagnosen:

29x 95sw lit 14709
Eutrophes FG 202-C9W, GG 1:470g
AT3-MangelNierenvenenthrombose links
Schrumpfniere links
V.a. renalen Hypertonus
Infarkt der Arteria cerebri media links V.a. Hemiparese rechtsseitig
Mikrocephalie
Achse 2:
Intelligenz/Entwicklung:
Motorische Entwicklungsstörung
Achse 3: Psychiatrisch/psychologische Diagnosen:
Achse 4: Psychosozialer Hintergrund:
(P07.3G, P07.11G) Z. n.
(P29.8G)
(163.5G)
(G81.1G)
(F82.9G)
nicht vergeben nicht vergeben
Sehr geehrte Damen und Herren,
Tilo befindet sich aufgrund der o.g. Diagnosen in unserer ambulanten Mitbetreuung. Letztmalig sahen wir das Kind in unserer ambulanten Sprechstunde am 5. 9. 2018
Tilo ist ein ehemaliges frühgeborenes Kind, das nach 38 3 SSW mit einem GG von 1.400 g und wurde im Sana-Klinikum Lichtenberg geboren. Es liegt ein Infarkt der Arteria cerebri media linksseitig vor sowie eine Nierenvenenthrombose links mit einer Schrumpfniere links. Klinisch zeigen sich eine Mikrocephalie, eine Hemiparese rechtsseitig mit Knick-Senkfuß rechts, verdecktem Spitzfuß.
Nach unserer fachärztlichen Einschätzung gehört der Patient auf Grund der o. g. Diagnosen, die länger als ein halbes Jahr bestehen, zum Personenkreis des § 53 Abs. 1 SGB XII in Verbindung mit dem § 2 SGB IX und hat Anspruch auf Teilhabe an der Gesellschaft nach § 55 Abs. 2,1 ff SGB 1.
CHARITÉ - UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN
Gliedkörperschaft der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin
Augustenburger Platz 1l 13353 Berlin Telefon +49 30 450-50 l www.charite.de
Berliner Sparkasse l BLZ 100 50 000l Konto 127 000 555 0

Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) für chronisch kranke Kinder
Fortsetzung Arztbrief: T., Tilo, geb. 31.12.2016
Wir empfehlen zur Unterstützung der weiteren Entwicklung, die Betreuung des Kindes im Kindergarten durch eine/n Integrationserzieher/in. Aus unserer fachärztlichen Sicht besteht bei Tilo ein erhöhter sozialpädagogischer Förderbedarf gemäß § 4 (7) Kindertagesförderungsverordnung - VO - KitaFöG.
Wir halten eine zusätzliche Förderung der Grob- und Feinmotorik, der Körperwahrnehmung, und der altersgerechten Selbstständigkeit im Kindergarten für angezeigt.
Das Kind wird auch weiterhin regelmäßig in unserer spezialisierten Einrichtung medizinisch betreut.
Für weitergehende Fragen stehen wir gern zur Verfügung
Mit freundlichen Grüßen

Dr. K. Drossel
Oberärztin
Komm. Leiterin Abt. Neuropädiatrie/ Entwicklungsneurologie/ Neonatologie
Dr. E. Walch
FÄ für Pädiatrie mit Schwerpunkt Neuropädiatrie
Dipl. Sozialpädagogin

CHARITÉ
CharitéCentrum für Frauen-, Kinder und Jugendmedizin mit Perinatalzentrum und Humangenetik
Charité I Campus Virchow-Klinikum I 13344 Berlin
Familie T.
Torgauer Str. 47
12627 Berlin
BAR
27. SEP. 2019
10103 - Berlin Merzann-*e:
Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)
für chronisch kranke Kinder
Leitung: Prof Dr. Angela M. Kaindl
Abteilung Neuropädiatrie/ Entwicklungsneurologie/Neonatologie
Komm. Leitung: Dr. Katrin Drossel
Tel. +49 (0)30 450 566 408
Fax. +49 (0)30 450 566 912
spz-neuropaediatrie@charite.de
spz.charite.de
Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Neurologie
Leitung: Prof. Dr. Angela M. Kaindl
Quatität und Entwicklung in
Datum: 19.09.2019 / lö/Wa
FallNr.: 0313146142
Nachrichtlich:
Betr.:
T., Tilo, *31.12.2016 wohnh.: Torgauer Str. 47, 12627 Berlin
Zur Vorlage bei der Krankenkasse: Beantragung einer SPZ Doppelbetreuung

Diagnosen:		
Achse 1:	Somatische Diagnosen:	
	Eutrophes FG, 30 + 3 SSW, GG 1.470 g	(P07.3G, P07.11G)
	Z. n. AT3-Mangel	
	Nierenvenenthrombose links	(P29.8G)
	Schrumpfniere links	
	V.a. renalen Hypertonus	

	Infarkt der Arteria cerebri media links	(163.5G)
	Hemiparese rechtsseitig	(G81.1G)
	Knick-Senkfuß rechts, verdecktem Spitzfuß	
	Mikrocephalie	(Q02.0G)
Achse 2:	Intelligenz/Entwicklung:	
	Motorische Entwicklungsstörung	(F82.9G)
	Achse 3: Psychiatrisch/psychologische Diagnosen:	nicht vergeben
	Achse 4: Psychosozialer Hintergrund:	

Sehr geehrte Damen und Herren,
Wie Sie aus den oben genannten Diagnosen sehen liegt bei Tilo eine eine Hemiparese rechtsseitig nach zerebralem Infarkt sowie eine Schrumpfniere bei Nierenvenenthrombose vor. Die diagnostische und medizinische Betreuung (Kinderneurologie, Kindernephrologie, Entwicklungsneurologie) erfolgt in unserem Hause. Therapeutisch soll das Kind wohnortnah im SPZ Hellersdorf betreut werden und seine Therapien erhalten.
Wir beantragen deshalb für das 1. und 3. Quartal 2020 die zusätzliche Betreuung des Kindes im SPZ der Charité Fachbereich Neuropädiatrie.
CHARITÉ - UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN
Gliedkörperschaft der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin
Augustenburger Platz 1 I 13353 Berlin I Telefon +49 30 450-50 I www.charite.de

Klinik für Neonatologie
Direktor Prof. Dr. Christoph Bührer
Arztbrief: T., Tilo, geb. 31.12.2016, Fallnummer: 0310638421
Erhebliche Besserung unter Milrinone + Betablocker. 17.01. Im Vergleich zum Vorgefund weiterhin gebesserte Funktion, Herz eher hyperkontraktil. MI GI weiterhin darstellbar. Orientierend gebesserte kardiale Funktion in der Verlaufskontrolle. Kreislaufunterstützung wie besrochen reduzierbar.
Uro-/Abdomensonographie vom 14.01.: Harnblase gut gefüllt, glattandig, mittig, keine Konkrememte.
Niere rechts normal konfiguriert, atemverschieblich, keine Stauung des NBKS, Nierenarterie und Nierenene frei. Größe: 40 x 22 x 24 mm. Niere links deutlich vergrößert (51 x 37 x 31 mm), global deutlich verwaschen, aufgehobene Mark-Rinden-Differenzierung,
NBKS kollabiert. Nierenarterie
angedeutet, Nierenvene mit Lumen NICHT darstellbar. Vena cava inferior subdiaphragamal frei. V.a.

Nierenvenenthrombose links 16.01. Bds. orthotop. rechte Niere mit 3,8 x 2,3 x 2,2 cm normal groß, regelrechte Mark-Rinden-Differenzierung, keine Erweiterung des NBKS, arterielle Perfusion mit RI von 0,88, Vmax 60 cm/s venöser Abfluss mit zentralvenösem Flussmuster. 17.01. Niere links weiterhin verwaschen, venöser Abfluss unterbrochen darstellbar. Nierenmaße links 4.77x3cm längs, rechts 3.6c2.2cm längs. linke Niere eher kugelig. Linke Niere massiv vergößert, verplumpt. 4,4 x 3,1 x 2,9 cm, deutliche Entdifferenzierung des Parenchyms, inhomogen mit eher erhöhter Ecchogenität. Im pw-Doppler der A renalis auffäliges Flussprofil mit systolischem Einstrom mit einer verminderten Vmax <20 cm/s und bereits mittdiastolischer retrogradem Fluss mit einem folglich erhöhten RI > 1,0 als Zeichen des erhöhten intrarenalen Widerstands. Im FKDS Sgmentarterien im Verlauf darstellbar. Venöser Abfluss über V renalis mit bandförmigem Flussmuster und erhöhter Abflussgeschwindigkeit von bis 20 cm/s. Eine direkte Darstellung einer Thrombosierung des Gefäßes gelingt nicht. VCI im intraabdominellen Verlauf im oberen Abdomen bis unterhalb des confluens V. portae darstellbar ohne Anhalt auf eine Thrombosierung. 22.01.
Niere rechts: unauffällige Lage, Form, Größe (rechts 3,89x1,86cm) und Kontur ohne Zeichen einer
Harnabflussstörung,
Vergleich
zum Vorbefund
(Nierenvenenthrombose) mit deutlich rückläufiger Größe (3,94x2,24cm), deutlich verbesserter Mark-Rinden Differenzierung, weiterhin etwas kollabiertem NBKS und kleinen echoreichen Bezirken bei in Organisation befindlicher Nierenvenenthrombose. Nierenvene am Hilus nicht sicher darstellbar. Kontrolle vom 29.01.2017: Nieren bds. orthotop und atemverschieblich gelegen. Rechtsseitig Größen in der Norm, keine Zeichen für nephrokalzinose. Normaler arterieller Fluss, venös um 10 cm/s (arteriell überlagert bis
. Gute Mark-Rinden Differenzierung rechts. Links: deutlich gebesserte Mark-Rinden Differenzierung. Arterieller Fluss gut, nicht beschleunigt. Venöser Fluss eher reduziert mit ca 2-5 cm/s in meherer kleinen Venen.
Hüftsonographie vom 01.02.2017: Bds Typ Ia/b nach Graf; links alpha 68°, beta 63°; rechts alpha 71°, MRT vom Kopf vom 16.01.2017: Ausgedehnter, frischerer Mediateilinfarkt links unter Einbeziehung der Inselregion, des frontoparietalen Operculum sowie des Putamens und des Globus Pallidum. Geringe hämorrhagische Imbibierung im linken Centrum semiovale. Dabei kein Nachweis einer höhergradigen raumfordernden Wirkung. Verdacht auf partiell umspülten Thrombus in der linken MCA-Bifurkation.
IV. Sonstige Diagnostik
EKG vom 30.01.2017: SR, Steiltyp, Hf 120/min. PQ 110 ms, QRS 60 ms, QTc 381 ms. Weiterhin rechtsbetonte Brustwandableitung, weiterhin unspezifische geringe ST-Streckenveränderungen, keine
ES
Langzeit EKG vom 01.02.2017: kont. SR mit normalem Frequenzspektrum (144-157-195/min).
Keine Extrasystolen, keine pathol. Tachykardien, Bardykardien oder Pausen.
Fundoskopie vom 31.01.2017: BA: ROP 0 Zone III; W zur Verlaufskontrolle in 2 Wochen erbeten.
Therapie und Verlauf

Aufgrund eines renal bedingten arteriellen Hypertonus zeigte sich echokardiografisch und auch laborchemisch eine deutliche Linksherzinsuffizienz, welche unter adäquater antihypertensiver Therapie mit Propranolol und einer intermittierenden Kreislaufunterstützung mit Milrinone rückläufig war. Im Verlauf Auftreten von schweren Bradykardien unter Propranolol-Therapie, sodass die Gaben beendet wurden. Anschließend allzeit normotone Blutdrücke. Nach Stabilisierung des Kindes problemlose Extubation unter atemanaleptischer Therapie mit Coffein.

Gentamicin
Tobramycin
Cotrimoxazol
Ciprofloxacin
Moxifloxacin
Erythromycin
Clindamycin
Vancomycin
Rifampicin
Linezolid
Fosfomycin
Doxycyclin
Tigecyclin
S <=0.5
S
S
<=10.0
S
S
S 0.5
S 0.25
S <=0.5
S <=0.03
S 2.0
S <=8.0
S <=1.0
S<=0.12
Screening auf multiresistente Erreger (MRSA, MRGN): 17.01. Enterobacter cloacae complex positiv 2
MRGN NeoPäd (KRINKO)
CMV-DNA im Urin (quant. PCR) vom 14.01.2017: negativ
II. Screening
Vorsorgeuntersuchungen: U1/U2 wurden im Sana Klinikum, U3 wurde hier durchgeführt.
Hörtest: bds. pass (BERA vom 10.1.17, Sana Klinikum Lichtenberg) sowie am 03.02.2017: bds pass Neugeborenenscreening: wurde zeitgerecht abgenommen am

2.1.17 (Sana Klinikum, Befund nicht bekannt); sowie am 23.1.2017 (Screening ID 051 235 121 435): unauffällig.
III. Bildgebung
Schädelsonographie vom 14.01. 12:55 Uhr: Echogenitätserhöhung links occipital, im Parenchym. rechts nur gering direkt periventrikulär. Intrakranielle Blutung/Thrombose nicht sicher auszuschleibar. Keine IVH.
Deutliches Hirnödem (RI 0,37)+ 14.01. 18:20 Uhr : Weiterhin deutlich erniedrigter RI, vorbeschriebene Echogenitätserhöhung links parital markiert sich jetzt noch deutlicher, ca 1,3 x 1,3 cm grosser Areai hyperechogen, keine Zysten, am ehsten Blutung -> Hepariniserung auf 200 IE/kg/d reduziert. 15.01.
Weiterhin Abnahme des RI, deutl. Echogenitätserhöhung li parietal bis occzipital- V.a Parenchymblutung Im vergleich zur Voruntersuchung keine deutl. Progredienz.
17.01. Zerebraler Ultraschall: RI 0.74, Gyrierung regelrecht, äußere Liquorräume darstellbar. Hyperechogenes Areal links parietal unverändert.
22.01. bekanntes Areal periventrikulär links weiterhin echoreich ohne klar darstellbare Zysten bei Z.n.
Mediainfarkt links darstellbar. SV und Sagittalschnitte aufgrund von Kreissaaleinsatz nicht dargestellt.
Flussgeschwindigkeit ACI intrakraniell geringer als extrakraniell, somit kein Hinweis auf erhöhten Hirndruck bei ebenso unauffälligem RI ACA. Kontrolle vom 01.02.2017: Deutliche Demarkation des infakrtareals links fronto-parietal. 0,7 x 0,8 cm Zyste im anterioren Infarktbereich. Kontrolle vom
03.02.2017: stabiler Befund, Zyste links im Hirnparenchym 1,02 x 0,9; bekanntes Infarktareal links Echokardiographie vom 14.01. 13:40 Uhr: Linker Ventrikel deutlich balloniert und Volumen-überladen, sehr schlechte globale Funktion. RV klein, gut kontraktil. PFO offen. TI I, MI I, AI I, PI 1I. AV VTI 5 cm.
PDA verschlossen. Kein struktureller intrakardialer Herzfehler, jedoch Enge am Aortenbogen auf minimal 2,7 mm, dort keine Flußbeschleunigung (bei schlechter Funktion). RR weiterhin hoch, sysst RR um 100 mmHg, an allen Extremitäten.Beurteilung: Indikation für Corotrop bei globaler LV-Funktionsstörung. Cave: Aortenisthmus! ggf KiKa-Kontrolle kurzfristig! 14.01. 16:05 Uhr Echo nach 2 Stunden unter Corotrop 0,7 mg/kg/min. Funktion geringgradig besser, LV weiterhin dtl. vergrößert. Weiterhin keine Flußbeschleunigung am Isthmus, jedoch weiterhin Enge <3 mm. Befund Kopf (Echogenitätserhöhung links parietal) idem. Beurteilung: ggf Kika Echo. Medikamentöse RR Senkung? Procedere positiv inotrope Medikation? Kinderkardiologisches Echo vom 14.01.: Befund: Situs solitus, strukturell normales Herz Unter Corotrop jetzt (im Verlauf verbesserte) noch dtl.eingeschraenkte LV Fx bei grossem LV. PFO. Mini PDA LR Shunt, Rv dtl kleiner als LV, TI 1 ohne sign. PHTbNachweis., LVIDd 18 mm, FS 29%, planimetrische EF 44%, MI 1-2, keine AS, Diameter AKL 6 mm, Isthmus paraductal 4 mm ohne Flussbeschleunigung. Beurteilung:#Kein Vitium, art. Hypertonus bei Nierenvenethrombose, am ehesten dabei kardial dekompensiert, DD CMP. Weiter Corotrop, auch Diuretika, Verlaufskontrollen. Einstellung Hypertonus. 15.01.17 Deutlich gebesserte Fx im Vgl. zum Vorbefund unter Milrinone und Propranolol. Visuell EF 55%, im M-Mode noch besser, LV noch leicht abgerundet. AoVTI mit 10,6 cm ebenfalls dtl. besser. Keine rel. MI mehr, nur noch triviale AI. PV unauffällig. IVC OK. Kein PE, kein PLE. Beurteilung:

Klinik für Neonatologie

Direktor Prof. Dr. Christoph Bührer
Arztbrief: T., Tilo, geb. 31.12.2016, Fallnummer: 0310638421
59 [51-73 g/l]; GPT (ALT) 12 [<41 U/l]; GOT (AST) 66 [16-96 U/l]; Alk. Phosphatase 170 [122-469 U/];
Quick (TPZ) 81 [70-130 %]; INR 1.14 [0.90-1.25];
aPTT 45.8 [30.0-46.0
Thrombinzeit/
Heparinmethode s. Kom. [<13.0 sek.]; Fibrinogen 5.91 P+ [1.60-4.00 g/l]; AT3 56 [48-108 %]; D-Dimere
16.86 P+ [0.58-2.74 mg/l]; 14.01.17 12:47 (60662, Endbefund):
Na+ 118 [mmol/L]; K+ 4.9 [mmol/L]; Ca++ 1.27 [mmol/L]; Glu 121 [mg/di];
Diagnose- und therapiebestimmende Werte im Verlauf: Quick (TPZ) 95 [70-130 %]; INR 1.03 [0.90-1.25]; aPTT 40.4 [30.0-46.0 sek.]; Fibrinogen 4.01 P+ [1.60-4.00 g/l]; AT3 58 [48-108 %];
Natrium HP 135 P- [136-145 mmol/l]; Kalium HP 4.9 P+ [3.4-4.5 mmol/l]; anorg. PO4 HP 2.22 [1.25-2.50 mmol/l]; Magnesium 1.06 [mmol/l]; Faktor VIII 120 [50-150 %]; Protein C 39 [24-51 %]; Protein S 64 [33-67 %]; Kreatinin (enzym.) 0.50 [0.31-0.88 mg/di]; Albumin 29.7 P- [38.0-54.0 g/l]; Immunglobulin G 2.57
[2.32-14.11 g/l]; Immunglobulin A <0.02 [<0.83 g/l]; Immunglobulin M 0.20 [<1.45 g/l]; ges. Cholesterin 152
P+ [54-151 mg/di];
Triglyceride 189 [<200 mg/dl]; Quick (TPZ) 80 [70-130 %]; Thrombinzeit / Heparinmethode 13.1 P+ [<13.0 sek.]; Anti-Xa-Aktivitaet NMH 1.14 P+ [<0.10 U/ml]; CK-MB% 77 [%];Albumin 27.4 P- [38.0-54.0 g/l]; Troponin-Ths 226 P+ [<50 ng/l]; Creatinkinase (CK) 101
[<190 U/l]; CK-MB 78.0 P+ [<24.0 U/l]; LDH 920 P+ [225-600 U/l]; TSH basal 1.38 P- [2.02-8.05 mU/l];
Letzte Laborwerte vor Entlassung:
Albumin 34.2 P- [38.0-54.0 g/l]; Quick (TPZ) 78 [70-130 %]; aPTT in Arbeit [30.0-46.0 sek.]; PTT Actin-FS (lupusinsensitiv) 71.7 P+ [25.0-33.0 sek.]; Thrombinzeit / Heparinmethode 15.0 P+ [<13.0 sek.];
Urin vom 23.01.2017: Ascorbinsäure negativ [negativ]; Urinstatus semiquantitativ siehe Kommentar; pH-Wert-Teststr. 7.0 [4.8-7.4]; Glucose-Teststr.
negativ [negativ]; Protein-Teststr. positiv P+ [negativ];
Urobilinogen-Teststr. normal [normal]; Bilirubin-Teststr.
negativ [negativ]; Ketone-Teststr.
[negativ]; Leukozyten-Teststr. positiv P+ [negativ]; Blut-Teststr. (Erys) positiv P+ [negativ /pl]; Nitrit-Teststr.
negativ [negativ];
1.010 [1.010-1.020]; Urinsediment
Leukozytenzählung entfällt [<25 /ul]; Creatinin Ur 6 [39-259 mg/di]; Protein Ur 255.4 [<150.0 mg/l]; Protein Ur/Krea 4009 [<140 mg/gKrea]; Albumin Ur 77.7 P+ [<20.0 mg/l]; Albumin Ur/Krea 1220 P+ [<20 mg/gKrea];
Urin vom 02.02.2017: pH-Wert-Teststr. 7.0 [4.8-7.4]; Glucose-Teststr. negativ [negativ]; Protein-Teststr. negativ [negativ]; Urobilinogen-Teststr. normal [normall; Bilirubin-Teststr. negativ [negativ]; Ketone-Teststr. negativ [negativ]; Leukozyten-Teststr. 25 [negativ]; Blut-Teststr. (Erys) negativ [negativ /ull; Nitrit-Teststr. negativ [negativ];
1.005 P- [1.010-1.020];

Leukozytenzählung <25 [<25 /ull; Osmolalität UR 70 [mosmo/Kg]; Creatinin Ur 8 [39-259 mg/dij; Protein Ur 62.5 [<150.0 mg/l]; Protein Ur/Krea 816 [<140 mg/gKrea]; Albumin Ur 5.4 [<20.0 mg/l]; Albumin
Ur/Krea 70 P+ [<20 mg/gKrea];
Mikrobiologie/Virologie:
Tracheobronchialsekret vom 15.01.2017
Keim 1 geringes Wachstum von
Staphylococcus aureus
Keim 1 Keim 2 Keim 3 Keim 4 Keim 5 Keim 6

ANTIBIOGRAMM:	
Cefoxetin-screen	
Levofloxacin	S <=0.12
Fusidinsäure	S <=0.5
Mupirocin	S <=2.0
Teicoplanin	S <=0.5
Daptomycin	S 0.25
Penicillin	R >=0.5
Oxacillin	S <=0.25
Ampicillin	R
Piperacillin	R
Ampicillin/Sulbactam	S
Piperacillin/Tazobactam S	
Imipenem	S
Meropenem	S
Cefazolin	S
Cefuroxim	S
Ceftriaxon	S
Ceftazidim	R

CHARITÉ
CharitéCentrum für Frauen-, Kinder- und Jugendmedizin mit Perinatalzentrum und Humangenetik
Charité I Campus Virchow Klinikum I 13353 Berlin
Frau
Dipl.-Med. Felicitas Temler Ärztin für Kinderheilkunde
Teterower Ring 48
12619 Berlin
Klinik für Pädiatrie mit Schwerpunkt Neurologie
Direktorin: Prof. Dr. Angela M. Kaindi
Station 28/29
Tel.: + 49 (0)30 450 - 566 382

Fax: + 49 (0)30 450 - 566 928
Anmeldung
Poliklinik Neuropädiatrie
Tel.: + 49 (0)30 450 - 566 625
Fax: + 49 (0)30 450 - 566 953
E-mail: neuropaediatrie@charite.de
Sozialpädiatrisches Zentrum
Tel.: + 49 (0)30 450-566 188
Notfallambulanz der Kinderklinik
Tel.: + 49 (0)3Q 450 - 566 128
Berlin: 31.12.2017 / MG
Fall-Nr.: 0311381600
Nachrichtlich:
NZ
* Frau J. T., Torgauer Str.47, 12627 Berlin
2 MRGN Keim rektal
Endgültiger Arztbrief
Sehr geehrte Frau Kollegin Temler,
wir berichten Ihnen über den Patienten T. Tilo, geb. am 31.12.2016, wohnhaft: Torgauer Str. 47,
12627 Berlin, der sich vom 30.10.2017 bis zum 02.11.2017 in unserer stationären Betreuung befand.
Diagnosen:
Eutrophes FG, 30 + 3 SSW, GG 1.470 g
Nierenvenenthrombose links
AT3-Mangel
Perinataler Infarkt der Arteria cerebri media links Zentrale Muskeltonus- und Koordinationsstörung rechts
Renaler Hypertonus
Mikrozephalie
Anamnese: Elektive Aufnahme zur Diagnostik bei Frühgeburtlichkeit, rechtsseitige armbetonte Muskeltonus- und Koordinationsstörung und Nierenvenenthrombose. Betreuung im SPZ Charité Abteilung Neuropädiatrie. Tilo entwickelt sich laut Mutter sehr gut. Seit einigen Tagen Infekt der oberen Luftwege und subfebrile Temperaturen. Medikation bei Aufnahme: Keine Klinischer Status: 10 Monate alter, korrigiert & Monate alter Junge in gutem AEZ/adipösem EZ o.ä., KL 77 cm (P82), KG 14,1 kg (2 kg >P99), KU 41,6 cm (2 cm<P3). Wach, freundlich, Kontaktaufnahme altersentsprechend, lautiert Doppelsilben. Pädiatrisch-intern: Kardiopulmonaler Auskultationsbefund und abdomineller Tastbefund unauffällig, Rachenring minimal gerötet. Äußeres Genitale unauffällig männlich, Hoden deszendiert. Keine phänotypischen Auffälligkeiten. Große Gelenke frei beweglich, Wirbelsäule gerade. Neurologisch: Pupillen isokor, Lichtreaktion direkt und indirekt seitengleich und prompt, Okulomotorik unauffällig, Mimik symmetrisch unauffällig, Schluckakt unauffällig, kein Speicheln, wendet Kopf zu Geräuschquelle. Spontanmotorik links betont, Muskeltonus rechte Extremitäten erhöht. Rumpfmuskulatur hypoton. In Bauchlage beidseitiger Unterarmstütz, Kopfheben bis 90°. Beidseitiges gezieltes Greifen, Transferieren. Sitzt noch nicht frei, sichere Kopfkontrolle im Sitz und bei Lageänderungen,

EEG vom 30.10.2017: Stark Artefakt-überlagertes EEG. Hintergrundaktivität ca. 4 Hz, altersentsprechend. Bei starker Artefakt-Überlagerung kein sicherer Hinweis für epilepsietypische Potentiale (ETP) • oder eine regionale Hirnfunktionsstörung. Keine Befunderweiterung Hyperventilation und FS. Beurteilung: Artefakt-gestörtes EEG ohne eindeutigen Hinweis für epilepsietypische Potentiale (ETP) oder eine regionale Hirnfunktionsstörung. Bei fortbestehendem klinischem Anhalt für Krampfanfälle evtl. Kontrolle im Schlaf im Verlauf.
CHARITÉ - UNIVERSITÄTSMEDIZIN BERLIN
Gliedkörperschaft der Freien Universität Berlin und der Humboldt-Universität zu Berlin Augustenburger Platz 1 13353 Berlin | Telefon +49 30 450-50| www.charite.de

Klinik für Pädiatrie m. S. Neurologie Direktorin: Prof. Dr. Angela M. Kaindl
Fortsetzung Arztbrief:
T., Tilo, geb. 31.12.2016
2
EKG: SR. Steiltyp, Hf 136/min. PO 120 ms, QRS 50 ms. QTc 411 ms. Keine Hypertrophiezeichen,
keine ERBS, keine ES.
Echokardiographie vom 01.11.2017: Leber- und Lungenvenen normal mündend, Atrioventrikuläre und Ventrikuloarterielle Konkordanz Septen intakt AV- und arterielle Klappen suffizient und ohne Stenosen. RV und LV Funktion gut, keine Dyskinesien, RVOT, Pulmonalbifurkation, RPA und LPA unauffällig (e PDA). LVOT, AoAsc, AoBogen und AoDesc unauffällig (o ISTA), kein PE. M-Mode (mm): LVDd 24,2; LVDs 17; IVSd 5,7; PWd 5, FS 30%. Plan. EF 66. TAPSE: 1,3cm. Doppler (m/s): TV ,8/; MV,8/1; PV 1; AoV 1, Isthmus 1,5.
Beurteilung: Kein Hinweis für Vitium cordis/Kardiomyopathie oder PHT.
MR Kopf vom 30.10.2017: Klinik, Fragestellung, Rechtfertigende Indikation: Mediainfarkt der ACM H. perculum, Putamen. Palidum. Technik 3 Tesla. Koofsoule. Lokalisationssequenzen, axiale T2 * axiale 12 TIRM, arterielle TOF, axiale T1-Flash, sagittale T2-TSE, axiale EPI | DWI. Vergleich mit Voraufnahmen vom 16.01.2017. Zustand nach
vorbeschriebenem Mediainfarkt
Parenchymdefekten im Stammganglienbereich und frontoparietalen Operculum links. Konsekutive evacuo Erweiterung des linken Seitenventrikels sowie Ausdünnung des Corpus callosum. Keine frischen oder in der Zwischenzeit aufgetretenen Infarkte. Normale intrakranielle, arterielle Hauptstammgefäße. Normales
Übrigen. Altersgerechte Myelinisierung.
Nasennebenhöhlen nur partiell belüftet. Freie Mastoide und Paukenhöhlen. Lymphknoten in den miterfassten Halsabschnitten. Beurteilung: Zustand nach Mediainfark links.
mm, normal groß, normal konfiguriert, glatt konturiert, normale Parenchymbreite, normale Parenchymechogenität, Kelche und Nierenbecken nicht erweitert. Rechter Ureter nicht erweitert.
Nierenvene rechts frei durchströmt. Im Nierenhilus rechts. Regelrechtes arterielles Flusssignal, kein Hinweis auf vorgeschaltete hämodynamisch relevante Stenose. Nierenarterienabgang beidseits nicht darstellbar. Linke Niere orthotop, mit 31 mm x 13mm x 10mm zu klein, normal konfiguriert, glatt konturiert, normale Parenchymbreite, normale Parenchymechogenität, Kelche und Nierenbecken nicht erweitert. Linker Ureter nicht erweitert. Links keine Perfusion darstellbar. Beurteilung:

Unauffällige Niere rechts, ausgeprägte Schrumpfniere links, am ehesten auf dem Boden der bekannten Nierenvenenthrombose. Rechts kein Hinweis auf eine Nierenarterienstenose, Nierenarterienabgang beidseits nicht beurteilbar.
Verlauf und Beurteilung: Wir nahmen Tilo geplant zur umfangreichen Diagnostik auf. Während des stationären Aufenthaltes entwickelte Tilo Fieber bis 40 °C, welches sich unter Antipyrese gut senken ließ. Er erhielt außerdem eine Antibiose mit Unacid bei unklarem Focus des Fiebers.
Die kardiologischen Untersuchungen zeigten keinen
Anhalt für einen
Herzfehler,
Kardiomyopathie oder eine pulmonale Hypertonie. Im EEG zeigten sich keine epilepsietypischen Potentiale. In der cMRT-Untersuchung in Sedierung leichte Erweiterungen der Seitenventrikel, die vereinbar sind mit dem stattgehabten Mediainfarkt. Eine Therapie ist nicht erforderlich. Die ausführliche Besprechung der Befunde wird im SPZ durch Frau Dr. Walch erfolgen.
Es erfolgte ein rektaler Abstrich bei bekanntem 2-MRGN Keim. Der Abstrich war negativ.
Wir konnten Tilo in gutem Allgemeinzustand am 02.11.2017 in die Häuslichkeit entlassen. Vor Entlassung enolgte ein Gespräch mit der Familienhelferin Frau Krüger per Telefon über die psychosoziale Situation der Familie, welche als ausreichend gut bestätigt wurde.
Entlassungsbefund: Guter Allgemeinzustand, fieberfrei Empfohlene / Mitgegebene Medikation bei Entlassung: Keine Empfehlungen: Nächster Termin im SPZ Charité Abteilung Neuropädiatrie am 08.11.2017
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern unter den im Briefkopf genannten Rufnummern oder der zuständigen Stationsstützpunktnummer 030 450-666455 zur Verfügung.
Stane
iV C
Dr. C. Prager
Direktorin der Klinik
Oberärztin
L. Barbera
Assistenzärztin

OBERLIN KLINIK
Oberlinklinik I Rudolf-Breitscheid-Str, 24 I 14462 Polsdem
Lebenshilfe gGmbH - SPZ
Herr Dr. med. Christian Michael
Ärztlicher Leiter
Blumberger Damm 158
12679 Berlin
Ansprechpartner
Dr. med. Gert Pietsch
Leiter
Abteilung
Ambulantes Zentrum für Menschen mit
Behinderung
Kontakt

Tel.: 0331 763-4691
Fax: 0331 763-4692
• azmb@oberlinhaus.de
Unser Zeichen: pie - eng
Datum: 03.02.2021
T., Tilo, *31.12.2016,
12627 Berlin; Torgauer Str. 47
Sehr geehrter Herr Kollege, ich berichte über die neuroorthopädische Konsiluntersuchung Ihres o. g. Patienten am 29.01.2021.
Diagnosen:
ICP nach FG 30. SSW
Arteria-Media-Infarkt links spastische Hemiparese rechts
Schrumpfniere links nach Nierenvenenthrombose ? AT3-Mangel
dystone-teilkontrakte Arm- und Handgebrauchsstörung rechts
Gangstörung
Innentorsion rechte Hüfte hochkontrakter Spitz-Supinationsfuß rechts Arm- und Beinlängendifferenz
Anamnese:
Zweit-Para.
Älteres und jüngeres Geschwisterkind sind gesund.
Bei Plazentaruptur Not-Sectio 30. SSW, 1.470 g.
Vermutlich unter AT3-Mangel ist es dann zum Hirninfarkt linksseitig wie auch zur Nierenvenenthrombose links gekommen.
Wegen Letzterer ist er aus der Entbindungsklinik Sana-Klinikum frühzeitig in die Charité verlegt worden, dann dort für zwölf Wochen Neonatologie.
Mit Entlassung nach Hause ist die Hemiparese bereits bekannt gewesen, entsprechend frühzeitige Physiotherapie.
Oberlinklinik gGmbH I Orthopädische Fachklinik I Rudolf-Breitscheid-Str. 24 I 14482 Potsdam
Tel.: 0331 763-4312 I Fax: 0331 763-4322 I info@oberlin-klinik.de I www.oberlin-klinik.de Gesellschafter: Verein Oberlinhaus I Geschäftsführung: Andreas Koch, Oliver Pommerenke
Gerichtsstand: Amtsgericht Potsdam I HRB 20086 P I USt-IdNr.: DE 252 092 291
Bankverbindung: Evangelische Bank eG I IBAN: DE76 5206 0410 0008 0250 96 I BIC: GENODEF1EK1
Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e. V.
Verbund christlicher Kliniken
Brandenburg
Ein Unternehmen im OBERLINHAUS
Im Verbund der Diakonie P

ASKLEPIOS
FACHKLINIKUM LÜBBEN
Γ
Asklepios Fachklinikum Lübben • Luckauer Straße 17 • 15907 Lübben
Familie T.
Dorfstr. 25a
15738 Zeuthen
Fachklinikum für Psychiatrie und Neurologie

Klinik f. Kinder- u. Jugendpsychiatrle, Psychotherapie u. Psychosomatik Chefärztin Dr. med. A. Donchin
Tagesklinik/Institutsambulanz KW
Oberarzt D. Illy
Cottbuser Straße 53 a + b
15711 Königs Wusterhausen
Telefon: (0 33 75) 52667-10/-20
Telefax: (0 33 75) 52667-30
sek.tkkw.luebben@asklepios.com
www.asklepios.com/luebben
S.WINDHEIM / S.WINDHEIM
KReiBE WuPterheeper20069P14032024
Abschlussbrief Diagnostik
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, wir berichten über den Patienten T., Tilo, geb. am 31.12.2016, Dorfstr. 25a, 15738 Zeuthen, der sich zuletzt am 09.10.2024 in hiesiger ambulanter Behandlung befand.
Diagnose/n:
Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung
F90.0
Einweisungsmodus:
Der Patient stellte sich in Begleitung seiner sorgeberechtigten Mutter auf Überweisung von Frau Mosch
(MVZ) in unserer PIA zum Erstgespräch vor. Begleitet wurde die Familie von der Familienhelferin Frau
Vorstellungsanlass:
Es bestehe laut Tilos Mutter der Verdacht auf ein ADHS, da Tilo agiere "wie ein Flummi". Eine Abklärung sei vor allem durch die Kita angeregt worden. Die Einschulung sei für das aktuelle Schuljahr auf einer. regulären Schule geplant. Es bestehe Förderstatus im körperlich-motorischen Bereich. Man habe Sorge, dass Tilo den Anforderungen in der Schule nicht gerecht werden könne, weil er kaum bei der Sache bleiben könne. Die Frustrationstoleranz sei gering, besonders im Kontakt mit seiner Mutter. Tilo bestimme auch die Art wie sein Zimmer gereinigt werde und wirke hier teilweise zwanghaft. Alles müsse immer am gleichen Platz sein, die Mutter dürfe nur Dinge bewegen und reinigen, die Tilo selbst freigebe.
Die Mutter hätte ähnliche Tendenzen, sie seien allerdings nicht so ausgeprägt. Die Familienhilfe ergänzte jedoch, dass zu Beginn ihrer Arbeit in der Familie deutliche Zwänge bestanden hätten. Frau T. putze mindestens 2x/d die Wohnung, die Kinder müssten nach der Kita die Kleidung wechseln, alle, die von draußen reinkämen, müssten sich zunächst die Hände waschen, weil Ängste vor Keimen bestünden. Tilo sei umstellungserschwert, veränderte Abläufe könne er nicht gut tolerieren. Sozial sei er nicht Gesund werden. Gesund leben. www.asklepios.com
Asklepios Fachkliniken Brandenburg GmbH
Sitz der Gesellschaft: Brandenburg/Havel • Registergericht: HR Potsdam B 20141 P
Geschäftsführer: Volker Thesing • Daniela Wolarz • Janina Pietschmann • Sebastian Klein
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Norbert Schneider
Bankverbindung: Commerzbank AG IBAN: DE13 1808 0000 0620 0382 00 BIC: DRESDEFF180
USt.-IdNr.: DE 236 792 342 • StNr.: 003/228/49088

eingeschränkt, habe feste Freundschaften. Er sei in der Kita gut integriert, hier zeige er außer der ADHS-Symptomatik keinerlei Auffälligkeiten. Auf die Familienhelferin habe er anfänglich sehr skeptisch reagiert, als hätte er Sorge gehabt, dass sie die Familie trennen wolle. Seine Mutter begründete dies mit negativen Erfahrungen mit Betreuern aus der vorherigen I-Kita. Es wurde jedoch beschrieben, dass auch die anderen Geschwister mit Skepsis reagiert hätten.
Tilos Mutter beschrieb den in der 29. SSW geborenen Tilo als Spätentwickler, der für alles etwas mehr Leit benötige. Auch für die Trennung seiner Eltern benötige Tilo mehr Zeit zur Verarbeitung als seine Geschwistern. Die motorische Entwicklung sei aufgrund der Frühgeburtlichkeit mit Halbseitenlähmung verzögert gewesen. Verständlich gesprochen habe Tilo erst mit 3 Jahren, vorher sei es erschwert gewesen, weil er eher geplappert und gezeigt habe. Die Geschwister wären ähnlich "langsam" gewesen.
Tilos Mutter beschrieb eine
Tina Wolter archie diete en e Kritestationshwehe dig, hauenweie leute ere
er oft körperlich. Außerhalb von zuhause halte Tilo sich besser an Regeln. Die Familienhilfe beschrieb, dass Tilo bei Frust schnell ausfallend und sachaggressiv reagiere. In der Kita sei es gegenteilig, er werde dort als feinfühlig, empathisch und rücksichtsvoll beschrieben.
Die Geburt sei traumatisch gewesen, es habe geheißen "machen Sie sich keine Hoffnung". Die ersten Monate wären stark angstgeprägt gewesen. Diese Problematik sei weiterhin sehr präsent;
eine
therapeutische Aufarbeitung habe für Tilos Mutter bisher nicht stattgefunden. Insgesamt zeigte sich seine Mutter belastet durch eigene Erfahrungen aus der Vergangenheit, die nun im Rahmen einer Tagesklinik-Behandlung aufgefangen werden solle. Parallel wurden deutlich zwanghafte Verhaltensweisen : thematisiert. Sie beschrieb weiterhin anhaltende Angste, die sie manchmal daran hindern würden, Tilo etwas zuzutrauen, bzw. loszulassen. Anamnestisch werden eine PTBS und eine Depression benannt.
Beschriebene Symptome bei
Tilo im Sinne einer zwanghaften oder sozialverhaltensgestörten
Symptomatik erscheinen hier vor allem im Rahmen der Häuslichkeit aufzutreten.
Familienanamnese:
Mutter: LRS und Konzentrationsschwäche, PTBS und Depressionen, anamnestisch Hinweise für
Zwangserkrankung
Tagesklinik geplant
Herzerkrankungen bei den Großeltern ms und vs bekannt.
Soziale Anamnese:

Der Patient lebe mit seiner Mutter (*1998) und 2 weiteren Geschwistern in einer Mietwohnung und habe ein eigenes Zimmer.
Die Eltern sind getrennt seit 2023. Der Vater sei ebenfalls sorgeberechtigt und sehe Tilo an den Wochenenden. Geschwister: Djamila (*2016) und Liam (*2020)
Beruflicher Hintergrund der Eltern: Die Mutter sei arbeitssuchend, der Vater in Ausbildung zum
Pflegehelfer.
In der Freizeit besuche Tilo gern den Spielplatz und baue Lego.
Sozial sei er ausreichend gut eingebunden.
Tilo wurde in diesem Jahr eingeschult.
Körperliche Entwicklung:
Frühgeborenes nach Notkaiserschnitt in der 29. SSW mit Plazentaablösung
Halbseitenlähmung nach postpartalem Schlaganfall
OP Achillessehne, OP nach Armbruch

Nierenschaden, Fußfehlstellung (geschient)
Geburtsgewicht: 1043g; Größe: 45cm. Postpartale Adaptation geprägt von Schlaganfall beim Kind mit :
resultierender Halbseitenlähmung, Ikterus, =2-Mangel, Trinkstörung. Man habe der Mutter damals
gesagt, sie solle sich keine Hoffnung machen. Tilo sei 3 Mo gestillt worden. Er habe eine Schrumpfniere.
Insgesamt habe er als Säugling 4 Monate im Krankenhaus verbracht. Laut der Km wird. das Schlafverhalten als unauffällig und das Temperament des Kindes als "normal" beschrieben. Frühkindliche Auffälligkeiten werden verneint. Die Meilensteine der frühkindlichen Entwicklung: Freies Laufen bei Halbseitenlähmung mit 2 1/2 Jahren. Erste Wörter mit 1 1/2 Jahren, verständliche Sprache nach 3. Lj. Einmaliger Krampfanfall im 1. Lj. Die Sauberkeitserziehung sei ab dem 4. Lj. abgeschlossen gewesen; erneutes Einnässen oder Einkoten wird verneint.
Psychiatrische Anamnese:
SPZ - Befunde werden nachgereicht seit 1 1/2 Jahren FH
I-Status motorische Entwicklung
Medienkonsumanamnese:
reguliert, 30min Tablet/d
Medikamentenanamnese:
leer
Psychopathologischer Befund bei Aufnahme:
7;4jähriger Patient, äußeres Erscheinungsbild altersentsprechend, trägt Schiene am re Fuß, gepflegt.
Patient ist wach, bewusstseinsklar und zu allen Qualitäten orientiert.
Psychomotorik: unauffälliger Antrieb, zu Beginn abgewandt und zurückgenommen bis spärlich im Kontakt, kein Blickkontakt. Erst im Verlauf des Gespräches etwas aufgelockerter, nimmt dann auch von sich aus Kontakt auf, schaut in die Augen.

Denken: kein Anhalt für formale oder inhaltliche Denkstörungen, Wahn oder Phobien. Zwanghafte und oppositionell-aggressive Tendenzen in der Häuslichkeit beschrieben.
Keine Wahrnehmungs- oder Ich-Störungen.
Stimmung, Affekt: ausgeglichen, spielt, lässt sich nur schwer in den Kontakt holen. Schwingungsfähigkeit dabei erschwert überprüfbar.
Bestenfalls durchschnittliche Intelligenz.
Kein SVV. Keine Suizidalität, verbal und sachaggressive Tendenzen ausschließlich in der Häuslichkeit beschrieben. Kein Anhalt für akute Eigen- oder Fremdgefährdung.
Diagnostik
Psychologische Diagnostik:
KiTAP (Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung - Kinderversion) ohne Medikation vom 13.08.2024:
Befund:
Alertness: Dieser Test erfasst die Verarbeitungsgeschwindigkeit (T-Wert: 57; durchschnittlich) sowie die Stabilität der Arbeitsweise (T-Wert: 43; durchschnittlich).
Daueraufmerksamkeit: Bei dieser Aufgabe wird die kontinuierliche Zuwendung der Aufmerksamkeit über eine längere Zeitspanne („Konzentration") geprüft. Mit 200 Fehlern (T-Wert: < 20) wurde eine weit

Nierenschaden, Fußfehlstellung (geschient)
Geburtsgewicht: 1043g; Größe: 45cm. Postpartale Adaptation geprägt von Schlaganfall beim Kind mit :
resultierender Halbseitenlähmung, Ikterus, =2-Mangel, Trinkstörung. Man habe der Mutter damals
gesagt, sie solle sich keine Hoffnung machen. Tilo sei 3 Mo gestillt worden. Er habe eine Schrumpfniere.
Insgesamt habe er als Säugling 4 Monate im Krankenhaus verbracht. Laut der Km wird. das Schlafverhalten als unauffällig und das Temperament des Kindes als "normal" beschrieben. Frühkindliche Auffälligkeiten werden verneint. Die Meilensteine der frühkindlichen Entwicklung: Freies Laufen bei Halbseitenlähmung mit 2 1/2 Jahren. Erste Wörter mit 1 1/2 Jahren, verständliche Sprache nach 3. Lj. Einmaliger Krampfanfall im 1. Lj. Die Sauberkeitserziehung sei ab dem 4. Lj. abgeschlossen gewesen; erneutes Einnässen oder Einkoten wird verneint.
Psychiatrische Anamnese:
SPZ - Befunde werden nachgereicht seit 1 1/2 Jahren FH
I-Status motorische Entwicklung
Medienkonsumanamnese:
reguliert, 30min Tablet/d
Medikamentenanamnese:
leer
Psychopathologischer Befund bei Aufnahme:

7;4jähriger Patient, äußeres Erscheinungsbild altersentsprechend, trägt Schiene am re Fuß, gepflegt.
Patient ist wach, bewusstseinsklar und zu allen Qualitäten orientiert.
Psychomotorik: unauffälliger Antrieb, zu Beginn abgewandt und zurückgenommen bis spärlich im Kontakt, kein Blickkontakt. Erst im Verlauf des Gespräches etwas aufgelockerter, nimmt dann auch von sich aus Kontakt auf, schaut in die Augen.
Denken: kein Anhalt für formale oder inhaltliche Denkstörungen, Wahn oder Phobien. Zwanghafte und oppositionell-aggressive Tendenzen in der Häuslichkeit beschrieben.
Keine Wahrnehmungs- oder Ich-Störungen.
Stimmung, Affekt: ausgeglichen, spielt, lässt sich nur schwer in den Kontakt holen. Schwingungsfähigkeit dabei erschwert überprüfbar.
Bestenfalls durchschnittliche Intelligenz.
Kein SVV. Keine Suizidalität, verbal und sachaggressive Tendenzen ausschließlich in der Häuslichkeit beschrieben. Kein Anhalt für akute Eigen- oder Fremdgefährdung.
Diagnostik
Psychologische Diagnostik:
KiTAP (Testbatterie zur Aufmerksamkeitsprüfung - Kinderversion) ohne Medikation vom 13.08.2024:
Befund:
Alertness: Dieser Test erfasst die Verarbeitungsgeschwindigkeit (T-Wert: 57; durchschnittlich) sowie die Stabilität der Arbeitsweise (T-Wert: 43; durchschnittlich).
Daueraufmerksamkeit: Bei dieser Aufgabe wird die kontinuierliche Zuwendung der Aufmerksamkeit über eine längere Zeitspanne („Konzentration") geprüft. Mit 200 Fehlern (T-Wert: < 20) wurde eine weit

unterdurchschnittlich hohe Fehleranzahl erreicht. Mit 7 Auslassern (T-Wert: 51) lag dieser Wert im durchschnittlichen Bereich.
Geteilte Aufmerksamkeit: Die Testung der Fähigkeit zur Teilung der Aufmerksamkeit ergibt einen Gesamtwert (T-Wert: 56) im durchschnittlichen Bereich.
Go/Nogo: In diesem Test wird die Fähigkeit überprüft unter Zeitdruck eine angemessene Reaktion auszuüben und eine unangemessene zu unterdrücken. Mit 11 Fehlern wurde eine unterdurchschnittlich hohe Fehlerzahl (T-Wert: 29) bei einer überdurchschnittlichen Reaktionszeit (T-Wert: 65) erreicht.
Verhaltensbeobachtung: Tilo geht zunächst schüchtern und zurückhaltend in den Kontakt. Im weiteren Verlauf ist er zunehmend aufgeschlossen und kommentiert sein Tun während der Testung. Eine motorische Unruhe ist nicht erkennbar, es fällt Tilo jedoch schwer, seine Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten.
Beurteilung:
In dieser Testung ergaben sich deutliche Hinweise auf einen impulsiven Arbeitsstil.
WISC-V (Wechsler Intelligence Scale for children) ohne Medikation vom 10.09.2024:
Befund:

Sprachverständnis (SV): 86
Visuell-Räumliche Verarbeitung (VRV): 105
Fluides Schlussfolgern (FS): 103
Arbeitsgedächtnis (AGD): 82
Verarbeitungsgeschwindigkeit (VG): 80
Gesamt-IQ: 84, Prozentrang (PR) 14, 90% Vertrauensintervall 80 - 89 (obere Grenze unterdurchschnittlicher Intelligenzbereich)
Verhaltensbeobachtung: Tilo geht zunächst unsicher und abwehrend in den Kontakt, im weiteren Verlauf wirkt er zugewandt und schwingungsfähig. Während der Testung zeigt er ein unterschiedlich ausgeprägtes Instruktionsverständnis, gerade der Untertest Zahlen nachsprechen bereitet ihm Schwierigkeiten in der Umsetzung. Insgesamt arbeitet Tilo überwiegend motiviert und zügig, er zeigt dabei keine Anzeichen motorischer Unruhe.
Beurteilung:
Da der Gesamt-IQ-Wert auf einem heterogenen Leistungsprofil basiert, sollte er in diesem Fall nur eingeschränkt interpretiert und durch die Index-Werte und begleitende Diskrepanzanalyse ergänzt werden. Klinisch signifikante Differenzen auf Hauptskalenebene ergeben sich zwischen Sprachverständnis und Visuell-Räumliche Verarbeitung, zwischen Sprachverständnis und Fluides Schlussfolgern, zwischen Visuell-Räumliche Verarbeitung und Arbeitsgedächtnis, zwischen Visuell-Räumliche Verarbeitung und Verarbeitungsgeschwindigkeit sowie zwischen Fluides Schlussfolgern und Verarbeitungsgeschwindigkeit.
Zudem liegen die Werte Nonverbaler Index (97) und Allgemeiner Fähigkeitsindex (kristalline, fluide Intelligenz und visuelle Verarbeitung; 95) deutlich über dem Wert Kognitiver Leistungsindex (Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit; 78). Dies lässt Rückschlüsse auf eine Aufmerksamkeitsstörung zu, hier wird aufgrund der Einschränkungen im Sprachverständnis eine sprachfreie Re-Testung unter behandelter Symptomatik empfohlen.
Beurteilungsbögen DISYPS-III: SCREEN, ADHS und SSV vom 07.10.2024:

Befund:
DISYPS-III: SCREEN ausgefüllt: KM 12/23
Werte im Grenzbereich
zur
Auffälligkeit (Stanine T): Screening Entwicklungs- und Ausscheidungsstörung (ENTW-SCREEN), Screening Autismus (AUT-SCREEN)
auffälliger Bereich (Stanine 8): Screening ADHS (ADHS-SCREEN), Screening Kontaktverhalten (KON-SCREEN)
ausgeprägt auffälliger Bereich (Stanine 9): Screening SSV (SSV-SCREEN), Screening Angst (ANG-SCREEN), Screening Depression (DEP-SCREEN), Screening Zwang & Tic (ZWATIC-SCREEN), Screening Internal (INT-SCREEN), Screening External (EXT-SCREEN), Funktionsbeeinträchtigung & Leidensdruck (FL-SCREEN)

DISYPS-III: SCREEN ausgefüllt: EZ 06/24
Werte im Grenzbereich zur Auffälligkeit (OB): Screening Entwicklungs- und Ausscheidungsstörung
(ENTW-SCREEN), Screening Autismus (AUT-SCREEN)
auffälliger Bereich (OB): Screening ADHS (ADHS-SCREEN), Screening Kontaktverhalten (KON-ausgeprägt auffälliger Bereich (OB): Screening Angst (ANG-SCREEN), Screening Depression (DEP-SCREEN), Screening External (EXT-SCREEN), Screening Internal (INT-SCREEN), Screening SSV (SSV-SCREEN), Screening Zwang & Tic (ZWATIC-SCREEN), Screening Gesamtsymptomatik (GES-SCREEN),
Funktionsbeeinträchtigung & Leidensdruck (FL-SCREEN)
Norm: -- Jungen, 7 bis 10 Jahre
Skala: T
DISYPS-III: FBB-ADHS-V ausgefüllt: KM 12/23: auffälliger Bereich (OB): Funktionsbeeinträchtigung/Leidensdruck (FL-ADHS-V)
DISYPS-III: FBB-ADHS ausgefüllt: EZ 06/24: auffälliger Bereich (OB): Unaufmerksamkeit (UA)
ausgeprägte Auffälligkeit (OB): Hyperaktivität/Impulsivität HY-IM), Gesamtsymptomatik ADHS (Ges-
ADHS), Funktionsbeeinträchtigung/Leidensdruck (FL-ADHS)
Kompetenzen: Ausdauer, Aufmerksamkeit und Reflexivität (OB): gering Die beschriebenen Verhaltensprobleme bestehen seit mind. 6 Monaten.
DISYPS-III: FBB-SSV ausgefüllt: KM 12/23
Werte im Grenzbereich zur Auffälligkeit (Stanine 7): Aggressiv-dissoziales Verhalten (AG-DISS),
Begrenzte Prosoziale Emotionalität (BPE)
auffälliger Bereich (Stanine 8): Oppositionelles Verhalten (OPP), Gesamtsymtomatik SSV (GES-SSV), Disruptive Affektregulationsstörung und Reizbarkeit (DAF-R), Funktionsbeeinträchtigung/Leidensdruck
SSV (FL-SSV)
Kompetenzen: Prosoziales Verhalten (K-PSV) (Staninen 7): hoch (hier liegen Verständnisschwierigkeiten beim Ausfüllen nahe)
DISYPS-III: FBB-SSV ausgefüllt: EZ 06/24
alle Werte im unauffälligen Bereich
Kompetenzen: Prosoziales Verhalten (K-PSV) (OB): durchschnittlich

Differenzialdiagnostische Überlegungen/Schlussfolgerung:
Wir sahen einen 7-jährigen Patienten, der zunächst schüchtern und zurückhaltend in den Kontakt ging.
Im weiteren Verlauf zeigte sich Tilo zunehmend aufgeschlossen und wirkte motiviert an den Testungen mit, es fiel ihm jedoch schwer, seine Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Zusammenfassend ergab sich nach Auswertung der ausführlichen Anamnese, der Fremdbeurteilungsbögen sowie

durchgeführten psychologischen Testdiagnostik und klinischen Verhaltensbeobachtung die Diagnose einer einfachen Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung. Die Leistungsdiagnostik ergab einen Gesamt-IQ an der oberen Grenze zum unterdurchschnittlichen Intelligenzbereich, da das Ergebnis auf einem heterogenen Leistungsprofil basierte, war hier nur eine eingeschränkte Interpretation möglich. Die Werte Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit lagen im unterdurchschnittlichen Intelligenzbereich. Zudem lagen die Werte Nonverbaler Index (97) und Allgemeiner Fähigkeitsindex (kristalline, fluide Intelligenz und visuelle Verarbeitung; 95) deutlich über dem Wert Kognitiver Leistungsindex (Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit; 78). Dies ließ einen zusätzlichen Rückschluss auf : eine Aufmerksamkeitsstörung zu, aufgrund der Einschränkungen im Sprachverständnis wird eine sprachfreie Re-Testung unter behandelter Symptomatik empfohlen.
Die beschriebenen Verhaltensauffälligkeiten sahen wir im Zusammenhang mit der gestellten Diagnose
Reaktion auf die unterschiedlichen Belastungsfaktoren
(Frühgeburtlichkeit
Halbseitenlähmung, Sprachentwicklungsverzögerung, Trennung der Eltern, psychische Problematik der Mutter). Differanzialdiagnostisch ergeben sich anamnestisch zudem Hinweise auf eine Zwangsstörung bzw. auf das Vorliegen einer Autismus-Spektrum-Störung (umstellungserschwertes Verhalten), die zur Einschätzung eine genauere Beobachtung erfordern. Aufgrund der Komplexität der Symptome wird zur besseren Einordnung der Symptomatik und zur Feststellung des tatsächlichen Hilfebedarfs eine vertiefende Diagnostik im Rahmen einer tagesklinischen Behandlung bzw. eine Aufnahme durch unsere stationsäquivalente Betreuung (StäB) unter Einbeziehung des familiären Rahmens empfohlen.
Empfehlungen:
-
-
-
medikamentöse Behandlung mittels Stimulanzien
Weiterführung der Betreuung durch die Familienhilfe unterstützende Maßnahmen in der Schule in Absprache mit den Lehrerinnen, u.a.
Nachteilsausgleich, Anpassung der Lernbedingungen ggf. Ergotherapie zur Unterstützung im Umgang mit der Aufmerksamkeitsproblematik bei Bedarf ergänzende Aufnahme einer ambulanten Psychotherapie
- ggf. tagesklinische Aufnahme zur weiterführenden Diagnostik bzw. Weiterbehandlung durch das Team hiesiger stationsäquivalenten Betreuung (StäB)
- sprachfreie Re-Testung (Leistungsdiagnostik) unter behandelter Symptomatik empfohlen

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
M. Schmid
Oberärztin
S. Windheim
Therapeut/-in
Vivantes
Vivantes - Postfach 26 01 27 - 13411 Berlin
Familie T.
Dorfstr. 25a

15738 Zeuthen
Vivantes
Klinikum Neukölln
Rudower Straße 48
12351 Berlin
Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité- Universitätsmedizin Berlin
Klinik für Kinder- u.
Neugeborenenchirurgie und Kinderurologie
Tel +49 (0)30 130 148284
Fax +49 (0)30 130 148495
Prof. Dr. med. B. Tillig
Chefarzt
bernd.tillig@vivantes.de
KNK - Station 61
BRIKISH
BRIKISH
11.10.2022
Zur Vorlage beim weiterbehandelnden Arzt
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege, wir berichten über den Jungen
Tilo T., geb. am 31.12.2016, wohnhaft: Dorfstr. 25a, 15738 Zeuthen,
der sich vom 09. bis zum 11.10.2022 in unserer stationären Behandlung befand.
Diagnose/n:
Suprakondyläre Humerusfraktur, links mit Weichteilschaden
S42.41
1. Grades
Therapie:
Geschlossene Reposition und Kirschnerdraht-Osteosynthese 5-790.13
(3 x 1,6 mm), linker Humerus distal am 09.10.2022
Tilo habe am Nachmittag des 09.10.2022 aus seinem Kinderbett heraus etwas greifen wollen, habe das Gleichgewicht verloren und sei unbeobachtet auf den Boden gestürzt und auf den linken Arm gefallen. Es erfolgte der Transport in unsere Klinik mit dem Notarzt. Dieser hatte Ketanest/Dormicum nasal verabreicht und den linken Arm geschient.
VE: Ehem. FG der 29 SSW, habe eine rechtsseitige Halbseitenspastik aufgrund eines Hirninfarktes in der Neonatalperiode. Außerdem berichtete die Mutter über eine zu kleine Niere rechts, bei stets guten Nierenwerten. Er sei im Wedding im SPZ angebunden, mit 6 monatiger Sonokontrolle.
Keine Allergien bekannt, keine regelmäßige Medikamenteneinnahme.
Aufnahmestatus:
AZ reduziert, Kind schmerzgeplagt, Arm links gerade geschient, Durchblutung und Motorik Finger links intakt. Gibt Kribbeln auf Nachfrage an den Fingern an, aber dies ist schlecht eruierbar. Eindeutio-Fehlstellung und Schwellung am distalen Oberarm links.

212
30016544

Pat.: Tilo T., geb. 31.12.2016, Brief vom 11.10.2022
Befunde:
Röntgen Oberarm, a.p., links, v. 09.10.2022:
Um Schaftbreite nach dorsal dislozierte suprakondyläre Humerusfraktur links. Vivantes
Röntgen Ellenbogengelenk, 2 Ebenen, links, v. 10.10.2022:
Zwischenzeitlich Reposition der vormals massiv dislozierten suprakondylären Humerusfraktur links und Fixation mittels drei Kirschnerdrähten. Das Fremdmaterial ist intakt und projiziert sich Verbesserte Stellung der Fraktur, aufgrund der Überlagerung durch Gips insbesondere erschwerte
Beurteilbarkeit der a.p. Ebene. Keine höhergradige Rotationsfehlstellung. Keine Luxation.
Verlauf:
diagnostizierter suprakondylärer Humerusfraktur links erfolgte noch am Aufnahmetag die
geschlossene Reposition und Osteosynthese der Fraktur sowie die Anlage einer Oberarmgipsschiene. Der Eingriff konnte in gut vertragener Allgemeinnarkose durchgeführt werden.
Die postoperative Röntgenkontrolle zeigte eine achsengerechte Stellung der Fraktur, so dass wir Tilo am 11.10.2022 aus der stationären Behandlung entlassen konnten.
Empfehlung:
- Körperliche Schonung noch für einige Tage
- Klinische Gipskontrolle in unserer kinderchirurgischen Sprechstunde + Kinderspezialambulanz am Freitag, den 14.10.2022, um 11:30 Uhr.
- Gesamtruhigstellungszeit beträgt 4 Wochen. Die Drahtentfernung kann im Anschluss daran erfolgen.

Wir bitten hierfür um die Vereinbarung eines Termins mit unserer Ambulanz (Tel.: 030/ 130 14 3551).
Zur Voruntersuchung bitte Röntgenkontrollbilder mitbringen.
Wir danken für die ambulante Weiterbehandlung und verbleiben mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. med. B. Tillig
Chefarzt
Dr. med. C. Nagel
Oberärztin
H. K. J. Brikis
Assistenzärztin
212
16544

Pflegegutachten für T., Tilo, geb. 31.12.2016 vom 27.01.2021
MDK
MEDIZINISCHER DIENST DER KRANKENVERSICHERUNG
BERLIN-BRANDENBURG
MDK Berlin-Brandenburg - Martin-Luther-Str. 3-7 - 10777 Berlin
BARMER

(Pflegekasse)
Kirchhofstr. 3-7
14776 Brandenburg
Geschäftsbereich Pflege
Region P-6
Martin-Luther-Str. 3-7
10777 Berlin
Telefon 030 202023-4000
Telefax 030 21017 - 4650
Gutachten zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit gemäß SGB XI
Versicherter:
Geburtsdatum:
Versichertennummer:
Auftragsnummer MDK:
T., Tilo
Torgauer Str. 47
12627 Berlin
31.12.2016
F076078046
000707-1125019
Zusammenfassung wesentlicher Inhalte des Gutachtens:

Anlass des Antrags/Auftrags:	Ambulante Leistungen - Geldleistung nach § 37 SGB XI
Art des Antrags/Gutachtenart:	Erstbegutachtung
Ergebnis:	Pflegegrad 2, seit 01.08.2020
Termin Wiederholungsbegutachtung:	01.2023
Mit freundlichen Grüßen Ihr MDK	

44011
V04

m
44011
Pflegegutachten für T., Tilo, geb. 31.12.2016 vom 27.01.2021
Anlass des Antrags/Auftrags:
Art des Antrags/Gutachtenart:
Antragsdatum:
Eingang des Auftrags beim MDK:
Ambulante Leistungen - Geldleistung nach § 37 SGB XI
Erstbegutachtung
19.08.2020
28.08.2020
Bisheriger Pflegegrad:
kein Pflegegrad
Verzögerungen im Verfahren beim angekündigten Hausbesuch nicht angetroffen

Angekündigter Termin von Antragsteller abgesagt (sonstige Gründe)
Erledigungsort:
MDK

Begutachtung am:	27.01.2021, 14:00 Uhr
Durch Gutachter(in):	Biedenweg, Änne (Pflegefachkraft)
Erledigungsart:	Nach Aktenlage
Gründe für Begutachtung nach	Aktenlage aus sonstigen Gründen Begründung
Aktenlage:	Um für die besonders gefährdete Personengruppe der pflegebedürftigen Menschen das Infektionsrisiko mit der neuartigen Erkrankung SARSCoV-2 zu reduzieren, wurde dieses Gutachten gemäß § 147 SGB XI anhand vorliegender Unterlagen sowie nach telefonischen Angaben des/der Versicherten, der Angehörigen, des Pflegepersonals und/oder der Betreuerin/des Betreuers/der Bevollmächtigten/des Bevollmächtigten erstellt.

Entsprechend der Begutachtungsrichtlinie wurde dieses Gutachten mit dem Formulargutachten der Pflegebegutachtung erstellt. Einige Punkte sind in dieser Erledigungsart nicht relevant. Die Nummerierung ist deshalb nicht fortlaufend.
1 Pflegerelevante Vorgeschichte und derzeitige Versorgungssituation
Nach Angaben: Eltern und im Beisein des Kindes
Das Einverständnis zur Befragung der Anwesenden wurde gegeben.
Mit dem Verfahren der telefonischen Befragung erklärten sich die Beteiligten einverstanden.
1.1 Pflegerelevante Fremdbefunde
Leistungsauszüge der Pflegekasse vom 28.08.2020
gelbes Untersuchungsheft
Krankenhausbericht von der Charité Berlin vom 05.02.2017
SPZ- Bericht vom 22.08.2018
Schwerbehindertenausweis: GdB: 70; Merkzeichen: G, H (seit 15.01.2020)
Aus technischen Gründen wurde die Wohnsituation unter Punkt 1.1 Fremdbefunde eingefügt.

und Konzentrationsfähigkeit, sowie die Auffassungsgabe seien unauffällig und altersentsprechend, Spielverhalten unauffällig, Regelverständnis für einfache Kinderspiele, wie Spielen mit Lego oder Autos, sowie Türme bauen sind möglich. In der Selbstbeschäftigung noch sprunghaft und vereinzelt abgelenkt.
Verhaltensauffälligkeiten nach Angaben der Mutter:

Es werden Verhaltensauffälligkeiten mit fremd- und sachaggressivem Tendenzen bei Wunschversagen und Missverstanden werdens beschrieben; der Junge trete, beiße und schreie (täglich); eine kinderpsychiatrische Vorstellung sei bisher nicht erfolgt; jedoch zeitnah angedacht, keine weiteren Therapien eingeleitet.
-> Um diese Punkte aus gutachterlicher Sicht im Gutachten werten zu können wird eine ärztliche Abklärung empfohlen um ggf. eine medikamentöse oder psychotherapeutische Behandlung einzuleiten. Zum jetzigen Zeitpunkt kann keine Dauerhaftigkeit (nach Richtlinie SGB XI) eines personellen Interventionsbedarf nachvollzogen werden. Daher keine Wertung.
Atmungsorgane; Herz- Kreislauf-System
Herz/ Kreislauf: keine sichtbaren kardiopulmonalen Dekompensationszeichen, keine sichtbaren Ödeme, Atmung unauffällig
- einmaliger Krampfanfall mit 2 Jahren (Notfallmedikament ist vorhanden).
Ausscheidung:
Sauberkeitserziehung ist noch nicht vollständig abgeschlossen, der Junge geht eigenständig zur Miktion zur Toilette, Stuhlgang noch Windel erforderlich. Er benötigt altersentsprechende Hilfe beim Nachreinigen nach
Stuhlgang.
Ernährung:
Das Kind erhält Normalkost. Die Mahlzeiten werden am Tisch im Familienverbund eingenommen. Die Nahrungsaufnahme erfolgt selbstständig mit Besteck; nach einiger Zeit gehäuftes Essen mit den Händen oder punktuelle Teilhilfen durch die Eltern. Er trinkt selbstständig aus einem Becher/ Glas/ Trinkflasche. Mundgerechte Zubereitung erforderlich, beinhaltet das Zerkleinern fester Speisen (Fleisch/ Obst) sowie das Einschenken von Getränken. Hunger- und Durstempfinden vorhanden und kann benannt werden.
Haut:
trockene Haut wird beschrieben; handelsübliche Pflegelotionen werden verwendet.
Augen:
keine Einschränkungen der Sehfähigkeit.
Ohren:
keine Einschränkung der Hörfähigkeit.
Sprache:
Der Junge spreche einfache Mehrwortsätze; die Aussprache wird als vereinzelt undeutlich beschrieben; das Sprachverständnis sei vorhanden; der Junge verstehe Aufforderungen und könne diese umsetzen; er versuche sich entsprechend seiner sprachlichen Ressourcen mitzuteilen; Bedürfnisse und Wünsche können benannt und/oder angezeigt werden; Zustimmung und Ablehnung kann ausreichend signalisiert werden.
Leistungen der medizinischen Rehabilitation
- keine
- im letzten Jahr vor der Begutachtungmehr als ein Jahr aber weniger als vier Jahre vor der Begutachtung

Ist aktuell ein Rehabilitationsantrag gestellt?

• nein
• ja, aber noch nicht genehmigt • ja, Genehmigung liegt vor
1.3 Vorhandene Hilfsmittel, Pflegehilfsmittel, Nutzung
Genutzt: Inkontinenzprodukte (Windeln, Eigenleistung), Orthesen, Nachtlagerungsschiene rechte Hand
1.4 Pflegerelevante Aspekte der Versorgungs- und Wohnsituation
Die antragstellende Person wohnt in einer ambulanten Wohnsituation mit: Mutter, Schwester, Bruder.
Pflege durch Pflegeeinrichtung(en) nach SGB XI
Die antragstellende Person besucht tagsüber den Kindergarten, die Schule, die Werkstatt für behinderte Menschen
Das Kind geht wochentags in eine Integrationskita mit I- Status in der Zeit von 09:00-15:00 Uhr. Der Transport dorthin und wieder nach Hause erfolgt durch die Pflegepersonen.
Beschreibung der aktuellen Versorgungssituation
Das Kind wird in der Häuslichkeit (außerhalb der Kitazeiten) durch die Mutter betreut und versorgt. Begleitur außer Haus, zu Arztbesuchen und Therapiebesuchen erfolgen durch die Pflegeperson.
Nachtruhe von 18/19:00- 07:00:
- ritualisiertes Zubettbringen erforderlich
- Einschlafphase bis zu 10 Minuten
- altersentsprechende Wachphasen
- der Junge schläft in seinem Bett und in der Regel durch

Die Verrichtungen der täglichen Grundpflege, beinhaltet die Körperpflege, sowie das An- und Auskleiden werden überwiegend durch die Pflegeperson übernommen, der Junge versucht sich nach eigenen motorischen Ressourcen an den Aktivitäten zubeteiligen.
Präsenz der Pflegeperson(en) in Rufnähe am Tage
- Nein
- mehrmals täglich
- überwiegend
- durchgehend

Nächtliche Unterstützung
- nie oder max. einmal wöchentlich
- mehrmals wöchentlicheinmal pro Nacht mehrmals nachts

Angaben zum Pflegeaufwand durch antragstellende Person oder Pflegepersonen
Pflege durch
A Frau T., Jenny
Angegebene Anzahl
Angegebene Angegebene
weiterer durch die
Pflegetage
Pflegestunden Pflegeperson gepflegten
pro Woche pro Woche
Pflegebedürftige
7
70
0

44011 V04
Pflegegutachten für T., Tilo, geb. 31.12.2016 vom 27.01.2021
Der Junge lebt in Gemeinschaft mit der Mutter und den Geschwistern (Bruder und Schwester), er wohnt in einem Mehrfamilienhaus in einer 3- zimmer- Wohnung im 5. Obergeschoss ohne Fahrstuhl. Vor der Haustür sind sechs Stufen zu überwinden. Vor der Wohnungstür sind Stufen zu überwinden. Die Wohnung wird mit einer Zentralheizung beheizt. Die Mobilität innerhalb der Wohnung ist eingeschränkt durch flache Türschwellen. Die Wohnung ist ausgestattet mit einem Bad mit WC, Waschbecken und Badewanne. Der Junge teilt sich das Zimmer mit seinen Geschwistern.
1.2 Pflegerelevante Vorgeschichte (Anamnese), medizinische und pflegerische Angaben unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Selbstständigkeit oder die Fähigkeiten Die heutige Begutachtung erfolgt im Rahmen eines Erstantrages, durch Empfehlung des Sozialdienst der Charité.
Die Schwangerschaft war auffällig bei vorzeitige Wehen, der Junge kam per Notsectio bei vorzeitiger Plazentalösung in der 30+ 6. SSW mit einem Geburtsgewicht von 1470 g und einer Körperlänge von 45 cm zur Welt; APGAR: 7/7/7; Nabel- pH: 6,9. Die postnatale Adaption war bei Frühgeburt und leichter respiratorischer Anpassungsstörung auffällig; Erstversorgung im Kreissaal bei deprimierten Kind, rasche Stabilisierung unter CPAP und Volumengabe, Verlegung auf die neonatologische Intensivstation; am 15. Lebenstag Verlegung in die Charité bei fortschreitender AZ -Verschlechterung nach stattgehabter Nierenvenenthrombose links.
-> Sonografisch bestätigte sich die Nierenvenenthrombose links, aufgrund des Verdachts auf einer parenchymatösen Blutung in der Schädelsonografie Umstellung auf Low-dose-Heparinisierung für 36 Stunden.
Im cMRT dann Nachweis eines abgelaufenen Mediainfarktes links (ohne vollständige Thrombosierung), daher erneute therapeutische Heparinisierung. Entlassung am 05.02.2017 im guten Allgemein- und Ernährungszustand mit einem Gewicht von 2550 g und einer Körperlänge von 48 cm und zusätzlich medizinischer Nachsorge in die Häuslichkeit; anfänglich noch s.c. Injektionen (Clexane) verabreicht durch die Eltern. SPZ- Anbindung seit Geburt.
Erste Auffälligkeiten zeigten sich sehr früh im Säuglingsalter bei Einschränkungen im Bereich der Greif- und Haltefunktion der rechten Hand mit überwiegender Faustung und bevorzugter Aktivität der linke Seite, sowie Bewegungseinschränkungen der rechten unteren Extremität bei defizitären Strampeln. Laut Angaben der Eltern erste dokumentierte motorische Entwicklungsstörung ab dem Alter von 1,5 Jahren mit Beginn einer Physiotherapie.
Meilensteine der Entwicklung:
Robben mit ungefähr 2 Jahren; Laufen mit ungefähr 2,5 Jahren, sicheres Laufen mit Orthesen ab 2019 (im Alter von 3 Jahren); erste Worte wurden mit ungefähr 3 Jahren gesprochen; erste Sätze mit 4 Jahren;
Sauberkeitserziehung noch nicht vollständig abgeschlossen, Urinausscheidung seit 2 Monaten ohne Windel, Stuhlgang wird derzeit noch in die Windel abgesetzt.
Kitabesuch ab 11/2018 in eine Integrationskita mit I-
Status "A".

gemäß SPZ- Bericht Charité vom 22.08.2018 wurden folgende Diagnosen vorgelesen:

- Eutrophes Frühgeborenes (GG 1470 g, 30+6 SSW)
- Nierenvenenthrombose links, V.a. renalen Hypertonus
- Infarkt A. cerebri media links mit rechtsseitiger Hemiparese
- Knick- Senk- Fuß Reiz mit versteckten Spitzfuß
- Mikrozephalie
- motorische Entwicklungsstörung

keine Auffälligkeiten im Bereich der Achse 3/4
Der Junge erhält 1x wöchentlich eine Physiotherapie und seit 02/2020 eine Ergotherapie.
zum Antrag/ Unterstützungsbedarf:
Es wird durch die Mutter ein erhöhter Mehraufwand im Bereich der Mobilität, der Selbstversorgung und der Behandlungspflege bei motorischer Entwicklungsverzögerung aufgrund einer Hemiparese rechts beschrieben.

Es wird noch ein unsicheres breitbasiges Gangbild unter Orthesenversorgung beschrieben, es komme zu gehäuften Stolperstürzen bei unzureichender Fußhebung und muskulärer Schwäche der unteren Extremitäten; das Sitzen sei frei möglich, das Aufstehen vom Boden mit Hochziehen und Abstützen an Gegenständen sei möglich; das Setzen auf einen Stuhl und/ oder Sessel/Couch sei selbstständig möglich. Das Treppensteigen wird derzeit im Nachstellschritt mit Absicherung an den Pflegepersonen durchgeführt. Die Feinmotorik rechts sei mit deutlichem Übungsbedarf in den Verschlüssen und der mundgerechten Zubereitung, sowie dem Besteckumgang auffällig vorhanden. Der Junge spreche einfache Mehrwortsätze; die Aussprache wird als vereinzelt undeutlich beschrieben; das Sprachverständnis sei vorhanden; der Junge verstehe Aufforderungen und könne diese umsetzen; er versuche sich entsprechend seiner sprachlichen Ressourcen mitzuteilen; Bedürfnisse und Wünsche können benannt und/oder angezeigt werden; Zustimmung und Ablehnung kann ausreichend signalisiert werden. Die kognitiven Fähigkeiten seien altersentsprechend vorhanden; eine geistige Behinderung liege nach Angaben der Mutter nicht vor. Es werden Verhaltensauffälligkeiten mit fremd- und sachaggressivem Tendenzen bei Wunschversagen und Missverstanden werdens beschrieben; der Junge trete, beiße und schreie (täglich); eine kinderpsychiatrische Vorstellung sei bisher nicht erfolgt; jedoch zeitnah angedacht, keine weiteren Therapien eingeleitet.
•Eine Befunderhebung mit Inaugenscheinnahme und Untersuchung war nicht möglich. Es erfolgte eine telefonische Befragung der Beteiligten, die folgendes Bild der Ressourcen und pflegerelevanten Schädigungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit und Fähigkeiten ergab:
Allgemeinbefund:
Der Junge 4 Jahre alt.
Größe: 104 cm (44.Perzentile), Gewicht: 12,6 kg (1.Perzentile), Stand 27.01.2020.
"Letzte U- Untersuchung am 17.12.2020 (U8); Gewicht: 12 kg, Größe: 104cm.
Auffälligkeiten zur Beobachtung:
Spitzfußstellung, Ergotherapie, SPZ- Verordnung alle 3 Monate bei Orthesen."
obere Extremitäten:

Hemiparese rechtsseitig, versucht vereinzelt die rechte Hand aktiv zu nutzen, überwiegende Faustung der Hand wird benannt; kein Pinzettengriff möglich. Linksseitig unauffällige Beweglichkeit beschrieben, der Junge könne mit der linken Hand sicher nach Gegenständen greifen und diese festhalten; freie Beweglichkeit der Gelenke vorhanden, Pinzettengriff wird angewandt; das Halten eines Stifts und/ oder Besteck erfolgt im überwiegenden Faustgriff, das Essen erfolgt mit der linken Hand, das Aufpieksen auf die Gabel wird unterstützt; das Trinken erfolgt aus einem Becher/Glas selbstständig nach Bereitstellung. Unterstützungsbedarf bestehe bei den Verschlüssen und dem Kleidungswechsel, sowie der mundgerechten Zubereitung.
Mobilität:
Hemiparese rechtsseitig mit Orthesenversorgung und beginnendem Spitzfuß.
Es wird noch ein unsicheres breitbasiges Gangbild unter Orthesenversorgung beschrieben, es komme zu gehäuften Stolperstürzen bei unzureichender Fußhebung und muskulärer Schwäche der unteren Extremitäten; das Sitzen sei frei möglich, das Aufstehen vom Boden mit Hochziehen und Abstützen an Gegenständen sei möglich; das Setzen auf einen Stuhl und/ oder Sessel/Couch sei selbstständig möglich. Das Stehen sei mit zweihändigem Festhalten möglich. Das Treppensteigen wird derzeit im Nachstellschritt mit Absicherung an den Pflegepersonen durchgeführt.
WIRBELSÄULE: Rumpfstabilität ist vorhanden, keine Einschränkungen benannt.
Geistiger Zustand:
Es besteht keine geistige Entwicklungsstörung, der Junge ist nach Angaben altersentsprechend mental/kognitiv entwickelt. Freundliches und kontaktfreudiges Kind. Er reagiert auf den Namen, soziales Lächeln vorhanden. Bezugspersonen werden von Fremden Personen und untereinander unterschieden. Merk-

hl
e
gte
OBERLIN KLINIK
Oberlinklinik gGmbH • Rudolf-Breitscheid-Straße 24 • 14482 Potsdam
Frau
Nora Koch
Teterower Ring 48
12619 Berlin
Abteilung:
Kinder- und Neuroorthopädie
Chefarzt Dr. med. Stefan Blume
Kinderorthopädie:
Telefon: 0331 763-5742
Fax: 0331 763-5740
kinderorthopaedie@oberlinhaus.de
Datum: 08.11.2022
Station A.
endgültiger Entlassbrief
T., Tilo (M) - geb. am 31.12.2016, wohnhaft: Dorfstr. 25a in 15738 Zeuthen
Sehr geehrte Frau Kollegin,
Wir berichten über o. g. Patient, der sich vom 07.11.2022 - 08.11.2022 in unserer stationären Behandlung befand.

Diagnosen:
Hypertrophie des Peritendineums bei subcutanem Fadengranulom nach Achillessehnenverlängerung in Wundmitte rechts bei Spitzfuß 09/2021
Nebendiagnose(n):
ICP nach FG 30. SSW
Arteria-Media-Infarkt links spastische Hemiparese rechts
Schrumpfniere rechts nach Nierenvenenthrombose
Frgl. AT3-Mangel
dystone-teilkontrakte Arm- und Handgebrauchsstörung rechts
Gangstörung
Innentorsion rechte Hüfte hochkontrakter Spitz-Supinationsfuß rechts Arm- und Beinlängendifferenz
Therapie:
Resektion des Granuloms und partielle Resektion des hypertrophen Peritendineums mit Naht des Peritendineums und primärem Wundverschluss (intracutan resorbierbar)
Datum
07.11.2022
Oberlinklinik gGmbH | Orthopädische Fachklinik | Rudolf-Breitscheid-Str. 24 | 14482 Potsdam
Tel.: 0331 763-4312 | Fax: 0331 763-4322 | info@oberlin-klinik.de | www.oberlin-klinik.de
Gesellschafter: Verein Oberlinhaus | Geschäftsführung: Thomas Neubauer, Dr. med. Hansjörg Lohbrunner
Gerichtsstand: Amtsgericht Potsdam | HRB 20086 P | USt-IdNr.: DE 252 092 291
Bankverbindung: Evangelische Bank eG | IBAN: DE76 5206 0410 0008 0250 96 | BIC: GENODEF1EK1
Mitglied im Diakonischen Werk Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e. V.
Ein Unternehmen im OBERLINHAUS
15€
OBERLINHAUS
Im Verbund der Diakonie
Christliche Kliniken
Potsdam

Verbindlichen Dank für die Einweisung Ihres Patienten. Für Rückfragen stehen Ihnen die Ärzte der Station A und ein Ansprechpartner zum Entlassmanagement unter Tel. 0331-7635721/23 zur Verfügung.
Mit freundlichen und kollegialen Grüßen
Oberlinklinik gGmbH
Dr. med. Stefan Blume
Chefarzt
Kinder- und Neuroorthopädie
Dr. med. Christian Kentner
Assistenzarzt

Kinder- und Neuroorthopädie

00718
Landesamt für Gesundheit und Soziales
Versorgungsamt
Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin Postfach 310929, 10639 Berlin
(Postanschrift)
Berlin
LAGeSo
Frau
Jenny T.
Torgauer Str. 47
12627 Berlin
Geschäftszeichen (bitte immer angeben)
D09 3949352
Dienstgebäude:
Sächsische Str. 28, 10707 Berlin
Bürgertelefon: 115
Telefax: (030) 9028 5079
E-Mailadresse:
LAGeSo-Sachgebiet9@lageso.berlin.de
(nicht für Dokumente mit elektronischer Signatur)
Datum:
24.01.2020
für: Tilo T., geb.: 31.12.2016
Torgauer Str. 47
12627 Berlin
Feststellungsantrag nach dem Schwerbehindertenrecht
Sehr geehrter Herr T.,
Ihr Antrag auf Feststellung nach § 152 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) ist am 15.01.2020 eingegangen und wird unter dem oben genannten Geschäftszeichen bearbeitet.
Bitte geben Sie bei allen Schreiben und Rückfragen dieses Geschäftszeichen an.
Weitere Informationen zum Verfahren entnehmen Sie bitte dem beigefügten Merkblatt.
Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer ist für Sie im Internet abrufbar unter_
http://www.berlin.de/lageso/behinderung/schwerbehinderung-versorgungsamt/antragstellung/#
bearbeitungszeit. Diese Angaben werden monatlich aktualisiert.
Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag
Ehrich
Dieses Schreiben ist maschinell erstellt und deshalb auch ohne Unterschrift gültig.
Verkehrsverbindungen:
U3 Fehrbelliner Platz
U7 Fehrbelliner Platz Fahrstuhl vorhanden
Bus 101, 104, 115
Haltestelle
Fehrbelliner Platz

Öffnungszeiten des KundenCenters Montag, Dienstag
09.00 - 15.00 Uhr
Mittwoch
geschlossen
Donnerstag
09.00 - 18.00 Uhr
Freitag
09.00 - 13.00 Uhr
Internetadresse: http://www.lageso.berlin.de
Sprechzeiten Bürgertelefon 115
Montag - Freitag 7.00 - 18.00 Uhr

00718
Landesamt für Gesundheit und Soziales
Versorgungsamt
Informationsblatt zum Antragseingang Feststellung der Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch
Das Versorgungsamt Berlin stellt die Schwerbehinderteneigenschaft auf Antrag fest. Es erteilt einen Feststellungsbescheid, in dem die einzelnen Funktionsbeeinträchtigungen, der Grad der Behinderung (GdB) und die zutreffende Merkzeichen (siehe Rückseite) enthalten sind.
Dauer des Feststellungsverfahrens
Nach Eingang Ihres vollständigen Antrages fordert das Versorgungsamt medizinische Unterlagen bei den von Ihnen angegebenen Ärzten und Institutionen an. Die Dauer des Feststellungsverfahren hängt wesentlich davon ab, wie schnell diese auf die Anfrage des Versorgungsamtes reagieren.
Erst wenn die vom Versorgungsamt angeforderten Unterlagen (vom behandelnden Arzt, Krankenhaus, Kurklinik, Pflegekasse und anderen) vorliegen, wird die versorgungsmedizinische Bewertung vorgenommen. Es ist üblich, dass Sie auf Ihren Antrag vom Versorgungsamt einen Bescheid erhalten, ohne im Verfahren untersucht worden zu sein. Nur wenn die vorhandenen ärztlichen Unterlagen für eine Bewertung nicht ausreichen, kann eine persönliche Untersuchung veranlasst werden.
Besondere Einzelfälle
Vorrangig bearbeitet werden:
- Anträge von berufstätigen Personen, die noch keine Feststellung nach dem Schwerbehindertenrecht haben oder Berufstätige, bei denen bisher ein GdB von unter 50 festgestellt wurde;
- Anträge von Personen mit besonders schwerwiegenden Erkrankungen (Karzinome, Aidserkrankung, ALS/ Amyotrophische Lateralsklerose).
Informationen zum Antragsverfahren
Informationen zum Antragsverfahren und zum Bearbeitungsstand Ihres Antrages erhalten Sie im KundenCenter des Versorgungsamtes in der Sächsischen Straße 28, 10707 Berlin.
Öffnungszeiten: Montag und Dienstag von 9.00 - 15.00 Uhr
Donnerstag von 9.00 bis 18.00 Uhr und Freitag von 9.00 bis 13.00 Uhr
Für Ihre telefonische Nachfrage gibt es das Bürgertelefon 115 mit den Sprechzeiten Montag bis Freitag 7.00 bis 18.00 Uhr. Nutzen Sie bitte auch die Randzeiten. Das Versorgungsamt ist bestrebt möglichst schnell über ihren Antrag zu entscheiden. Bitte haben Sie deshalb Verständnis, dass Ihre Anfragen über eine telefonische

Hotline beantwortet werden, damit die Sachbearbeiter/innen möglichst unterbrechungsfrei arbeiten können.
Seite 3
[192]
766
T., Tilo, 31.12.2016, GZ: 3949352

Dauerzustand
Eine akute Erkrankung muss nicht zwingend zu einer Behinderung (dauerhaften Funktionseinschränkung) führen. In vielen Fällen kann daher frühestens sechs Monate nach Eintritt der Erkrankung für die dann noch vorhandenen Funktionsbeeinträchtigungen ein GdB festgestellt werden.
Heilungsbewährung
Die „Heilungsbewährung" ist eine gesetzlich vorgeschriebenen Zeit des Abwartens (2-5 Jahre) bei Gesundheitsstörungen mit eventuellen Rückfällen. Während dieser Zeit wird der GdB höher bewertet, als er sich aus der vorliegenden Erkrankung tatsächlich ergibt. Ist die Zeit der „Heilungsbewährung" abgelaufen, wird der aktuelle Gesundheitszustand vom Versorgungsamt überprüft und neu bewertet.
Schwerbehinderte Menschen
Schwerbehinderte Menschen im Sinne des Sozialgesetzbuches (SGB IX) sind Personen, bei denen ein Grad der Behinderung (GdB) von mindestens 50 festgestellt ist, und die sich rechtmäßig in Deutschland aufhalten.
Der GdB wird nach Zehnergraden von 20 bis 100 abgestuft festgestellt und bezeichnet das Ausmaß von Funktionsbeeinträchtigungen auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Diese Funktionsbeeinträchtigungen können Störungen der körperlichen Funktion, der geistigen Fähigkeit oder der seelischen Gesundheit sein. Sie müssen länger als sechs Monate anhalten. Dabei spielt es keine Rolle, ob die gesundheitliche Einschränkung angeboren, Folge eines Unfalls oder einer Krankheit ist.
Keine Berücksichtigung finden jedoch alterstypische Beeinträchtigungen.
Ausweis
Beträgt der festgestellte GdB wenigstens 50, wird vom Versorgungsamt ein Schwerbehindertenausweis ausgestellt. Seine Gültigkeit beginnt im Regelfall mit dem Antragseingangsdatum beim Versorgungsamt. Der Ausweis dient als Nachweis für die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung (GdB) sowie die Merkzeichen und für die Inanspruchnahme von Rechten und Leistungen (Nachteilsausgleiche).
Für die Ausweisausstellung wird ein Lichtbild benötigt.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass postalisch eingereichte Lichtbilder für die Ausweisausstellung nach dem Einscannen vernichtet werden. Die gespeicherten Lichtbilder werden nach 4 Wochen gelöscht. Die datenrechtlichen Bestimmungen werden beachtet.
Seite 4
T., Tilo, 31.12.2016, GZ: 3949352

Vorstellung am 29.01.2021 - Seite 4 von 5
T., Tilo * 31.12.2016
Grundsätzlich kann man die Handfunktion durch Behandlung mit Botulinum-Toxin in die Langfingerbeuger und die Handgelenksbeuger verbessern.

Im Augenblick möchte ich ihn damit aber noch nicht belasten.
Rechte Hüfte zeigt eine etwas erhöhte Innenrotation, ist sonst aber unauffällig und stabil.
Im Augenblick noch keine Röntgendiagnostik.
Hauptproblem für die Statomotorik ist der rechte Fuß.
Hier besteht eine fortgeschrittene und hochgradig kontrakte Spitzfußstellung, die er aktiv nicht mehr Absenken kann und die auch passiv nicht mehr ausreichend zu korrigieren ist.
Diesen Spitzfuß sollte man zeitnah operieren, um seine ansonsten sehr schöne motorische Entwicklung nicht unnötig durch die Fußfehlstellung zu bremsen.
Konservativ wäre sonst nur noch eine spezielle Schuhzurichtung mit Spitzfußausgleich möglich, was aber vom Gewicht her schwer und auch in der alltäglichen Anwendung sicherlich nur eingeschränkt möglich sein wird.
Spitzfuß-Korrektur durch sagittale Achillessehnen-Verlängerung: evtl. Kapsulotomie im oberen
Sprunggelenk.
Eine zusätzliche Verlängerung des Tibialis posterior wird wahrscheinlich nicht erforderlich sein (intraoperativ zu prüfen: ggf. Einkerbung?).
Für den Eingriff fünf Tage stationärer Aufenthalt, ein Elternteil sollte mitaufgenommen werden.
Vier Wochen Unterschenkelgips, der nicht belastet werden darf (also Rollstuhlzeit, unsererseits kann er aber seine Kita aufsuchen).
Nach der vierten Woche nochmal stationäre Aufnahme: Ausgipsen, Anpassen einer Unterschenkel-Nachtlagerungsschiene und einer Unterschenkel-Orthese.
Diese Orthese muss er noch für acht weitere Wochen zum Schutz der operierten Achillessehne tragen.
Die Nacht-Lagerungsschiene wird er über viele Jahre, vermutlich bis zum Wachstumsende tragen müssen, um einem Spitzfuß-Rezidiv vorzubeugen.
Nach Korrektur des Spitzfußes wird er dann auch einen Beinlängenausgleich rechts tragen müssen.
Es ist davon auszugehen, dass die Beinlängendifferenz mit weiterem Wachstum zunehmen wird.
Evti. später Wachstumsbremsung auf der linken Seite durch Verklammerung dortiger Wachstumsfugen (derzeit noch kein Thema).
Die Eltern werden sich unseren Operationsvorschlag überlegen.
Bei OP-Wunsch in unserer Klinik bitte Kontaktaufnahme über Email kinderorthopaedie@oberlinhaus.de.
Falls gewünscht, kann dann auch im Rahmen der OP-Narkose bereits die Behandlung mit Botulinum-Toxin am rechten Unterarm durchgeführt werden.
Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass er dann wieder regelmäßig Ergotherapie bekommt und die Handgelenks-Funktionsorthese zur Verfügung steht (Fa. Koletzki?).

Gemeinde Zeuthen
Kita Kinderkiste
Zeuthen, 23.10.2023
Tilo besucht seit Dezember 2022 unsere Kindertageseinrichtung. Er startete - gemäß unseres
Konzeptes - in unserem altersgemischten Kitabereich. Als einer der ältesten Kinder konnte er sich gut in die alltäglichen Gruppenstrukturen finden. Im August diesen

Jahres wechselte er in unseren altershomogenen Vorschulbereich. Hier ist er mit derzeit 33 weiteren gleichaltrigen Kindern im letzten Kitajahr zusammen und wird täglich an die bevorstehenden und wachsenden Herausforderungen, die ihm mit dem Übergang in die Schule bevorstehen, gezielt herangeführt.
Gemäß den gesetzlichen Grundlagen, bekommt Tilo seit September 2023 zwei Einheiten individuelle pädagogische Frühförderung bei uns im Haus.
Tilo ist ein aufgeweckter, fröhlicher und äußerst hilfsbereiter Junge. Er besucht sehr regelmäßig die Kita, ist fest in die Kindergruppe integriert und hat diverse Spielpartner. Sein Spielverhalten ist altersentsprechend gut entwickelt. Tilo konstruiert gern in der Bauecke, liebt bewegte Spiele in Gemeinschaft und findet sich ebenso gut bei Regelspielen zurecht. Insgesamt hat er im Alltag ein sehr gutes Regelverständnis und hilft aktiv dieses aufrecht zu halten. Gern erinnert er seine Altersgenossen an die in Vergessenheit geratene Regeln. Er ist bemüht Konflikte selbstständig und verbal zu klären, gleichzeitig wendet er sich hilfesuchend an uns Erzieher, wenn er die Situation allein nicht friedlich klären kann.
Im Bereich der Feinmotorik, insbesondere bei der Stiftführung, dem Schneiden, beim Malen oder beim Einhalten von Begrenzungslinien hat Tilo große Fortschritte gemacht. Er begegnet Herausforderungen selbstsicherer und kompetent. Hin und wieder fordert er sich individuellen Zuspruch zur Motivation ein, was durchaus altersgerecht ist. Bei zeitlich umfangreicheren Angeboten ist die Muskulatur in seiner linken Hand erschöpft und er benötigt kleine Pausen zur
Entlastung•
Die viel größere Hürde stellt bei gestellten Anforderungen seine geringe Aufmerksamkeits- und Konzentrationsspanne dar. Tilo ist immer wieder sehr schnell abgelenkt und kann nur mit Unterstützung den Fokus auf die gestellte Aufgabe zurückgewinnen. Diese herausfordernde Aufgabe begegnet ihm im Alltag dauerhaft und bringt ihn ebenso oft an seine Grenzen.
Postanschrift:
Kita Kinderkiste
Dorfstraße 22a/23
15738 Zeuthen
Tel.: (033762)
92867
(033762) 886964
Fax.: (033762) 809597

Er ist sehr reizoffen und folgt impulsiv dem dominierenden Reiz. Die Kompetenz hier Prioritäten zu setzen bzw. eigenständig zur ursprünglichen Aufgabe zurück zu finden, hat er nicht.
Seine sprachlich - kommunikativen Fähigkeiten sind altersgerecht entwickelt. Insgesamt hat er eine große Sprechfreude, verfügt über einen einfachen Wortschatz und Satzbau. Unsicherheiten hat er hier noch beim Konjugieren der Verben - vorwiegend bei der Nutzung verschiedener Zeitformen.
Im Bereich der Grobmotorik neigt er dazu, sich im Gruppengeschehen zu überschätzen. Einfache Aufgaben am Boden bewältigt Tilo problemlos. Klettern ist ihm nur mit Hilfestellung durch einen Erwachsenen möglich. Aufgrund seiner körperlichen Einschränkung, bereiten ihm schwere Gegenstände oder Wettkampfspiele, Balancieren oder auch das Geräteturnen erhebliche

Schwierigkeiten.
Beeindruckend ist immer wieder sein ungeheuer großer Willen, Grenzen neu zu stecken. Stellt sich ihm im Alltag eine Hürde in den Weg, hat er inzwischen viele Strategien entwickelt, die ihn scheinbar ohne große Anstrengung, die Herausforderungen annehmen lassen. Er holt sich Hilfe, wenn er glaubt Unterstützung zu brauchen, auch wenn es „nur" Motivation und Zuspruch sein mögen.
kita erzieherin
kitaleitung